



Nuansa
Fajar
Cemerlang



IKAPI
IKATAN PERAWAT INDONESIA

ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN

Ida Farida, APPd., M.Kes.
Ns. Heni Kusumawati, MKep.
Dewi Purnamawati, M.Kep.
Ns. Rini Nurdini, M.Kep.
Nian Afrian Nuari, S.Kep, Ns, M.Kep
Ns. Elisabeth Wahyu Savitri, M.Kep.

ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN

**IDA FARIDA
HENI KUSUMAWATI
DEWI PURNAMAWATI
RINI NURDINI
NIAN AFRIAN NUARI
ELISABETH WAHYU SAFITRI**



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN

Penulis:

Ida Farida, APPd., M.Kes.
Ns. Heni Kusumawati, MKep.
Dewi Purnamawati, M.Kep.
Ns. Rini Nurdini, M.Kep.
Nian Afrian Nuari, S.Kep, Ns, M.Kep
Ns. Elisabeth Wahyu Savitri, M.Kep.

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Siti Hartina Fatimah
Achmad Faisal

ISBN: 978-623-09-2824-6

Cetakan Pertama:

Februari 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-NYA sehingga buku ajar asuhan keperawatan pada gangguan system pencernaan ini dapat diselesaikan.

Buku ajar asuhan keperawatan pada gangguan system pencernaan ini meliputi asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan akibat gastritis, hepatitis, appendiksitis, diare, Kolelitiasis dan ca kolorektal.

Buku ajar asuhan keperawatan pada gangguan system pencernaan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah bahan bacaan bagi mahasiswa diploma tiga keperawatan, sehingga dapat membantu menambah wawasan pengetahuan dalam keperawatan medical bedah, khususnya pada gangguan sistem pencernaan.

Selama proses penyusunan buku ajar ini, banyak pihak yang telah berkontribusi. Kami mendoakan semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Semoga kehadiran buku ajar ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan menjadi alternatif pilihan sumber pustaka bagi mahasiswa diploma tiga keperawatan

Tim Penulis

PRAKATA

Sungguh suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, diantara berbagai tugas rutin yang melimpah, kami dapat mempersembahkan buku ajar ini bagi mahasiswa keperawatan yang haus akan ilmu pengetahuan. Buku ini kami dedikasikan bagi mahasiswa keperawatan sebagai alternatif sumber pustaka untuk menambah wawasan pengetahuannya tentang keperawatan medikah bedah, khususnya asuhan keperawatan pada gangguan system pencernaan.

Banyak kasus gangguan system pencernaan yang dapat kita temui, namun pada buku ini yang dibahas adalah asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan akibat gastritis, hepatitis, appendiksitis, diare, Kolelitiasis dan ca kolorectal. Buku Ajar ini berisi tentang konsep dasar medik dan konsep keperawatan untuk setiap kasus yang dibahas. Konsep medik meliputi Definisi, Etiologi, Patofisiologi, Manifestasi Klinis, Komplikasi, Pemeriksaan Penunjang, dan Penatalaksanaan. Sedangkan konsep keperawatan terdiri dari Pengkajian, Diagnosis, Intervensi, Implementasi dan Evaluasi.

Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi semua.
Amiin...

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN GASTRITIS.....	1
ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN APPENDIKSITIS.....	19
ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DIARE.....	41
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN HEPATITIS.....	55
ASUHAN KEPERAWATAN PADA KOLELITIASIS	75
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN CARCINOMA COLORECTAL	98

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN GASTRITIS

Dewi Purnamawati, M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN GASTRITIS

PENULIS: DEWI PURNAMAWATI, M.Kep.

A. KONSEP DASAR MEDIK

1. Pendahuluan

Gastritis merupakan penyakit inflamasi pada membran mukosa lambung yang disebabkan oleh banyak faktor. Masyarakat awam mengenal penyakit gastritis dengan sebutan penyakit “maag”. Banyak orang yang menyepelekan penyakit ini karena dianggap tidak berbahaya. Padahal jika penyakit ini dibiarkan maka pasien akan sering mendapatkan gejala yang berulang dan dapat menyebabkan masalah atau komplikasi yang membutuhkan perawatan serius.

Gastritis merupakan salah satu masalah kesehatan di masyarakat dengan prevalensi yang cukup tinggi. Gastritis mempengaruhi hingga 50% orang dewasa di negara barat. Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2019 kejadian gastritis di dunia mencapai 1.8 juta hingga 2.1 juta penduduk setiap tahunnya (Nirmalarumsari & Tandipasang, 2020). Prevelensi awal penyakit gastritis di beberapa Negara di dunia diantaranya Inggris 22%, China 31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Perancis 29,5% (Shamsutdinov et al., 2021). Data di negara- negara maju seperti Amerika Serikat tercatat angka kematian akibat gastritis mencapai 8-10% setiap tahun dengan angka perbandingan 150 kasus per 1000 populasi. Insiden terjadinya gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya.

WHO, 2019 juga menyatakan bahwa persentase angka kejadian gastritis di Indonesia adalah 40,8% dan mencapai prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa penduduk di beberapa daerah Indonesia (Li et al., 2018). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 mencatat bahwa kasus gastritis termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak di Indonesia, yaitu pada pasien rawat inap di RS maupun di Puskesmas Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 30.154 (4,9%) (Tussakinah et al., 2018). Hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan angka kejadian gastritis di beberapa kota besar seperti Jakarta 50%, Bandung 32,5%, Surabaya 31,2 %, Medan 91,6% dan Denpasar 46%. Secara garis besar penyebab gastritis dibedakan atas faktor internal yaitu adanya kondisi yang memicu pengeluaran asam lambung yang berlebihan, dan faktor eksternal yang menyebabkan iritasi dan infeksi (Handayani & Thomy, 2018).

Menurut beberapa survei sebelumnya, menunjukkan bahwa usia produktif merupakan kelompok umur yang rentan mengalami kejadian

gastritis, karena tingkat kesibukan, stres, dan pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan (Tussakinah et al., 2018). Insiden gastritis dapat terjadi pada berbagai rentang usia baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gastritis lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki, dan lebih sering terjadi pada peminum alkohol berat, perokok, dan stress.

Gejala yang umum terjadi pada pasien yang mengalami gastritis adalah rasa tidak nyaman pada perut, perut kembung, sakit kepala dan mual yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, rasa tak nyaman di epigastrium, mual, muntah, Perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan, hilang selera makan, bersendawa, dan kembung. Dapat pula disertai demam, menggigil (kedinginan), cegukan (*hiccups*). Bila penyakit gastritis ini terus dibiarkan, akan berakibat semakin parah dan akhirnya asam lambung akan membuat luka-luka (ulkus) yang dikenal dengan tukak lambung. Bahkan bisa juga disertai muntah darah.

2. Definisi

Gastritis merupakan suatu keadaan inflamasi mukosa lambung yang dapat bersifat akut atau kronis (Black & Hawks, 2005). Gastritis merupakan peradangan dari mukosa lambung akibat iritasi dan infeksi, dimana lambung dapat mengalami kerusakan oleh proses peremasan apabila terjadi secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan lecet dan terjadinya luka yang mengakibatkan inflamasi (Bayti et al., 2021).

Gastritis dibagi menjadi 2, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Salah satu bentuk gastritis akut yang sering ditemui di klinik adalah gastritis akut erosive. Gastritis akut erosive merupakan suatu peradangan mukosa lambung akut dengan kerusakan erosive yang terjadi hanya pada mukosa.

Sedangkan gastritis kronik adalah suatu peradangan bagian permukaan mukosa lambung yang menahun/berkepanjangan yang disebabkan oleh ulkus lambung baik jinak maupun ganas atau disebabkan oleh bakteri *Helicobacter pylori* (Brunner & Suddarth, 2001).

3. Etiologi

Hasil penelitian literature review bahwa ada 9 faktor penyebab gastritis terdiri dari pola makan meliputi jenis makanan, frekuensi makan dan porsi makan, stres, konsumsi kopi, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, jenis kelamin dan usia (Suwindri & Ningrum, 2021).

Gastritis akut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

- a. Obat-obatan seperti NSAIDs (*Non steroid anti inflammatory drugs*), digitalis, obat kemoterapi, steroid, yang dapat mengiritasi mukosa lambung.

Hasil penelitian Mutia, dkk tahun 2022 menunjukkan bahwa pasien yang mengonsumsi OAINS (Obat anti inflamasi non steroid), berisiko sebesar 6,3 kali menderita gastritis dibanding tidak mengalami ketergantungan obat OAINS.

- b. Minum alkohol

- c. Makanan: konsumsi teh, kopi, parika, cengkeh, dapat menjadi faktor presipitasi gastritis akut. Makanan dengan tekstur kasar dan minuman temperatur tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan/iritasi mukosa.

Pola makan merupakan kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dan dapat mempengaruhi asupan gizi (Kadir, 2019). Gastritis dapat terjadi karena pola makan yang tidak teratur, seperti konsumsi berlebihan terhadap makanan yang dapat memicu naiknya asam lambung, misalnya makanan pedas, soda, alkohol, atau kopi. Akibatnya, individu tersebut mengalami kejadian iritasi lambung (tukak lambung atau gastritis) (Hadinata, 2021; Rizkiana & Tanuwijaya, 2021).

- d. Agen korosif seperti larutan alkali

- e. Penyakit tertentu dapat menyebabkan gastritis akut seperti uremia, shock, lesi sistem saraf pusat, sirosis hepatitis, hipertensi porta. Stres fisik yang disebabkan luka bakar, trauma, dan pembedahan juga dapat memicu gastritis.

- f. Infeksi bakteri seperti *H. Pylori*, *Staphylococcus*

- g. Stres/ketegangan emosional yang lama

Menurut Meivy et al. (2017), stres merupakan suatu fenomena universal yang dapat terjadi karena kebutuhan tubuh terganggu, sehingga berdampak pada dimensi kesehatan setiap individu seperti fisik, intelektual, emosional, dan sebagainya (Adam & Tomayahu, 2019). Kurangnya nafsu makan, perubahan pola tidur, penurunan produktivitas merupakan beberapa contoh yang dapat terjadi akibat stres (Tussakinah et al., 2018).

Stress yang berkepanjangan dapat menjadi pemicu utama munculnya gastritis karena dapat menyebabkan aliran darah ke mukosa dinding lambung berkurang sehingga terjadi peningkatan permeabilitas dinding lambung. Bila stress berlangsung secara terus menerus dan disertai gastritis akan menimbulkan banyak efek patofisiologis seperti aktivasi neuro-endokrin dan hormonal serta dapat mempercepat kecemasan dan gangguan afektif seperti depresi yang selanjutnya menyebabkan produksi radikal bebas berlebihan. Sedangkan efek utama dari stress ialah pada fisiologi usus meliputi mobilitas gastrointestinal, peningkatan persepsi

visceral, perubahan sekresi gastroentinal serta efek negative pada mikrobiota usus (Hardi, 2014).

4. Patofisiologi

Lapisan mukosa lambung dilindungi oleh asam lambung. Barrier mukosa tersusun dari prostaglandin. Jika barrier di penetrasi maka terjadi gastritis. Gastritis akut biasanya bersifat jinak, merupakan reaksi dari membrane mukosa lambung terhadap berbagai iritan lokal diantaranya endotoksin bakteri, kafein, alkohol dan aspirin. Organisme atau iritan akan menempel pada epitel lambung dan menghancurkan lapisan mukosa pelindung, meninggalkan daerah epitel yang gundul.

Perangsangan sel vagus yang berlebihan selama stress psikologis dapat menyebabkan pelepasan atau sekresi gastrin yang menyebabkan dari nukleus motorik dorsalis nervus vagus, setelah melewati nervus vagus menuju dinding lambung pada sistem saraf enterik, kemudian kelenjar-kelenjar gaster atau getah lambung, sehingga mukosa dalam antrum lambung mensekresikan hormon gastrin dan merangsang sel-sel parietal yang nantinya produksi asam hidroklorinnya berlebihan sehingga terjadi iritasi pada mukosa lambung (Guyton, 1997: 1021- 1022).

Obat-obatan, alkohol, garam empedu, atau enzim pankreas dapat merusak mukosa lambung, mengganggu barrier mukosa lambung dan memungkinkan difusi kembali asam dan pepsin ke dalam jaringan lambung. Maka terjadi iritasi dan peradangan pada mukosa lambung dan nekrosis yang dapat mengakibatkan perforasi dinding lambung dan perdarahan dan peritonitis (Long, 1996: 196).

Asam hidroklorida disekresi secara kontinyu sehingga sekresi meningkat karena mekanisma neurogenik dan hormonal yang dimulai oleh rangsangan lambung. Jika asam lambung atau hidroklorida tidak dinetralisasi atau mukosa melemah akibatnya tidak ada perlindungan, akhirnya asam hidroklorida dan pepsin akan merusak lambung, yang lama - kelamaan barrier mukosa lambung yaitu suplai darah, keseimbangan asam-basa, integritas sel mukosal dan regenerasi epitel. Bahan-bahan seperti aspirin, alkohol dan Anti Inflamasi Non Steroid dapat menurunkan produksi mukosa lambung.

Pada fase awal peradangan mukosa lambung akan merangsang ujung saraf yang terpajan yaitu saraf hipotalamus untuk mengeluarkan asam lambung. Kontak antara lesi dan asam juga merangsang mekanisme reflek lokal yang dimulai dengan kontraksi otot haluskitamya. Dan akhirnya terjadi nyeri yang biasanya dikeluhkan dengan adanya nyeri tumpul, tertusuk, terbakar di epigastrium tengah dan punggung.

Masukan minuman yang mengandung kafein, stimulan sistem saraf pusat parasimpatis dapat meningkatkan aktivitas otot lambung dan sekresi pepsin. Selain itu nikotin juga dapat mengurangi sekresi bikarbonat pankreas, karena menghambat netralisasi asam lambung dalam duodenum yang lama-kelamaan dapat menimbulkan mual dan muntah.

Peradangan akan menyebabkan terjadinya hiperemis atau peningkatan vaskularisasi, sehingga mukosa lambung berwarna merah dan menebal yang lama-kelamaan menyebabkan atropi gaster dan menipis, yang dapat berdampak pada gangguan sel *chief* dan sel *parietal* yang berfungsi untuk mensekresikan faktor intrinsik, akan tetapi karena adanya antibody maka faktor intrinsik tidak mampu untuk menyerap vitamin B12 dalam makanan, dan akan terjadi anemia perniciousa (Smeltzer, 2001: 1063 - 1066).

5. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis pasien gastritis akut biasanya terjadi ketidaknyamanan epigastrik, nyeri abdomen, kram, sakit kepala, refluks, mual, muntah, anoreksia, serta kadang-kadang terjadi hematemesis. Jika gastritis karena kontaminasi makanan maka dapat terjadi diare dalam 5 jam. Beberapa pasien tidak mengalami gejala/asimtomatik (Brunner & Suddarth, 2001).

Sedangkan pada gastritis kronis, pasien biasanya mengalami gejala anoreksia, nyeri ulu hati setelah makan, kembung, rasa asam di mulut atau mual dan muntah. Gejala ini biasanya terjadi pada gastritis kronis tipe B (disebabkan oleh *H. Pylori*). Sedangkan gastritis kronis tipe A secara khusus asimtomatis kecuali telah mengalami defisiensi vitamin B12 pasien akan mengalami anemia, lemah, pucat, nyeri, lidah merah, dan diare ringan (Brunner & Suddarth, 2001).

Hasil penelitian Ndruru et al. (2019) menyatakan 94% pasien gastritis keluhan utamanya nyeri ulu hati. Peradangan mukosa lambung akan menyebabkan respon mual, muntah dan anoreksia serta menimbulkan respon saraf lokal dari iritasi mukosa yang menyebabkan nyeri. Menurut (Schellack, Schellack, Van der Sandt, and Masuku, 2015) gastritis akan menyebabkan respon mual, muntah dan rasa penuh pada perut yang sering disebut dyspepsia. Respon ini akan menimbulkan anoreksia dan menyebabkan penurunan intake nutrisi sehingga berdampak terhadap masalah keperawatan defisit nutrisi.

6. Komplikasi

Komplikasi yang dapat terjadi pada gastritis kronis adalah perdarahan, anemia pernisiiosa, dan kanker lambung. Perdarahan terjadi ketika terjadi erosi lambung. Perdarahan bisa terjadi karena penggunaan alkohol, aspirin dan NSAIDs. Anemia pernisiiosa karena berkurangnya kemampuan lambung untuk mensekresi faktor intrinsik yang menyebabkan terjadinya malabsorpsi vitamin B12 yang dapat di konfirmasi dengan tes schillings. Kanker lambung diduga terjadi pada pasien gastritis yang tidak sembuh dengan terapi.

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membantu menegaskan diagnosis gastritis adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan darah

Pemeriksaan darah dilakukan untuk mengidentifikasi adanya *Helicobacter Pylori* dalam darah. Hasil positif menunjukkan bahwa pasien pernah kontak dengan bakteri namun hasil positif tidak menunjukkan pasien terinfeksi. Pemeriksaan juga untuk mengetahui adanya anemia akibat perdarahan lambung.

b. Uji nafas urea

Uji ini merupakan metode diagnostik berdasarkan prinsip bahwa urea diubah oleh urease H. Pylori dalam lambung menjadi amoniak dan karbondioksida. CO₂ cepat diabsorpsi melalui dinding lambung dan dapat terdeteksi dalam udara ekspirasi.

c. Pemeriksaan feses

Pemeriksaan feses untuk mengetahui apakah terdapat darah dan bakteri H. Pylori terdapat dalam feses. Hasil positif menunjukkan adanya infeksi.

d. Endoscopi saluran cerna bagian atas

Endoscopi saluran cerna bagian atas dilakukan untuk menentukan adanya ketidaknormalan pada saluran cerna bagian atas yang mungkin tidak tampak dengan rontgen. Endoscopi dilakukan dengan memasukkan selang kecil yang fleksibel melalui mulut, esofagus, lambung dan usus kecil bagian atas. Jika ditemukan hal yang mencurigakan dalam pemeriksaan, dilakukan biopsi. Waktu pemeriksaan sekitar 20 – 30 menit. Setelah endoscopy selesai pasien diobservasi selama sekitar 1 – 2 jam untuk melihat efek anestesi. Ketidaknyamanan pada tenggorokan akibat menelan endoskop menjadi hal yang penting di evaluasi.

e. Rontgen saluran cerna bagian atas

Rontgen dilakukan untuk melihat adanya tanda-tanda gastritis atau penyakit pencernaan lainnya. Sebelum rontgen pasien terlebih dahulu menelan

cairan barium. Cairan barium akan melapisi saluran cerna dan akan terlihat jelas ketika di rontgen.

8. Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan pasien gastritis adalah:

- a. Berikan diet tinggi kalori sesuai toleransi
- b. Berikan terapi antasida dan antibiotik
- c. Berikan agen penyekat kalsium, proardia, isordil
- d. Berikan analgetik jenis cair

B. Konsep Dasar Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proses keperawatan. Pengkajian meliputi anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa dilakukan untuk mengumpulkan riwayat keperawatan pasien sedangkan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan data obyektif terkait gejala yang dialami pasien. Ketika mengkaji pasien gastritis akut atau kronik, perhatikan diet, pola makan, penggunaan obat-obatan termasuk konsumsi alkohol dan rokok.

Anamnesa adalah terkait biodata seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan dan alamat. Riwayat pasien dikumpulkan dengan menanyakan tentang tanda dan gejala yang dirasakan, apakah pasien mengalami nyeri uluhati/epigastium, tidak selera makan (anoreksia), mual, atau muntah. Kapan gejala muncul, apakah sebelum atau setelah makan, adakah riwayat pasien mengkonsumsi makanan pedas, konsumsi alkohol, atau pasien telah mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Apakah pasien mengalami gejala setelah mengalami cemas, stres, alergi, makan minum terlalu banyak, makan terlalu cepat atau makan terlalu panas? Apakah yang dilakukan pasien untuk menghilangkan atau mengurangi gejala? Apakah pasien memiliki riwayat penyakit lambung sebelumnya atau memiliki riwayat pembedahan lambung? Bagaimana riwayat diet pasien dan jenis diet selama 72 jam terakhir? Riwayat ini akan membantu perawat untuk mengidentifikasi apakah kelebihan diet atau diet yang tidak sehat berhubungan dengan gejala yang dialami pasien saat ini. Penting juga dikaji apakah pasien mengalami muntah darah, apakah warna darah merah segar atau kehitaman?

Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan status generalis dan pemeriksaan *head to toes*. Pemeriksaan status generalis meliputi keadaan umum apakah pasien tampak sakit ringan/sedang/berat. Tanda vital menunjukkan suhu tubuh kadang meningkat, tekanan darah akan cenderung menurun. Pemeriksaan fisik

lainnya meliputi nyeri tekan abdomen, adanya dehidrasi (perubahan turgor kulit, membran mukosa kering).

Fokus Pengkajian Aktivitas sehari-hari:

1) Aktivitas / Istirahat

Gejala : kelemahan, kelelahan

Tanda : takikardia, takipnea / hiperventilasi (respons terhadap aktivitas)

2) Sirkulasi

Gejala : kelemahan, berkeringat

Tanda : - hipotensi (termasuk postural), takikardia, disritmia (hipovolemia / hipoksemia), nadi perifer lemah, pengisian kapiler lambat/perlahan (vasokonstriksi), warna kulit pucat, sianosis (tergantung pada jumlah kehilangan darah), kelemahan kulit / membran mukosa, berkeringat (menunjukkan status syok, nyeri akut, respons psikologik)

3) Integritas ego

Gejala : faktor stress akut atau kronis (keuangan, hubungan kerja), perasaan tak berdaya.

Tanda : tanda ansietas, misalnya gelisah, pucat, berkeringat, perhatian menyempit, gemetar, suara gemetar.

4) Eliminasi

Gejala : riwayat perawatan di rumah sakit sebelumnya karena perdarahan gastroenteritis (GE) atau masalah yang berhubungan dengan GE, misalnya luka peptik atau gaster, gastritis, bedah gaster, radiasi area gaster. Perubahan pola defekasi / karakteristik feses.

Tanda : - nyeri tekan abdomen, distensi, bunyi usus : sering hiperaktif selama perdarahan, hipoaktif setelah perdarahan. Karakteristik feses: diare, darah warna gelap, kecoklatan atau kadang-kadang merah cerah, berbusa, bau busuk (*steatorea*), konstipasi dapat terjadi (perubahan diet, penggunaan antasida). haluaran urine : menurun, pekat.

5) Makanan / Cairan

Gejala : - anoreksia, mual, muntah (muntah yang memanjang diduga obstruksi pilorik bagian luar sehubungan dengan luka duodenal). Masalah menelan : cegukan, nyeri ulu hati, sendawa bau asam, mual atau muntah.

Tanda : muntah dengan warna kopi gelap atau merah cerah, dengan atau tanpa bekuan darah, membran mukosa kering, penurunan produksi mukosa, turgor kulit buruk (perdarahan kronis).

6) Neurosensi

Gejala : rasa berdenyut, pusing / sakit kepala karena sinar, kelemahan.

Tanda : tingkat kesadaran dapat terganggu, rentang dari agak cenderung tidur, disorientasi / bingung, sampai pingsan dan koma (tergantung pada volume sirkulasi / oksigenasi).

7) Nyeri / Kenyamanan

Gejala : - nyeri, digambarkan sebagai tajam, dangkal, rasa terbakar, perih, nyeri hebat tiba-tiba dapat disertai perforasi. Rasa ketidaknyamanan / distress samar-samar setelah makan banyak dan hilang dengan makan (gastritis akut).

- nyeri epigastrium kiri sampai tengah / atau menyebar ke punggung terjadi 1-2 jam setelah makan dan hilang dengan antasida (ulkus gaster).
- nyeri epigastrium kiri sampai / atau menyebar ke punggung terjadi kurang lebih 4 jam setelah makan bila lambung kosong dan hilang dengan makanan atau antasida (ulkus duodenal).
- tak ada nyeri (varises esofeal atau gastritis).

Faktor pencetus : makanan, rokok, alkohol, pengguna obat-obatan tertentu (salisilat, reserpin, antibiotik, ibuprofen), stresor psikologis.

Tanda : wajah berkerut, berhati-hati pada area yang sakit, pucat, berkeringat, perhatian menyempit.

8) Keamanan

Gejala : alergi terhadap obat / sensitif misal : ASA

Tanda : peningkatan suhu, spider angioma, eritema palmar (menunjukkan sirosis / hipertensi portal)

9) Penyuluhan / Pembelajaran

Gejala : adanya penggunaan obat resep / dijual bebas yang mengandung ASA, alkohol, steroid. NSAID menyebabkan perdarahan GI. Keluhan saat ini dapat diterima karena (misal : anemia) atau diagnosa yang tak berhubungan (misal : trauma kepala), flu usus, atau episode muntah berat.

Masalah kesehatan yang lama misal : sirosis, alkoholisme, hepatitis, Gangguan makan (Gangguan Gastrointestinal)

2. Diagnosis

Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinik tentang respon individu, keluarga dan masyarakat tentang masalah Kesehatan atau proses kehidupan yang actual atau potensial, sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat (NANDA International, 2012).

Menurut PPNI (2016) Diagnosa Keperawatan pada kasus gastritis yaitu:

- a. Nyeri (akut) berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung.
- b. Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan output cair yang berlebih (mual dan muntah).
- c. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi tidak adekuat.
- d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik.

- e. Ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit.
- f. Kurang pengetahuan tentang penatalaksanaan diet dan proses penyakit.

3. Intervensi

Intervensi merupakan tahap ketiga dari proses keperawatan. Langkah pertama dalam tahap intervensi keperawatan adalah menentukan prioritas masalah keperawatan. Setelah prioritas ditetapkan dilanjutkan dengan merumuskan intervensi yang akan dilakukan berdasarkan diagnosa keperawatan yang muncul. Adapun intervensi keperawatan yang dapat dirumuskan pada pasien gastritis adalah sebagai berikut:

- a. Nyeri (akut) berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung.
 - 1) Mengkaji keluhan nyeri, lokasi nyeri, intensitas nyeri (0 – 10) dan faktor yang menghilangkan atau memperberat nyeri. Perhatikan respon non-verbal seperti melindungi otot, nafas dangkal, dan respon emosi
Rasional: mengetahui tingkat nyeri sehingga dapat diupayakan terapi farmakologis dan non farmakologi yang sesuai
 - 2) Puaskan pasien beberapa jam jika diperlukan
Rasional: mengurangi inflamasi mukosa
 - 3) Mengajarkan pasien untuk menurunkan tingkat nyeri dengan gosokan punggung, lingkungan yang tenang, ajarkan teknik relaksasi, dan penggunaan bimbingan imajinasi, serta dapat juga diberikan aktivitas diversional.
Rasional: teknik relaksasi dan distraksi dapat menurunkan tingkat nyeri
 - 4) Mengajarkan pasien tentang penyebab gastritis, makanan yang dapat memperburuk kondisi
Rasional: pengetahuan pasien meningkatkan Kerjasama pasien dalam mempercepat penyembuhan
 - 5) Membantu pasien mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan gejala seperti stres, kelelahan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu saat perut kosong, makanan dan minuman, konsumsi alkohol dan merokok.
Rasional: identifikasi faktor meningkatkan gejala meningkatkan pemahaman dan kemampuan pasien untuk mencegah munculnya gejala
 - 6) Mengajarkan pasien untuk menghindari semua faktor yang dapat memperburuk gejala.
Rasional: pengetahuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pasien untuk menghindari factor yang memperburuk gejala
 - 7) Jika mual dan muntah berat dialami pasien, pasien dapat dibatasi makan peroral sampai derajat mual dan muntah berkurang.

Rasional: mengurangi mual dan muntah

- 8) Menganjurkan untuk menjaga diet seimbang dan menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengiritasi.

Rasional: diet seimbang menurunkan risiko iritasi lambung

- b. Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan output cair yang berlebih (mual dan muntah)

- 1) Memantau dan mengukur Intake cairan setiap hari.

Rasional: intake adekuat mencegah dehidrasi.

- 2) Memantau tanda-tanda awal dehidrasi. Haluaran urine minimal 30 ml/jam, dan intake cairan minimal 1,5 ml/hari). Bila makanan dan minuman ditunda, biasanya cairan intravena diberikan minimal 3 l/hari.

Rasional: menunjukkan status dehidrasi dan peningkatan kebutuhan penggantian cairan.

- 3) Mengobservasi adanya indikasi perdarahan lambung seperti adanya hematemesis (muntah darah), takikardia dan hipotensi.

Rasional: muntah meningkatkan tekanan intra abdominal dan dapat mencetuskan perdarahan lanjut.

- 4) Mengbservasi tanda-tanda vital secara periodik, observasi turgor kulit, pengisian kapiler dan membrane mukosa.

Rasional: mengindikasikan status dehidrasi.

- 5) Lakukan tatalaksana terhadap adanya perdarahan lambung seperti menentukan dengan segera jumlah kehilangan darah, mengganti sel darah yang hilang, menghentikan perdarahan dengan air atau menggunakan normal salin, menstabilkan kondisi pasien, dan melakukan tindakan kolaboratif untuk mendiagnosa dan mengobati penyebab.

Rasional: mengganti kehilangan cairan yang hilang dan memperbaiki keseimbangan cairan.

- c. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi tidak adekuat.

- 1) Anjurkan pasien untuk makan sedikit demi sedikit dengan porsi kecil tapi sering.

Rasional: menjaga nutrisi tetap terpenuhi dan mencegah mual dan muntah

- 2) Berikan makanan yang lunak dan makan yang disukai pasien.

Rasional: mempermudah mengunyah makanan dan mengurangi mual

- 3) Lakukan oral hygiene 2 kali sehari.

Rasional: kebersihan mulut meningkatkan selera makan.

- 4) Timbang Berat badan pasien setiap hari dan pantau turgor kulit, mukosa bibir.
Rasional: mengetahui status nutrisi pasien.
 - 5) Konsultasikan dengan ahli gizi dalam pemberian diet pasien.
Rasional: pemberian diet yang tepat akan mempercepat pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien.
- d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik
- 1) Observasi sejauh mana pasien dapat melakukan aktivitas.
Rasional: mengetahui tingkat aktivitas yang dapat dilakukan pasien.
 - 2) Berikan lingkungan yang tenang.
Rasional: lingkungan yang tenang meningkatkan istirahat.
 - 3) Berikan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang tidak dapat dilakukan pasien secara mandiri, berikan reward atas upaya pasien.
Rasional: pemenuhan kebutuhan aktivitas pasien dan meningkatkan harga diri pasien karena dapat melakukan aktivitas secara mandiri secara bertahap.
 - 5) Jelaskan pentingnya mobilisasi/aktivitas bagi pasien secara periodik diselingi aktivitas istirahat.
Rasional: meningkatkan pemahaman pasien dan meningkatkan Kerjasama sehingga mempercepat pemulihan.
 - 6) Tingkatkan tirah baring atau duduk secara periodik sesuai indikasi.
Rasional: tirah baring meningkatkan pemulihan kondisi pasien.
- e. Ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit
- 1) Kaji tingkat kecemasan pasien.
Rasional: menentukan derajat kecemasan agar dapat disesuaikan tindakan yang akan diberikan
 - 2) Observasi respon fisiologi misalnya takpnea, palpitasi, pusing, sakit kepala, sensasi kesemutan.
Rasional: menjadi indicator derajat cemas dan bahan informasi kondisi fisik pasien.
 - 3) Jelaskan seluruh prosedur Tindakan yang dilakukan pada pasien sesuai tingkat pemahaman pasien.
Rasional: pengetahuan pasien tentang prosedur tindakan akan meningkatkan kerjasama pasien dalam perawatan.
 - 4) Dorong pernyataan takut atau ansietas, berikan umpan balik atas respon takut.
Rasional: meningkatkan hubungan terapeutik perawat pasien sehingga proses perawatan menjadi lebih cepat.

- 5) Berikan informasi yang akurat tentang penyakit pasien, jawab semua pertanyaan yang diajukan pasien selengkap mungkin.
Rasional: pelibatan pasien dalam rencana asuhan keperawatan dan pengetahuan pasien tentang penyakitnya akan menurunkan kecemasan yang dialami.
 - 6) Berikan lingkungan yang tenang untuk istirahat pasien.
Rasional: Memindahkan pasien dari stressor luar, meningkatkan relaksasi, meningkatkan ketrampilan coping.
 - 7) Dorang orang terdekat untuk tinggal/menemani pasien, jangan biarkan pasien sendiri.
Rasional: Membantu menurunkan cemas melalui pengalaman menakutkan saat sendiri.
 - 8) Ajarkan teknik relaksasi
Rasional: teknik relaksasi dapat membantu pasien dalam menurunkan ketegangan dan menurunkan cemas.
- f. Kurang pengetahuan tentang penatalaksanaan diet dan proses penyakit
- 1) Berikan persiapan pulang kepada pasien secara individual.
Rasional: meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga.
 - 2) Jelaskan tentang Diet berkolaborasi dengan ahli gizi. Diet disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kalori harian pasien, makanan yang disukai dan pola makan.
Rasional: Edukasi pasien tentang daftar makanan yang dihindari seperti kopi/kafein, nikotin, makanan berbumbu, makanan pedas, makanan yang mengiritasi atau makanan yang merangsang akan meningkatkan pemahaman pasien dan meningkatkan ketaatan terhadap diet.
 - 3) Siapkan resep obat sesuai order dan jelaskan penggunaannya kepada pasien. Pasien yang mengalami anemia pernisiiosa diberikan edukasi tentang kebutuhan terhadap vitamin B12 jangka panjang.
Rasional: edukasi tentang obat yang dikonsumsi seperti antibiotik, obat-obatan untuk menurunkan sekresi lambung, obat-obatan untuk melindungi sel-sel mukosa dari sekresi lambung sesuai dengan resep yang diberikan meningkatkan pemahaman pasien dan meningkatkan ketaatan terhadap pengobatan.
 - 4) Anjurkan pasien untuk melakukan kontrol secara rutin, terutama pada pasien yang didiagnosis gastritis yang terinfeksi H. Pilory atau gastritis atropik karena berhubungan dengan kanker gaster
 - 5) Rasional: Kontrol teratur akan memudahkan dalam mengevaluasi kemajuan pengobatan dan perawatan pasien dan mencegah terjadinya percepatan tingkat keparahan penyakit.

4. Implementasi

Implementasi merupakan tahap keempat proses keperawatan. Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari semua intervensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi merupakan tahap Ketika perawat mengaplikasikan atau melaksanakan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nursalam, 2001). Pada tahap pelaksanaan, perawat harus benar-benar siap untuk melaksanakan seluruh intervensi dan aktivitas keperawatan yang telah direncanakan. Perawat juga harus memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan tentang prosedur, keterampilan teknis dan etika dalam pelaksanaan tindakan.

5. Evaluasi

Hasil yang diharapkan pada asuhan keperawatan pasien gastritis adalah:

- a. Nyeri berkurang
- b. Gangguan keseimbangan cairan teratasi
- c. Gangguan nutrisi teratasi
- d. Keterbatasan aktivitas teratasi
- e. Ansietas menurun
- f. Pengetahuan meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., & Tomayahu, M. B. (2019). Tingkat Stres dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus. *Jambura Health and Sport Journal*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.37311/jhsj.v1i1.2047>
- Brunner & Suddart, (2002), Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, Vol. 2, Edisi 8, EGC, Jakarta
- Bayti, C. S., Indah, I., Jubaidah, J., Priani, N. K., & Jayanthi, S. (2021). Gambaran Pola Hidup Mahasiswa Perantauan terhadap Kejadian Gastritis di Universitas Samudra, Aceh. *Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 13(1), 43–47. <https://doi.org/10.24815/jbe.v13i1.21841>
- Doengoes, Marilyn, dkk. 2000. Rencana Asuhan Keperawatan; Pedoman untuk Perencanaan dan Pendokumentasian Perawatan Pasien. edisi 3. Jakarta: EGC
- Handayani, M., & Thomy, T. A. (2018). Hubungan Frekuensi, Jenis Dan Porsi Makan Dengan Kejadian Gastritis Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana (JKSP)*, 1(2), 40-46.

- Hirlan. 2001. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Edisi. 3 Jilid 2. Jakarta: FKUI Muttaqin, Arif & Sari, Kurmala. 2011. *Gangguan Gastrointestinal: Aplikasi Asuhan Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: Salemba Medika
- Hadinata, D. (2021). Hubungan Faktor Risiko dengan Kejadian Gastritis pada Pasien Berobat Jalan di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2018. *Jurnal Kampus STIKES YPIB Majalengka*, 8(1), 91–104. <https://doi.org/10.51997/jk.v8i1.111>
- Herlina J., Amanda A, Rayyani, Y. (2022). Determinan KEjadian Gastritis pada Mahasiswa. *Jambura Health and Sport Journal*, Vol. 4, No. 2 Agustus 2022 p-ISSN: 2654-718X, e-ISSN: 2656-2863, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jhsj/issue/view/862>. DOI : 10.37311/jhsj.v4i2.15171
- Kadir, S. (2019). Pola Makan dan Kejadian Hipertensi. *Jambura Health and Sport Journal*, 1(2), 56–60. <https://doi.org/10.37311/jhsj.v1i2.2469>
- Li, Y., Xia, R., Zhang, B., & Li, C. (2018). Chronic atrophic gastritis: a review. *Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology*, 37(3).
- Mutia, I. Asriati, Wa Ode. S., (2022). Analisis Faktor Risiko Gastritis Pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Bataraguru Kota Bau-bau. *Nursing Update: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*, Vol 13 (3), 123 – 128. <https://doi.org/10.36089/nu.v13i3>
- NANDA Intemasional. 2012. *Diagnosis Keperawatan*. Alih Bahasa: Made
- Ndruru, R. K., Sitorus, S., & Barus, N. (2019). Gambaran Diagnostik dan Penatalaksanaan Gastritis Rawat Inap BPJS di RSUD Royal Prima Medan Tahun 2017. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), 209-216.
- Nirmalarumsari, C., & Tandipasang, F. (2020). Faktor Risiko Kejadian Gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas Bantilang Tahun 2019. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 7(2), 196–202. <https://doi.org/10.26699/jnk.v7i2.ART.p196-202>
- Nursalam. 2001. *Proses dan Dokumentasi Keperawatan*. Jakarta: EGC
- PPNI, 2016. *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Price, Anderson, Sylvia. 2006. *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*, Alih bahasa brahm. Jakarta: EGC
- PPNI, 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta
- Smeltzer, S., Bare, P. G. 2001. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Edisi. 8 Jilid 2. Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta: EGC
- Suwindri, Y. T., & Ningrum, W. A. C. (2021). Faktor Penyebab Kejadian Gastritis Di Indonesia: Literature Review. *JKM: Jurnal Keperawatan Merdeka*, 1(2), 209-223.
- Shamsutdinov, A. S., Abdullaeva, U.K., & Akhmedova, N. S. (2021). Determination of the level of pepsinogens in patients with chronic h. pylori associated gastritis.

ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(2), 919–924.

Smeltzer, Suzanne C. 2001. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, Alih bahasa Agung Waluyo. Jakarta: EGC

Schellack, N., Schellack, G., Van der Sandt, N., & Masuku, B. (2015). Gastric pain. South African Family Practice, 57(5), 13-19.

Tussakinah, W., Masrul, M., & Burhan, I. R. (2018). Hubungan Pola Makan dan Tingkat Stres terhadap Kekambuhan Gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas Tarok Kota Payakumbuh Tahun 2017. Jurnal Kesehatan Andalas, 7(2), 217. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i2.805>

WHO. 2017. *Global Report On Gastritis*. France: World Health Organization.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN APPENDIKSITIS

Ns. Heni Kusumawati,M.Kep.



ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN APPENDIKSITIS

PENULIS: Ns.HENI KUSUMAWATI,M.Kep.

A. KONSEP DASAR MEDIK

1. Pendahuluan

Apendiksitis adalah proses peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing atau disebut *Apendiksitis*. Infeksi ini bisa terjadi apabila tidak segera mendapatkan tindakan bedah untuk *penanganannya*. *Apendiksitis* adalah penyebab utama inflamasi akut di kuadran kanan bawah abdomen. Meskipun dapat dialami oleh semua kelompok usia, *Apendiksitis* paling sering terjadi antara usia 10 dan 30 tahun (Awan, 2015 dalam David 2021). Angka kejadian apendiksitis terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu karena masyarakat tidak sadar akan pentingnya kesehatan, dengan mengkonsumsi makanan yang instan dan cepat saji maka peningkatan pada penderita *Apendiksitis* pun akan meningkat (Nuari).

Menurut *World Health Organization* (2018, dalam Wainsani dan Khoiriyah 2020), di Amerika Serikat *Apendiksitis* merupakan kedaruratan bedah abdomen yang paling sering dilakukan, dengan jumlah penderita pada tahun 2017 sebanyak 734.138 orang dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 739.177 orang. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan pertama sebagai angka kejadian *Apendiksitis* akut tertinggi dengan prevalensi 0.05%, diikuti oleh Filipina sebesar 0.022% dan Vietnam sebesar 0.02%.

Hasil survei pada tahun 2018 angka kejadian *Apendiksitis* di sebagian besar wilayah Indonesia, jumlah pasien yang menderita penyakit *Apendiksitis* berjumlah sekitar 7% dari jumlah penduduk di Indonesia atau sekitar 179.000 orang (Wainsani & Khoiriyah, 2020). Di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak pasien yang mengalami *Apendiksitis* tidak termasuk kedalam 10 penyakit terbesar.

Sedangkan di RSUD Dr Adjidarmo Rangkasbitung pada tahun 2021 pasien yang mengalami *Apendiksitis* yaitu sebanyak 208 orang dan menempati urutan pertama di ruang Jeruk. Distribusi Penyakit terbesar Di ruang Jeruk. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka kejadian *apendiksitis* masih cukup tinggi, dimana menduduki peringkat pertama tindakan pembedahan di Jeruk. Perawat sebagai tonggak utama dalam pemberi asuhan keperawatan mempunyai peranan yang penting dalam membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kejadian *appendiksitis*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurarif dan Kusuma (2015) pada kasus pasien dengan *Apendiksitis* dapat timbul berbagai masalah keperawatan baik itu masalah selama pre operasi, maupun post operasi. Masalah keperawatan yang mungkin muncul selama pre operasi diantaranya nyeri akut, hipertermi, gangguan rasa nyaman dan ansietas. Selama periode post operasi masalah keperawatan yang dapat timbul diantaranya nyeri akut, resiko infeksi, resiko kekurangan volume cairan dan kurang pengetahuan tentang kondisi, prognosis dan kebutuhan pengobatan. Apendiksitis yang tidak segera ditatalaksana akan menimbulkan komplikasi. Salah satu komplikasi yang paling membahayakan adalah perforasi. Perforasi terjadi 24 jam setelah timbul nyeri. Gejalanya mencakup demam dengan suhu 37,7°C atau lebih tinggi, dan nyeri abdomen atau nyeri tekan abdomen yang kontinyu (Radwan, 2013 dalam Erwin, 2020).

Rangkasbitung Tahun 2021

NO	Jenis Penyakit	Jumlah	Prosentase
1	<i>Apendiksitis</i>	208	20,55
2	Cidera Kepala	152	15,01
3	Hernaia <i>Inguinalis</i>	146	14,42
4	<i>Benigna Prostat Hiperplasia</i>	119	11,75
5	Snake Bite	100	9,88
6	Fraktur	75	7,41
7	Ulcus/ Ganggren	74	7,31
8	<i>Soft Tissue Tumor</i>	66	6,52
9	Tonsil	37	3,65
10	Abses	35	3,45
Jumlah		1.012	100%

Sumber: *Medical Record* RSUD Dr. Adjidarmo, (2022).

Cara mengatasi semua masalah yang muncul pada pasien *Apendiksitis* dalam hal ini perlu dilakukan tindakan bedah apendektomi sebagai terapi *Apendiksitis*. Apendektomi merupakan satu-satunya tindakan bedah abdomen akut yang paling banyak dilakukan di dunia. (Flum, 2002 dalam zulfikar 2015). Pada Pasien yang dilakukan tindakan pembedahan akan menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah resiko infeksi. Luka operasi bila tidak diberikan penanganan dengan benar akan memperburuk kondisi pasien yaitu akan menimbulkan nyeri hebat akibat infeksi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa *Apendiksitis* masih menjadi suatu permasalahan bagi perawat untuk menekan kasus tersebut, maka

dari itu perawat hendaknya mampu memberikan asuhan keperawatan dengan baik, yang komperhensif dan memandang pasien dengan bio-psiko - sosial dan spiritual. Upaya perawat dalam membantu menurunkan angka kejadian dan pencegahan pasien appendiksitis baik sebelum maupun sesudah operasi dapat dilakukan melalui upaya promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif.

Upaya promotif dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan masyarakat mengenai penyakit appendiksitis yang meliputi: pengertian, tanda dan gejala, penyebab, komplikasi dan penanganannya. Upaya preventif dapat dilakukan dengan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan *apendiksitis* yaitu dengan menjaga kebersihan makanan dan makan-makanan tinggi serat. Upaya kurative dapat dilakukan dengan melakukan perawatan luka pada pasien yang telah dilakukan operasi agar tidak terjadi infeksi dan memberikan perawatan dengan mengurangi nyeri. upaya rehabilitatif dapat dilakukan dengan cara tetap menjaga pola makan, makan makanan tinggi serat, makan TKT dan melakukan perawatan luka, menjaga luka tetap bersih dan kering.

2. Definisi

"Apendiksitis adalah penyebab utama inflamasi akut di kuadran kanan bawah abdomen. Meskipun dapat dialami oleh semua kelompok usia, *Apendiksitis* paling sering terjadi antara usia 10 dan 30 tahun (Awan Hariyanto dan Rini Sulistyowati, 2015 dalam david 2021)"

"Apendiksitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu (*Apendiksitis*). Infeksi yang terjadi dapat mengakibatkan pernanahan. Bila infeksi bertambah parah, usus buntu itu bisa pecah. Usus buntu merupakan saluran usus yang ujungnya buntu dan menonjol dari bagian awal usus besar atau sekum (cecum). Usus buntu besarnya sekitar kelingking (Setyaningrum, 2013)"

"Apendiksitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing yang disebabkan oleh adanya makanan keras yang masuk ke dalam usus buntu dan tidak bisa keluar lagi sehingga menyebabkan perkembangan kuman-kuman yang memperparah keadaan (Saydam, 2011 dalam Ambros, 2021)".

Jadi dapat disimpulkan *Apendiksitis* adalah peradangan yang terjadi pada pasien akibat terjadinya infeksi, dan Juga usus buntu itu menambah parah dan tidak diobati maka usus bisa pecah dan usus buntu ini bisa dialami oleh setiap usia.

3. Klasifikasi Apendiksitis

Menurut Nian 2015 klasifikasi pada pasien yang mengalami *Apendiksitis* yaitu:

- 1) *Apendiksitis* akut
 - a) *Apendiksitis* fokal atau segmentalis yaitu setelah pasien mengalami kesembuhan akan mengalami striktur total
 - b) *Apendiksitis* purlulenta difusi yaitu sudah terjadinya penumpukan nanah

2) *Apendiksitis kronis*

- a) Apendiksitis kronis fokal atau parsial setelah sembuh akan mengalami struktur lokal
- b) *Apendiksitis kronis obliterativa*; yaitu Apendiksitis miring biasanya kasus seperti ini di temukan pada pasien yang sudah tua.

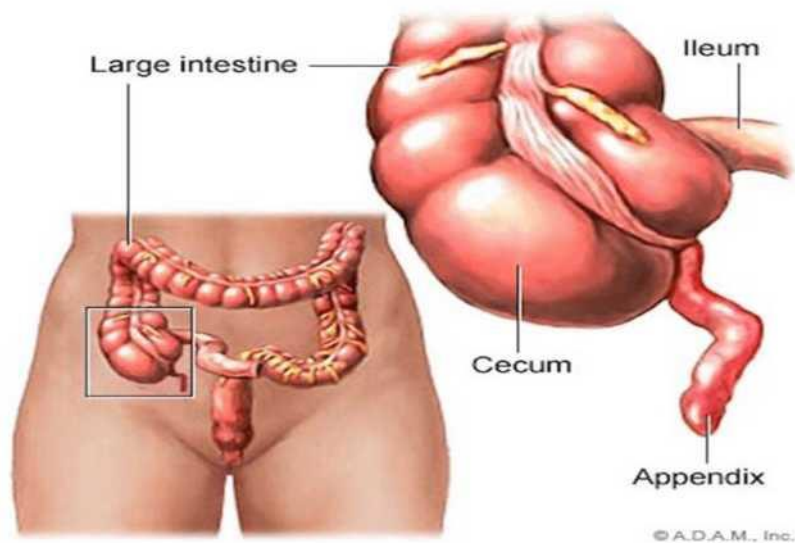
4. Anatomi Fisiologi

Appendiks vermiformis atau yang sering disebut sebagai Apendik adalah organ berbentuk tabung dan sempit yang mempunyai otot dan banyak mengandung jaringan limfoid. Panjang Apendik *vermiformis* bervariasi dari 3-5 inci (8-13 cm). Dasarnya melekat pada permukaan aspek posteromedial caecum; 2,5cm dibawah junctura iliocaecal dengan lainnya bebas. Lumennya melebar di bagian distal dan menyempit di bagian proksimal (S. H. Sibuea, 2018 dalam David 2021).

Appendik *vermiformis* terletak pada kuadran kanan bawah abdomen di region *iliaca dextra*. Pangkalnya diproyeksikan ke dinding *anterior* abdomen pada titik sepertiga bawah yang menghubungkan spina *iliaca anterior superior* dan *umbilicus* yang disebut titik McBurney (Siti, 2018 dalam David 2021). Pada Apendik Posisi yang normal adalah Apendik yang terletak pada dinding abdomen di bawah titik *Mc. Burney*. Untuk menentukan titik *Mc Burney* caranya adalah dengan menarik garis semu dari umbilikal kanan ke *anterior superior iliac* spina kanan dan 2/3 dari garis tersebut merupakan titik Mc Burney. b. Fisiologi Appendiks Secara fisiologis, Apendik menghasilkan lendir 1 - 2 ml per hari.

Lendir normalnya dicurahkan ke dalam lumen dan selanjutnya mengalirkan ke sekum. Hambatan aliran lendir di muara *Apendiksitis* berperan pada patogenesis Apendik.

Immunoglobulin sekreator yang dihasilkan oleh GALT (*Gut Associated Lymphoid Tissue*) yang terdapat di sepanjang saluran pencernaan termasuk Apendik ialah IgA. Immunoglobulin tersebut sangat efektif sebagai perlindungan terhadap infeksi. Namun demikian, pengangkatan Apendiksitis tidak mempengaruhi sistem imun tubuh karena jumlah jaringan limfa disini kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlahnya disaluran cerna dan diseluruh tubuh (Arifin, 2015).



Gamabar 1 Anatomi Usus
(Arifin, 2015)

5. Etiologi

Apendikisitis akut merupakan infeksi bakteri. Berbagai hal berperan sebagai faktor pencetusnya. Sumbatan lumen *Apendiksitis* merupakan faktor yang diajukan sebagai faktor pencetus disamping hiperplasia jaringan limfe, fekalit, tumor *Apendikitis*, dan cacing askaris dapat pula menyebabkan sumbatan. Penyebab lain yang diduga dapat menimbulkan *Appendik* adalah erosi mukosa *Apendiksitis* karena parasit seperti *E. histolytica* (Jong, 2010 dalam Erwin, 2020).

6. Manifestasi klinis

Menurut Mardalena dalam Handaya (2017), beberapa manifestasi klinis yang sering muncul pada *Apendiksitis* antara lain sebagai berikut:

- 1) Nyeri samar (nyeri tumpul) di daerah epigastrium disekitar umbilikus atau *periumbilikus*. Kemudian dalam beberapa jam, nyeri beralih kekuadran kanan bawah ke titik *Mc Burney* (terletak diantara pertengahan umbilikus dan spina anterior ileum) nyeri terasa lebih tajam.
- 2) Bisa disertai nyeri seluruh perut apabila sudah terjadi peritonitis karena kebocoran *Apendiksitis* dan meluasnya pernanahan dalam rongga abdomen.
- 3) Mual, muntah, nafsu makan menurun, konstipasi, demam.

7. Patofisiologi

Appendicitis terjadi karena penyumbatan lumen *Apendiksitis* oleh *hyperplasia folikel limfoid*, fekalit, benda asing, striktur karena *fibrosis* akibat peradangan sebelumnya, atau *neoplasma*. Obstruksi tersebut menyebabkan *mucus* yang diproduksi mukosa mengalami bendungan. Makin lama mucus tersumbat

makin banyak, namun elastisitas dinding *Apendiksitis* mempunyai keterbatasan sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intralumen. Tekanan yang meningkat tersebut akan menghambat aliran limfe yang mengakibatkan edema, diapedesis bakteri, dan ulserasi mukosa. Pada saat inilah terjadi *Apendiksitis* akut fokal yang ditandai oleh nyeri epigastrium.

Bila sekresi mucus terus berlanjut, tekanan akan terus meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan obstruksi vena, edema bertambah, dan bakteri akan menembus dinding. Peradangan yang timbul meluas dan mengenai peritoneum setempat sehingga menimbulkan nyeri di daerah kanan bawah. Keadaan ini disebut *appendicitis supuratif* akut. Bila kemudian aliran arteri terganggu akan terjadi infark dinding appendiks yang lebih panjang dan dinding *Apendiksitis* lebih tipis.

Keadaan tersebut ditambah dengan daya tahan tubuh yang masih kurang memudahkan terjadinya perforasi. Sedangkan pada orang tua perforasi mudah terjadi karena telah ada gangguan pembuluh darah. Diikuti dengan gangren. Stadium ini disebut dengan *appendicitis gangrenosa*. Bila dinding yang telah rapuh ini pecah, akan terjadi *appendicitis perforasi* (Wedjo, 2019).

Apendiksitis terinflamasi dan mengalami edema sebagai akibat terlipat atau tersumbat kemungkinan oleh fekolit (massa keras dari faeces) atau benda asing. Proses inflamasi meningkatkan tekanan intraluminal, menimbulkan nyeri abdomen atas atau menyebar hebat secara progresif, dalam beberapa jam terlokalisasi dalam kuadran kanan bawah dari abdomen. Akhirnya *Apendiksitis* yang terinflamasi berisi pus

Apendektomi biasanya disebabkan adanya penyumbatan lumen *Apendiksitis* yang dapat diakibatkan oleh *fekalit* atau *Apendiksitis olit*, *hiperplasia limfoid*, benda asing, parasit, mioplasma atau striktur karena *fibrosis* akibat peradangan sebelumnya. Obstruksi lumen yang terjadi mendukung perkembangan bakteri dan sekresi mukus sehingga menyebabkan distensi lumen dan peningkatan tekanan dinding lumen. Setelah *Apendiksitis*omy dilakukan mengakibatkan kerusakan jaringan dan terjadinya ujung saraf terputus menimbulkan masalah perawatan kerusakan integritas kulit (Hanifah, 2019).

8. Pemeriksaan Penunjang

Menurut Nurarif, (2015) pemeriksaan penunjang pada pasien dengan *Apendiksitis* meliputi:

1) Pemeriksaan Fisik

- a) Inspeksi : akan tampak adanya pembengkakan (*swelling*) rongga perut dimana dinding perut tampak mengencang (*distensi*).
- b) Palpasi: didaerah perut kanan bawah bila ditekan akan terasa nyeri dan bila tekanan dilepas juga akan terasa nyeri (*Blumberg sign*) yang mana merupakan kunci dari diagnosis *Apendiksitis* akut.

- c) Tindakan tungkai bawah kanan dan paha diteku kuat atau tungkai di angkat tinggi-tinggi, maka rasa nyeri di perut semakin parah (*proas sign*).
 - d) Kecurigaan adanya peradangan usus buntu semakin bertambah bila pemeriksaan dubur dan atau vagina menimbulkan rasa nyeri juga.
 - e) Suhu dubur yang lebih tinggi dari suhu ketiak, lebih menunjang lagi adanya radang usus buntu.
 - f) Pada Apendiksitis terletak pada retro sekal maka uji psoas akan positif dan tanda perangsangan peritoneum akan lebih menonjol.
- 2) Pemeriksaan Laboratorium Kenaikan dari sel darah putih (leukosit) hingga 10.000- 18.000/mm³. Jika peningkatan lebih dari itu, maka kemungkinan *Apendiksitis* sudah mengalami perforasi (pecah).
- 3) Pemeriksaan Radiologi
- a) Foto polos perut dapat memperlihatkan adanya *fekalit*
 - b) *Ultrasonografi* (USG)
 - c) CT Scan
 - d) Kausu kronik dapat dilakukan rontgen foto abdomen, USG abdomen dan *Apendiksitis ogram*.

9. Penatalaksanaan

Menurut Saputro (2018), penatalaksanaan pada yang dilakukan pada klien *Apendiksitis* yaitu penatalaksanaan medis dan penatalaksanaan keperawatan:

- 1) Penatalaksanaan Medis
 - a) Pembedahan (konvensional atau laparaskopi) apabila diagnose *Apendiksitis* telah ditegakan dan harus segera dilakukan untuk mengurangi risiko perforasi.
 - b) Berikan obat antibiotik dan cairan IV sampai tindakan pembedahan dilakukan.
 - c) Agen analgesik dapat diberikan setelah diagnosa ditegakan.
 - d) Operasi (*Apendiksistomi*), bila diagnosa telah ditegakan yang harus dilakukan adalah operasi membuang *Apendiksitis* (*Apendiksistomi*). Penundaan *Apendiksitis* tomi dengan cara pemberian antibiotik dapat mengakibatkan abses dan perforasi. Pada abses *Apendiksitis* dilakukan *drainage*.
- 2) Penatalaksanaan Keperawatan
 - a) Tata laksana *Apendiksitis* pada kebanyakan kasus adalah *Apendiksistomi*. Keterlambatan dalam tata laksana dapat meningkatkan kejadian perforasi. Teknik laparaskopi sudah terbukti menghasilkan nyeri pasca bedah yang lebih sedikit, pemulihan yang lebih cepat dan angka kejadian infeksi luka yang lebih rendah. Akan tetapi terdapat peningkatan kejadian abses intra abdomen dan pemanjangan waktu operasi. Laparaskopi itu dikerjakan

untuk diagnosa dan terapi pada pasien dengan akut abdomen, terutama pada wanita

- b) Tujuan keperawatan mencakup upaya meredakan nyeri, mencegah defisit volume cairan, mengatasi ansietas, mengurangi risiko infeksi yang disebabkan oleh gangguan potensial atau aktual pada saluran gastrointestinal, mempertahankan integritas kulit dan mencapai nutrisi yang optimal.
- c) Sebelum operasi, siapkan pasien untuk menjalani pembedahan, mulai jalur Intra Vena berikan antibiotik, dan masukan selang nasogastrik (bila terbukti ada ileus paralitik), jangan berikan laksatif.
- d) Setelah operasi, posisikan pasien fowler tinggi, berikan analgetik narkotik sesuai program, berikan cairan oral apabila dapat ditoleransi, dan lakukan perawatan luka.
- e) Jika drain terpasang di area insisi, pantau secara ketat adanya tanda - tanda obstruksi usus halus, hemoragi sekunder atau abses sekunder. Jadi berdasarkan pembahasan diatas, tindakan yang dapat dilakukan terbagi dua yaitu tindakan medis yang mengacu pada tindakan pembedahan/apendectomy dan pemberian analgetik, dan tindakan keperawatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan klien sesuai dengan kebutuhan klien untuk menunjang proses pemulihan.

10. Komplikasi

Komplikasi menurut (Brunner dan Suddarth, 2014) yaitu:

- 1) Komplikasi utama adalah perforasi *Apendiksitis* yang dapat menyebabkan peritonitis pembentukan abses (tertampungnya materi purulen), atau flebilitis portal.
- 2) Perforasi biasanya terjadi setelah 24 jam setelah awitan nyeri. Gejala yang muncul antara lain: Demam 37,70C, nyeri tekan atau nyeri abdomen.

Menurut Saputro (2018), komplikasi dapat terjadi apabila terjadi keterlambatan penanganan seperti:

1) Abses

Abses merupakan peradangan *apendiksitis* yang berisi pus. Teraba massa lunak di kuadran kanan bawah atau daerah pelvis. Massa ini mula-mula berupa *flegmon* dan berkembang menjadi rongga yang mengandung pus. Hal ini terjadi bila *Apendiksitis* gangren atau *mikroperforasi* ditutupi oleh omentum.

2) Perforasi

Perforasi adalah pecahnya appendix yang berisi pus sehingga bakteri menyebar ke rongga perut. Perforasi jarang terjadi dalam 12 jam pertama sejak awal sakit, tetapi meningkat tajam sesudah 24 jam. Perforasi dapat diketahui

praoperatif pada 70% kasus dengan gambaran klinis yang timbul lebih dari 36 jam sejak sakit, panas lebih dari 38,50C, tampak toksik, nyeri tekan seluruh perut, dan leukositosis terutama polymorphonuclear (PMN).

Perforasi, baik berupa perforasi bebas maupun mikroperforasi dapat menyebabkan peritonitis.

3) Peritonitis

Peritonitis adalah peradangan peritoneum, merupakan komplikasi berbahaya yang dapat terjadi dalam bentuk akut maupun kronis. Bila infeksi tersebar luas pada permukaan peritoneum menyebabkan timbulnya peritonitis umum. Aktivitas peristaltik berkurang sampai timbul ileus paralitik, usus meregang, dan hilangnya cairan elektrolit mengakibatkan dehidrasi, syok, gangguan sirkulasi, dan oligouria. Peritonitis disertai rasa sakit perut yang semakin hebat, muntah, nyeri abdomen, demam, dan leukositosis.

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian adalah pemikiran tentang penjelasan dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, untuk mengidentifikasi, mengenali masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan baik fisik, mental, sosial dan lingkungan (Effendy, 1995 dalam Deden, 2012).

Pengkajian pada pasien yang mengalami *Apendiksitis* menurut David, (2021) yaitu:

1) Identitas pasien

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, status perkawinan, suku bangsa, nomor register, tanggal masuk rumah sakit dan diagnosa medis.

2) Riwayat penyakit

a) Keluhan utama

Nyeri dibagian perut kanan bawah.

b) Riwayat kesehatan sekarang

Klien mengatakan nyeri pada daerah abdomen kanan bawah yang menembus kebelakang sampai pada punggung dan mengalami demam tinggi

c) Riwayat kesehatan dahulu Apakah klien pernah mengalami operasi sebelumnya padacolon.

d) Riwayat kesehatan keluarga

Apakah anggota keluarga ada yang mengalami jenis penyakit yang sama.

3) Pemeriksaan fisik

a) Status kesehatan umum

Kesadaran composmentis, wajah tampak menyeringai, konjungtiva anemis.

b) Sistem pernapasan

Frekuensi nafas normal (16-20x/menit), dada simetris, ada tidaknya sumbatan jalan nafas, tidak ada gerakan cuping hidung, tidak terpasang O₂, tidak ada ronchi, wheezing, stridor

c) Sistem kardiovaskular

Ada distensi vena jugularis, pucat, edema, TD >110/70mmHg;

d) Sistem pencernaan

Terdapat nyeri lepas, peristaltik pada usus ditandai dengan distensi abdomen.

Inspeksi: Terdapat luka bekas operasi tertutup kasa, bentuk dan ukuran luka, terlihat mengencang (distensi).

Auskultasi: Bising usus menurun

Palpasi: Terdapat nyeri tekan pada abdomen bekas operasi

Perkusi: Kaji suara apakah timpani atau hipertimpani

e) Sistem penglihatan

Terdapat permasalahan penglihatan

f) Sistem perkemihan

Poliuri, retensio urin, inkontinensia urin, rasa panas atau sakit saat berkemih.

g) Sistem musculoskeletal

Ada kesulitan dalam pergerakan karena proses perjalanan penyakit.

h) Sistem integument

Terdapat oedema, turgor kulit menurun, sianosis, pucat.

4) Pola Kebiasaan Sehari-hari

a) Pola Makan dan Minum

Klien biasanya akan mengalami gangguan pemenuhan nutrisi akibat pembatasan intake makanan atau minuman sampai peristaltik usus kembali normal

b) Pola Istirahat dan Tidur

Insisi pembedahan dapat menimbulkan nyeri yang sangat sehingga dapat mengganggu kenyamanan pola tidur klien

c) Personal Hygiene

Pasien dengan Apendiksitis post operasi, pasti akan terganggu masalah personal hygiene

d) Pola Eliminasi BAK dan BAB

Pada pola eliminasi urine akibat penurunan daya kontraksi kandung

kemih, rasa nyeri atau karena tidak biasa BAK ditempat tidur akan mempengaruhi pola eliminasi urine. Pola eliminasi alvi akan mengalami gangguan yang sifatnya sementara karena pengaruh anastesi sehingga terjadi penurunan fungsi.

e) Pola aktivitas

Aktivitas dipengaruhi oleh keadaan dan malas bergerak karena rasa nyeri, aktivitas biasanya terbatas karena harus bedrest berapa waktu lamanya setelah pembedahan.

C. Diagnosa keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial (PPNI, 2017).

Berdasarkan pada semua data pengkajian diagnosa keperawatan utama yang dapat muncul pada appendicitis, antara lain:

1) Diagnosa Keperawatan Pre Operasi

- a) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi (inflamasi appendicitis).
- b) Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit (Infeksi pada appendicitis).
- c) Risikom Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif (muntah).
- d) Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan.

2) Diagnosa Keperawatan Post Operasi

- a) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (Prosedur operasi).
- b) Risiko Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif (muntah).
- c) Resiko Infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasive.
- d) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri.

D. Intervensi Keperawatan

Perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan adalah perumusan tujuan, tindakan dan penilaian rangkaian asuhan keperawatan pada klien berdasarkan analisa pengkajian agar masalah kesehatan dan keperawatan klien dapat diatasi (Nurarif, 2016). Menurut PPNI, (2018), intervensi keperawatan pada pasien dengan pre operasi *appendicistis* dan intervensi keperawatan pasien dengan post operasi Apendiksitis

Tabel 2 Intervensi Pre Operasi

No	Diagnosa	Tujuan dan kriteria hasil	Intervensi keperawatan
1	Nyeri akut berhubungan dengan agen Manajemen pencedera fisiologi (inflamasi appendicitis). 1) Definisi Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. 2) Penyebab Agen pencedera fisiologis (misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma) 3) Batasan karakteristik a) Data mayor (1) Data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnosa nyeri akut antara lain: (a) Subjektif Mengeluh Nyeri (b) Objektif (1) Tampak meringis (2) Bersikap protektif (3) Gelisah Frekuensi nadi meningkat 5. b) Data Minor Data minor yang dapat menunjang munculnya diagnose nyeri akut antara lain (1) Subjektif : (2) Objektif : • Tekanan darah meningkat • Pola nafas berubah • Nafsu makan berubah • Proses berfikir terganggu • Menarik diri • Berfokus pada diri sendiri • Diaforesis 4) Kondisi Klinis Terkait a) Infeksi	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat nyeri dapat menurun dengan Kriteria Hasil: 1) Keluhan nyeri menurun 2) Meringis menurun 3) Sikap protektif menurun 4) Gelisah menurun 5) Kesulitan tidur menurun 6) Menarik diri menurun 7) Berfokus pada diri sendiri menurun 8) Diaforesis menurun 9) Perasaan depresi (tertekan) menurun 10) Perasaan takut mengalami cedera berulang menurun 11) Anoreksia menurun 12) Perineum terasa tertekan 13) Uterus teraba membulat menurun 14) Ketegangan otot menurun 15) Pupil dilatasi menurun 16) Muntah menurun 17) Mual menurun 18) Frekuensi nadi membaik 19) Pola nafas membaik 20) Tekanan darah membaik 21) Proses berfikir membaik 22) Fungsi berkemih membaik 23) Perilaku membaik 24) Nafsu makan membaik 25) Pola tidur membaik	Manajemen Nyeri 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2) Identifikasi skala nyeri 3) Identifikasi respons nyeri non verbal 4) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri 7) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 8) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 9) Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri kontrol b) lingkungan yang memperberat rasa nyeri fasilitasi istirahat dan tidur c) pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi a) jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri b) jelaskan strategi meredakan nyeri c) anjurkan memonitor nyeri secara mandiri d) anjurkan menggunakan analgetik secara tepat e) ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Kolaborasi Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

2	Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit (Infeksi pada appendicitis). 1) Definisi Suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh 2) Penyebab Proses penyakit (misalnya infeksi, kanker) 3) Batasan karakteristik a. Data mayor Data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnose hipertermi antara lain: a) Subjektif b) Objektif: Suhu tubuh di atas normal b. Data minor Data minor yang dapat menunjang munculnya diagnose hipertermi antara lain a) Subjektif b) Objektif 1) Kulit merah 2) Takikardi 3) Kulit terasa hangat 4) Kondisi klinis terkait a) Proses infeksi	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama Pasien menyatakan suhu tubuh pasien membaik dengan kriteria hasil: 1) Suhu tubuh membaik 2) Suhu kulit membaik 3) Kadar glukosa darah membaik 4) Pengisian kapiler membaik 5) Ventilasi membaik 6) Tekanan darah membaik	Manajemen Hipertermi Observasi: a) Identifikasi penyebab hipertermia b) Monitor suhu tubuh c) Monitor kadar elektrolit d) Monitor haluan urine e) Monitor komplikasi akibat hipertermia Terapeutik: a) Sediakan lingkungan yang dingin b) Basahi dan kipasi permukaan tubuh c) Berikan cairan oral d) Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika terjadi hyperhidrosis e) Hindari pemberian antipiretik dan aspirin f) Berikan oksigen Edukasi: a) Anjurkan tirah baring Kolaborasi: a) Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena
---	--	---	--

3	Risiko Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif (muntah). a) Definisi Berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh, yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa b) Faktor resiko Kekurangan volume cairan 1) Kondisi klinis terkait Perdarahan	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama Pasien mengatakan sudah tidak mengalami syok dengan kriteria hasil: a) Kekuatan nadi meningkat b) Output urinei meningkat c) Tingkat kesadaran meningkat d) Saturasi oksigen meningkat e) Akral dingin menurun f. Pucat menurun f) Haus menurun g) Tekanan darah sistolik membaik h) Tekanan darah diastolic membaik i) Tekanan nadi membaik j) Frekuensi nafas membaik	Observasi: a) Monitor status kardiopulmonal b) Monitor status oksigenasi c) Monitor status cairan d) Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil e) Periksa riwayat alergi Terapeutik: a) Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen b) Persiapan intubasi dan ventilasi mekanis, jika perlu c) Pasang jalur IV, jika perlu d) Pasang kateter urine untuk menilai produksi urine, jika perlu e) Lakukan skin test untuk mencegah reaksi alergi Edukasi: a) Jelaskan penyebab atau faktor risiko syok b) Jelaskan tanda dan gejala awal syok c) Anjurkan melapor jika menemukan atau merasakan tanda dan gejala syok d) Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral Kolaborasi: a) Kolaborasi pemberian IV, jika perlu b) Kolaborasi pemberian transfuse darah, jika perlu c) Kolaborasi pemberian antiinflamasi, jika perlu
---	---	--	--

4	Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan 1) Definisi Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme 2) Penyebab Ketidakmampuan mencerna makanan 3) Batasan karakteristik a) Data mayor Data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnosa defisit nutrisi antara lain 1) Subjektif 2) Objektif Berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal b) Data minor Data minor yang dapat menunjang munculnya diagnosa defisit nutrisi antara lain: 1) Subjektif 1. Kram atau nyeri abdomen 2. Nafsu makan menurun 2) Objektif : 1. Bising usus hiperaktif 2. Otot menelan lemah 4) Kondisi klinis terkait: Infeksi	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama status nutrisi pasien membaik dengan kriteria hasil: a. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat b. Berat badan membaik c. Indeks massa tubuh membaik d. Frekuensi makan membaik e. Nafsu makan membaik	Observasi: a) Identifikasi status nutrisi b) Identifikasi alergi dan intoleransi makanan c) Identifikasi makanan disukai d) Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient e) Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric f) Monitor asupan makanan g. Monitor berat badan g) Monitor hasil pemeriksaan h) laboratorium Terapeutik: a) Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu b) Fasilitas menentukan pedoman diet c) Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai d) Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi e) Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein f) Berikan suplemen makanan, jika perlu. g) Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastric jika asupan oral dapat ditoleransi. Edukasi: a) Anjarkan posisi duduk, jika perlu b) Ajarkan diet yang deprogramkan Kolaborasi: a) Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, jika perlu b) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan, jika perlu
---	--	--	--

Sumber: Tim Pokja Ppni, 2018

Tabel 2.2 Diagnosa Post Operasi

No	SDKI	SLKI	SIKI
1	Nyeri akut berhubungan dengan post operasi Definisi Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. 1) Penyebab Agen pencedera fisiologis (misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma) 2) Batasan karakteristik a. Data mayor 1) Data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnosa nyeri akut antara lain: 2) Subjektif Mengeluh Nyeri 3) Objektif : 1) Tampak meringis 2) Bersikap protektif 3) Gelisah Frekuensi nadi meningkat 4) Sulit tidur b. Data Minor Data minor yang dapat menunjang munculnya diagnosa nyeri akut antara lain (1) Subjektif : (2) Objektif : • Tekanan darah meningkat • Pola nafas berubah • Nafsu makan berubah • Proses berfikir terganggu • Menarik diri • Berfokus pada diri sendiri • Diaforesis 3) Kondisi Klinis Terkait a) Infeksi	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat nyeri dapat menurun dengan Kriteria Hasil: 1) Keluhan nyeri menurun 2) Meringis menurun 3) Sikap protektif menurun 4) Gelisah menurun 5) Kesulitan tidur menurun 6) Menarik diri menurun 7) Berfokus pada diri sendiri menurun 8) Diaforesis menurun 9) Perasaan depress (tertekan) menurun 10) Perasaan takut mengalami cedera berulang menurun 11) Anoreksia menurun 12) Perineum terasa tertekan 13) Uterus teraba membulat menurun 14) Ketegangan otot menurun 15) Pupil dilatasi menurun 16) Muntah menurun 17) Mual menurun 18) Frekuensi nadi membaik 19) Pola nafas membaik 20) Tekanan darah membaik 21) Proses berfikir membaik 22) Fungsi berkemih membaik 23) Perilaku membaik 24) Nafsu makan membaik 25) Pola tidur membaik	Manajemen nyeri a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b) Identifikasi skala nyeri c) Identifikasi respons nyeri non verbal d) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri g) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup h) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan i) Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri kontrol b) lingkungan yang memperberat rasa nyeri fasilitasi istirahat dan tidur c) pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi a) jelaskan penyebab b) periode, dan pemicu nyeri c) jelaskan strategi meredakan nyeri d) anjurkan memonitor nyeri secara mandiri e) anjurkan menggunakan analgetik secara tepat f) ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Kolaborasi Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

2	Risiko Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif (muntah). a) Definisi Berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh, yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa b) Faktor resiko Kekurangan volume cairan Kondisi klinis terkait Perdarahan	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama Pasien mengatakan sudah tidak mengalami syok dengan kriteria hasil: a) Kekuatan nadi meningkat b) Output urinei meningkat c) Tingkat kesadaran meningkat d) Saturasi oksigen meningkat e) Akral dingin menurun f) Pucat menurun g) Haus menurun h) Tekanan darah sistolik membaik i) Tekanan darah diastolic membaik j) Tekanan nadi membaik Frekuensi nafas membaik	Observasi: a) Monitor status kardiopulmonal b) Monitor status oksigenasi c) Monitor status cairan d) Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil e) Periksa riwayat alergi Terapeutik: a) Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen b) Persiapan intubasi dan ventilasi mekanis, jika perlu c) Pasang jalur IV, jika perlu d) Pasang kateter urine untuk menilai produksi urine, jika perlu e) Lakukan skin test untuk mencegah reaksi alergi
3	Risiko Infeksi dibuktikan dengan efek prosedur infasive 1) Definisi Berisiko mengalami peningkatan tereserang organisme patogenik 2) Faktor resiko Efek prosedur invasive 3) Kondisi klinis terkait Tindakan invasiv	Setelah dilakukan tindakan keperawatan tingkat infeksi dengan kriteria hasil: 1) Kebersihan tangan meningkat. 2) Kebersihan badan meningkat. 3) Demam, kemerahan, nyeri, bengkak menurun. 4) Kadar sel darah putih meningkat.	Edukasi: a) Jelaskan penyebab atau faktor risiko syok b) Jelaskan tanda dan gejala awal syok c) Anjurkan melapor jika menemukan atau merasakan tanda dan gejala syok d) Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral Kolaborasi: a) Kolaborasi pemberian IV, jika perlu b) Kolaborasi pemberian transfuse darah, jika perlu c) Kolaborasi pemberian anti inflamasi, jika perlu Pencegahan Infeksi 1) Observasi: a) Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik. b) Batasi jumlah pengunjung c) Berikan perawatan kulit d) pada area edema. e) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan klien dan lingkungan klien. f) Pertahankan Teknik aseptik pada klien berisiko tinggi.

			2) Edukasi: a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. 3) Kolaborasi Kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu.
4	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. 1) Definisi Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih extremitas secara mandiri. 2) Penyebab Nyeri 3) Batasan karakteristik a. Data mayor Data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnose gangguan mobilitas fisik antara lain: 1) Subjektif : a) Mengeluh sulit menggerakkan extremitas 2) Objektif : a) Kekuatan otot menurun b) Rentang gerak menurun b. Data minor Data minor yang dapat menunjang munculnya diagnose gangguan mobilitas fisik antara lain: 1) Subjektif : i. Nyeri saat bergerak ii. Enggan melakukan pergerakan iii. Merasa cemas saat Bergerak 2) Objektif : i. Sendi kaku ii. Gerakan tidak terkoordinasi iii. Gerakan terbatas iv. Fisik Lemah	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama Pasien menyatakan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil: a) Pergerakan extremitas meningkat b) Kekuatan otot meningkat c) Rentang gerak meningkat d) Nyeri menurun e) Kecemasan menurun f) Kaku sendi menurun Gerakan tidak terkoordinasi menurun g) Gerakan terbatas menurun h) Kelemahan fisik menurun	Observasi a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya b) Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi c) Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi d) Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi Terapeutik a) Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu b) Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik c) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi Edukasi a) Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi b) Anjurkan melakukan ambulasi dini c) Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan

E. Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik dengan menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat pada kebutuhan klien, faktor - faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan, strategi implementasi keperawatan dan kegiatan komunikasi (Dinarti dan Mulyani, 2017).

F. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi atau tahap penilaian merupakan tindakan perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara bersambung dengan melibatkan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap perencanaan (Wahyuni, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Adeodatus Yuda Handaya. 2017. *Deteksi Dini dan atasi 31 Penyakit Bedah Saluran Cerna*. Yogyakarta. Rapha Publishing.
- Ambros, et al. (2021). *How learning works: seven research-based principals for smart teaching*. San Fransisco, CA: John Wiley Son.
- Amin Huda Nurarif, & Hardhi Kusuma. 2015. *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis Dan Nanda NIC-NOC Edisi Revisi Jilid 1*. Yogyakarta. Mediaction.
- Amin Huda Nurarif, & Hardhi Kusuma. 2016. *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis Dan Nanda NIC-NOC Edisi Revisi Jilid 1*. Yogyakarta. Mediaction.
- Brunner & Suddarth. 2013. *Keperawatan Medikal-Bedah*. Jakarta. EGC.
- David Mirza Mahendra. 2021. *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Oprasi Apendiksitis Di Rsud Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan*. Karya Tulis Ilmiah. Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Jurusan Prodi D-III Keperawatan Samarinda .
- Erwin Hidayat. 2020. *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Apendiksitis yang Di Rawat Di Rumah Sakit*. Karya Tulis Ilmiah. Politeknik Kesehatan Kementrian Jurusan Prodi D-III Keperawatan Samarinda.
- Fandy Zulfikar. 2015. *Studi Penggunaan Antibiotik pada Kasus Bedah Apendiksitis di*

Instalasi Rawat Inap RSD dr. Soebandi Jember. 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember 2 Instalasi Farmasi RSD dr. Soebandi Jember e-mail: zulfikarfandy@yahoo.com

Hanifah. 2019. *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Apendiksitis yang Di Rawat Di Rumah Sakit*. Karya Tulis Ilmiah. Politeknik Kesehatan Kementrian Jurusan Prodi D-III Keperawatan Samarinda.

Kemenkes RI. 2017. *Data dan Informasi Kesehatan Profil Kesehatan Indonesia*

Nian Afrian Nuari. 2015. *Asuhan Keperawatan Pada Gangguan Sistem Gastrointestinal*. Trans Info Media. Jakarta

Medical Record Rsud Dr Adjidarmo. (2022). *10 Penyakit Terbanyak*

Saputro, N. E. (2018). *Asuhan Keperawatan Pada Klien Post Operasi Apendiksitis Dengan Masalah Keperawatan Kerusakan Integritas Jaringan*. 2(1), 7-8. Retrieved from <http://repo.stikesicme-jbg.ac.id/1535/2/>

Setyaningrum, Wahyu Adi. (2013). *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Pos Operasi Apendiksistomi Hari Ke-1 di Ruang Dahlia RSUD Banyudono*. Naskah Publikasi UMS.

Suara Mahyar. 2018. *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta. Cv, Trans Info Medika.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Wainsani, S., & Khoiriyah, K. (2020). *Penurunan Intensitas Skala Nyeri Pasien Appendiks Post Appendiktomi Menggunakan Teknik Relaksasi Benson*. *Ners Muda*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.26714/nm.v1i1.5488>

ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DIARE

Ida Farida, APPd., M.Kes.



ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DIARE

PENULIS: IDA FARIDA, APPd., M.Kes.

A. KONSEP DASAR MEDIK

1. Pendahuluan

Orang sering berpendapat diare adalah buang air besar yang lebih sering dari biasanya. Lazimnya seseorang setiap pagi buang air besar. Namun bila dalam kurung waktu beberapa jam sudah buang air besar lebih dari tiga kali, hal tersebut dapat dikatakan sebagai diare. Bukan sekadar frekuensinya yang bertambah, namun konsistensi fesesnya pun lebih lunak atau cair, kadang disertai rasa mulas atau melilit pada perutnya. Banyak orang berpendapat diare sama dengan gastroenteritis, tapi hal ini tidak terlalu tepat. Memang ada persamaan antara diare dan gastroenteritis, yaitu konsistensi feses cair dan frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali. Perbedaannya adalah gastroenteritis disertai mual dan muntah, sedangkan pada diare tidak ditemukan mual dan muntah.

Diare dapat terjadi pada semua tingkat usia, mulai dari bayi, balita, anak-anak sampai dengan dewasa dan lanjut usia. Secara umum pada tahun 2020 telah terjadi 1,5 juta kasus diare di dunia (WHO, 2020). Di Indonesia, rerata kejadian diare secara nasional adalah 6,8% dan kejadian terbanyak (11,5%) terjadi pada usia 1-4 tahun (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Namun yang akan kita bicarakan disini adalah kejadian diare pada orang dewasa.

Banyak hal yang dapat menyebabkan diare pada orang dewasa, antara lain infeksi bakteri/virus (Umar Zein, Khalid Huda Sagala, 2017), intoleransi laktosa dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Diare juga sering dihubungkan dengan kebersihan diri yang kurang baik, jarang cuci tangan, makan makanan yang kurang bersih. Namun hasil penelitian (Trikora & Siwiendrayanti, 2015) menyatakan tidak ada hubungan kebiasaan cuci tangan dengan diare.

Karena buang air lebih cair dan sering, maka dapat terjadi kekurangan volume cairan, kulit sekitar anus iritasi karena sering dibasuh. Studi kasus yang dilakukan oleh (Andriani, 2021) memperlihatkan bahwa pada orang dewasa yang mengalami diare dapat terjadi masalah kekurangan volume cairan.

Mengingat dampak masalah yang diakibatkan oleh diare begitu banyak, maka kita harus melakukan pencegahan supaya tidak mengalami diare. Pencegahan diare yang dapat dilakukan antara lain pendidikan kesehatan untuk menurunkan angka kejadian diare.

2. Definisi Diare

Diare adalah keadaan ketidaknyamanan perianal, urgensi atau inkontinensia dimana buang air besar lebih dari tiga kali per hari, jumlah feses lebih dari 200 gram per hari dan konsistensi feses cair (Nair, 2009). Diare adalah kondisi akut dari feses yang keluar encer atau cair, minimal tiga kali sehari, bisa dianggap kronis bila terjadi lebih dari empat minggu (Harding & Kwong, 2019).

Diare adalah keluarnya feses yang lebih sering dan sebagian besar konsistensinya lebih cair, bila berlangsung kurang dari 14 hari disebut diare akut, bila terjadi terus menerus lebih dari sebulan disebut diare kronis (Riddle et al., 2016)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diare adalah buang air besar lebih dari tiga kali dalam satu hari, konsistensi feses cair, bisa terjadi akut sampai kronis.

3. Jenis Diare

Jenis diare antara lain sekresi, osmotik, malabsorpsi, menular dan eksudatif. Ada juga yang membagi jenis diare sebagai diare akut dan diare kronis. Diare akut biasanya terjadi akibat infeksi bakteri, virus, parasit (Umar Zein, Khalid Huda Sagala, 2017). Diare kronis sering dihubungkan dengan penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, intoleransi laktosa dan gangguan endokrin (Nair, 2009)

4. Penyebab Diare

Menurut Harding & Kwong (2019), berbagai faktor dapat menyebabkan diare, antara lain:

- a. Virus; Rotavirus, Norovirus
- b. Bakteri; Escherichia Colli, Shigella, Salmonela, Staphilococcus, Clostridium
- c. Parasit: Entamoeba Histolytica, Cryptosporidium

5. Patofisiologi Diare

Diare terjadi karena ketidakseimbangan antara proses penyerapan dan sekresi di usus halus. Proses terjadinya diare dapat dijelaskan melalui mekanisme osmotik dan sekresi (Kelly et al., 2018).

Mekanisme diare secara osmotik diawali dengan masuknya zat yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus, misalnya pada kasus intoleransi laktosa dari susu sapi, sehingga banyak cairan pasif bergerak di lumen usus. Hal ini mengakibatkan bertambahnya volume lumen usus. Sementara peristaltic usus bergerak kearah bawah dari usus halus menuju kolon, bila pada waktunya rectum penuh maka akan menstimulasi spinter ani untuk relaksasi, membuka

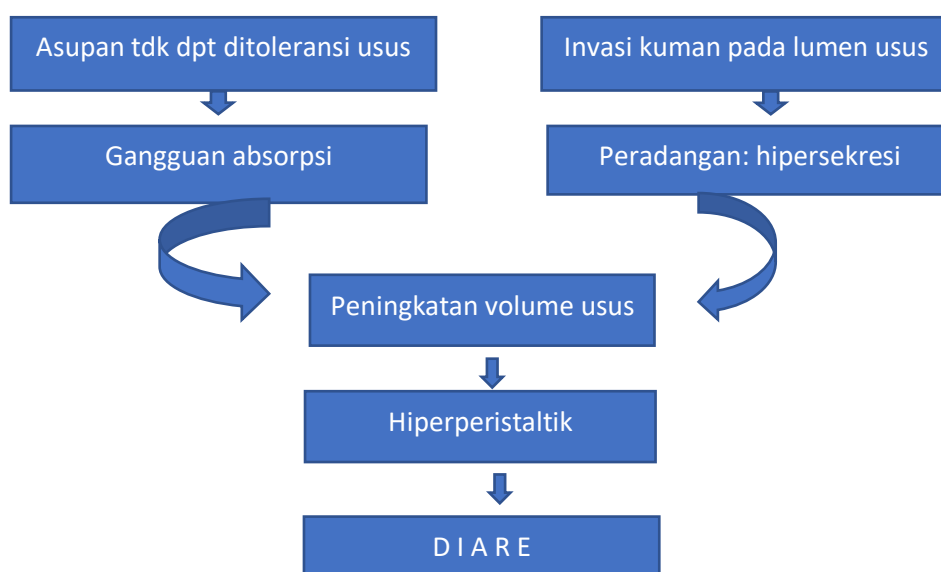
anus terbuka sehingga terjadi proses buang air besar namun dengan konsistensi feses yang cair.

Proses diare secara sekresi dimulai ketika mediator kimia (Sheikh et al., 2018) menstimulasi usus mengeluarkan sekresi berlebih sebagai respon dari proses peradangan atau iritasi eritrosit oleh invasi bakteri berlebih. Harding & Kwong (2019) menjelaskan bahwa virus atau bakteri penyebab diare memasuki tubuh manusia melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging ayam yang dimasak kurang matang. Bakteri atau parasite juga bisa masuk ke tubuh manusia melalui rute fekal – oral; tertular dari tangan orang lain yang hygiene tangannya kurang bersih. Setelah virus atau bakteri masuk kedalam saluran cerna mulai dari mulut, lambung sampai ke usus, menginvasi mukosa usus, menimbulkan reaksi peradangan, usus mengeluarkan sekresi berlebih untuk melawan invasi kuman tersebut (Kelly et al., 2018).

Didalam usus virus dan bakteri berkembang biak, sehingga volume usus meningkat, tekanan osmotik usus meningkat pula. Selain itu bakteri dan virus atau parasite yang hidup menempel di sepanjang mukosa usus menghalangi proses penyerapan, akibatnya bahan makanan memenuhi rongga usus. Volume usus yang penuh memberi stimulasi aktivitas saraf otonom untuk memberikan respon impuls kolinergik meningkatkan peristaltik usus, sehingga isi usus bergerak ke bawah sampai ke rektum sehingga terjadilah proses defekasi / buang air besar. Karena terjadi gangguan absorpsi di usus, konsistensi bahan fekal masih berbentuk cair (Harding & Kwong, 2019).

Proses diare secara umum dapat digambarkan pada bagan di bawah ini :

Gambar 1. Patofisiologi Diare



Sumber : (Kelly et al., 2018), (Sheikh et al., 2018), (Harding & Kwong, 2019)

6. Manifestasi Klinis Diare

Menurut Nair (2009), klien yang mengalami diare dapat menunjukkan gejala klinis sebagai berikut : Frekuensi buang air besar bertambah; Konsistensi feses lebih cair; Peristaltic usus meningkat; Kram abdomen; Tidak nafsu makan; Haus; Pada diare kronik, karena dehidrasi berkelanjutan dapat menimbulkan hipokalemia dan ketidakseimbangan asam basa (Harding & Kwong, 2019)

7. Pemeriksaan Diagnostik

Sebagian besar kejadian diare dapat sembuh dengan cepat. Namun bila sudah 3 – 5 hari masih diare, apalagi disertai demam, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan (Harding & Kwong, 2019):

- a. Kultur tinja; untuk mengidentifikasi penyebab pasti diare
- b. Tes parasite dan sel telur parasite; dilakukan pada diare yang sudah terjadi sampai dengan dua minggu
- c. Pemeriksaan darah lengkap; anemia ditemukan pada klien dengan diare kronik; bila dehidrasi berlanjut terus maka dapat mengakibatkan peningkatan hematokrit, BUN (Blood Urea Nitrogen) dan kreatinin.
- d. Pada diare kronis, bila penyebab diare belum diketahui secara pasti, dapat dilakukan pemeriksaan endoskopi dan barium enema untuk membantu mengidentifikasi penyebab diare (Nair, 2009)

8. Komplikasi

Akibat dehidrasi yang berlangsung lama klien diare kronik akan mengalami hipokalemia. Efek hipokalemia dalam waktu lama akan menyebabkan disritmia jantung, kelemahan otot, parestesia, hipotensi (Nair, 2009).

9. Penatalaksanaan Diare

Penatalaksanaan diare dapat dilakukan melalui manajemen medis dan manajemen keperawatan (Nair, 2009).

a. Manajemen Medis

Manajemen medis pada diare mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Penatalaksanaan medis berfokus pada pengendalian gejala, mencegah komplikasi, menghilangkan atau mengobati penyakit
- Pemberian obat antibiotic, anti radang, anti diare seperti loperamine (Imodium), diphenoxylate (Lomotil)
- Meningkatkan asupan cairan oral melalui glukosa oral dan larutan elektrolit

- Bila telah teridentifikasi penyebab pasti diare dapat diberikan anti mikroba
- Berikan terapi cairan melalui intra vena untuk rehidrasi cepat, terutama pada klien lanjut usia

b. Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan pada klien diare meliputi beberapa hal, antara lain:

- Dapatkan data riwayat Kesehatan lengkap untuk mengidentifikasi karakteristik dan pola diare, seperti tanda dan gejala, terapi obat saat ini, pola diet dan asupan sehari-hari, riwayat medis dan bedah di masa lalu, paparan penyakit akut dari area/wilayah lain.
- Pemeriksaan fisik berfokus pada auskultasi bising usus; inspeksi membrane mukosa dan kulit untuk menentukan status hidrasi, identifikasi karakteristik feses, observasi daerah perianal; palpasi untuk validasi nyeri perut
- Anjurkan tirah baring sampai periode akut mereda
- Tetap berikan makanan lunak dan minuman dalam jumlah sedikit tapi sering
- Bila asupan makanan sudah dapat ditoleransi, dapat diberikan makanan semipadat sampai ke padat
- Anjurkan klien untuk membatasi asupan minuman kafein dan karbonat, yang sangat panas atau dingin karena akan meningkatkan motilitas usus
- Anjurkan klien untuk membatasi asupan produk susu, lemak, produk biji-bijian, buah segar dan sayuran selama beberapa hari
- Berikan obat antidiare sesuai resep dokter
- Pantau kadar elektrolit serum dengan cermat
- Segera laporkan bukti disritmia atau perubahan tingkat kesadaran
- Anjurkan klien untuk mengikti rutinitas perawatan kulit perianal untuk mengurangi resiko iritasi dan eksoriasi;
- Beri perhatian khusus pada daerah kulit perianal, terutama pada klien lanjut usia karena sangat sensitive terhadap eksoriasi akibat penurunan turgor kulit dan penipisan lapisan lemak subkutan.

Di Indonesia, penatalaksanaan diare akut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat satu bertujuan untuk rehidrasi cairan (Menteri et al., 2014). Adapun hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Menghitung defisit cairan berbasis Berat Jenis Plasma (BJ Plasma) dengan rumus sebagai berikut: $(BJ\ Plasma - 1,025) / 0,001 \times Berat\ Badan\ (Kg) \times 4\ ml$.
- b. Berikan rehidrasi cairan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dua jam pertama; tahap rehidrasi inisial; dari hasil hitungan deficit cairan di atas, berikan cairan Ringer Laktat atau NaCl 0,9 % melalui intravena.
 - Satu jam berikutnya; tahap rehidrasi; Lanjutkan pemberian Ringer Laktat atau NaCl 0,9%, sesuai hitungan di atas.
 - Berikutnya pemberian cairan berdasarkan kehilangan cairan melalui feses, urin dan insensible water loss
- c. Berikan satu gelas oralit setiap klien buang air besar (dewasa)
- d. Klien tidak perlu dipuasakan
- e. Diet : makanan yang mudah dicerna dan tidak mengandung gas
- f. Hindari susu sapi karena terdapat defisiensi transien
- g. Hindari minuman beralkohol karena dapat meningkatkan motilitas dan sekresi usus
- h. Pemberian obat anti diare untuk menurunkan motilitas usus seperti Loparamide; dosis awal 4 mg, berikutnya 2 mg tiap BAB cair, maksimal 16 mg/hari.
- i. Berikan antibiotic bila dicurigai ada infeksi bakteri; misalnya golongan kuinolon, ciprofloxacin 2 x 500mg/hari selama 5-7 hari. Bila diduga Giardiasis, berikan Metronidazole 3 x 500 mg/hari selama 7 hari.

B. KONSEP DASAR KEPERAWATAN

1. Pengkajian

Pengkajian keperawatan diawali dengan wawancara kepada klien untuk mendapatkan data subyektif tentang Riwayat Kesehatan sekarang dan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan mencari data pendukung secara objektif melalui pemeriksaan fisik secara sistematis dari mulai kepala sampai ke kaki dengan teknik inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi.

Data subyektif yang harus didapatkan dari klien diare difokuskan pada riwayat pola buang air besar dan keluhan yang menyertai, misalnya bagaimana frekuensi, durasi, buang air besar, konsistensi feses. Kaji juga apakah ada keluhan nyeri, mual atau muntah. Untuk Riwayat Kesehatan lalu dapat ditanyakan apakah ada riwayat mengkonsumsi antibiotik, obat pencahar. Pengkajian pola kebiasaan sehari-hari difokuskan pada data tentang pola menyiapkan makanan, misalnya masak sendiri atau membeli makanan di warung, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, kebiasaan minum alkohol

yang berlebihan. Dikaji juga apakah ada perubahan pola makan dan nafsu makan, sebelum dan sesudah mengalami diare (Harding & Kwong, 2019).

Data objektif dari hasil pemeriksaan fisik dengan teknik inspeksi berfokus pada tanda dehidrasi seperti keadaan umum lemah, mata cekung, hidrasi kulit kering, volume urin sedikit dan warna urin kuning pekat. Karakteristik feses yang cair perlu dikaji apakah warna feses berubah, terdapat nanah atau darah atau lender atau lemak pada feses yang keluar. Observasi juga kulit disekitar daerah perianal, apakah ada kemerahan atau iritasi akibat diare. Dari hasil auskultasi kita dapatkan frekuensi bising usus yang meningkat. Dapat kita temukan suara abdomen tympani atau hipertympani dari hasil pemeriksaan fisik dengan teknik auskultasi. Kita juga dapat melakukan teknik palpasi pada area abdomen untuk menemukan area nyeri dan distensi abdomen. Pengukuran tanda-tanda vital dapat ditemukan hipotensi, hipertermi, denyut nadi melemah, frekuensi napas relative stabil atau meningkat (Nair, 2009)

2. Diagnosis

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap atau respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah kesehatan, pada resiko masalah kesehatan atau proses kehidupan (PPNI, 2017). Diagnosis keperawatan merupakan bagian vital dalam menentukan asuhan keperawatan yang sesuai untuk membantu klien mencapai derajat Kesehatan yang optimal. Menurut (PPNI, 2017) diare merupakan kondisi klinis yang terkait dengan masalah Keperawatan sebagai berikut:

a. Diare; D.0020; kategori Fisiologis; subkategori Nutrisi dan Cairan. Definisi Diare adalah pengeluaran feses yang sering, lunak dan tidak berbentuk. Penyebab dari masalah diare ada beberapa, antara lain:

- Fisiologis; inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, proses infeksi, malabsorpsi
- Psikologis; kecemasan, tingkat stress tinggi
- Situasional; terpapar kontaminan, terpapar toksin, penyalahgunaan laksatif, penyalahgunaan zat, program pengobatan (agen tiroid, analgesic, pelunak feses, ferosulfat, antasida, cimetidine, antibiotic), perubahan air dan makanan, bakteri pada air.

Gejala dan tanda mayor dari masalah diare secara subjektif tidak ada, namun secara objektif didapatkan defekasi lebih dari tiga kali dalam 24 jam, feses lembek atau cair. Gejala dan tanda minor dari masalah diare secara subjektif adalah urgency, nyeri/kram abdomen dan secara objektif ditemukan bising usus hiperaktif, frekuensi peristaltic meningkat.

- b. Risiko Hipovolemia; D.0034; kategori: fisiologis; subkategori : Nutrisi dan Cairan. Definisi risiko hypovolemia adalah berisiko mengalami penurunan volume cairan intravascular, interstisial, dan/atau intraselular. Faktor resiko nya antara lain: kehilangan cairan secara aktif, gangguan absorpsi cairan, usia lanjut, kelebihan berat badan, status hipermetabolik, kegagalan mekanisme regulasi, evaporasi, kekurangan intake cairan, efek agen farmakologis.
- c. Pemeliharaan Kesehatan tidak efektif; D.0003; kategori: Perilaku; subkategori: Penyuluhan dan Pembelajaran. Definisi Pemeliharaan tidak efektif adalah penurunan volume cairan intravascular, interstisial, dan/atau intraselular. Penyebab dari masalah Pemeliharaan Kesehatan tidak efektif antara lain: kehilangan cairan aktif, kegagalan mekanisme regulasi, peningkatan permeabilitas kapiler, kekurangan intake cairan, evaporasi.

Gejala dan tanda mayor dari masalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif tidak harus didapatkan dari data subyektif. Namun Gejala dan tanda mayor masalah pemeliharaan Kesehatan tidak efektif bisa didapatkan dari data objektif, seperti: frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membrane mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat. Gejala dan tanda minor dari masalah pemeliharaan Kesehatan tidak efektif secara subjektif adalah merasa lemah dan mengeluh haus, sedangkan secara objektif dapat diketahui terdapat pengisian vena menurun, status mental berubah, suhu tubuh meningkat, konsentrasi urin meningkat, berat badan menurun tiba-tiba.

3. Intervensi

Intervensi untuk klien diare bertujuan agar tidak ada penularan mikroorganisme penyebab diare; pola buang air besar Kembali normal; keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa tercapai; status gizi normal; tidak ada kerusakan kulit perianal (Harding & Kwong, 2019).

Menurut (PPNI, 2018) pada klien diare dapat dilakukan manajemen hipovolemia (I.03116) yaitu mengidentifikasi dan mengelola penurunan volume cairan intravascular. Beberapa jenis Tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Observasi

- Periksa tanda dan gejala hypovolemia; seperti frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan nadi menyempit, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah.

- Monitor intake dan output cairan
- b. Terapeutik
 - Hitung kebutuhan cairan
 - Berikan posisi modified Trendelenburg
 - Berikan asupan cairan oral
- c. Edukasi
 - Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral
 - Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak
- d. Kolaborasi
 - Kolaborasi pemberian cairan IV isotonis, misal NaCl, RL
 - Kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis seperti glukosa 2,5%, NaCl 0,4%
 - Kolaborasi pemberian cairan kolid, contoh albumin, Plasmanate
 - Kolaborasi pemberian produk darah

Perencanaan untuk mengatasi masalah perilaku upaya Kesehatan yang tidak efektif dapat dilakukan dengan intervensi edukasi perilaku upaya Kesehatan. PPNI (2018) berpendapat bahwa edukasi perilaku upaya Kesehatan adalah mengajarkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang mendukung kesehatan. Beberapa Tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan edukasi perilaku upaya kesehatan adalah:

- a. Observasi
 - Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima edukasi
- b. Terapeutik
 - Sediakan materi dan media Pendidikan Kesehatan
 - Jadwalkan Pendidikan Kesehatan sesuai kesepakatan
 - Berikan kesempatan untuk bertanya
 - Gunakan variasi metode pembelajaran
 - Gunakan pendekatan promosi Kesehatan dengan memperhatikan pengaruh dan hambatan dari lingkungan sosial serta budaya
 - Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya
- c. Edukasi
 - Jelaskan penanganan masalah Kesehatan
 - Informasikan sumber yang tepat yang tersedia di masyarakat
 - Anjurkan menggunakan fasilitas Kesehatan
 - Anjurkan mengevaluasi tujuan secara periodic
 - Anjurkan menentukan perilaku spesifik yang akan diubah, misal keinginan mengunjungi fasilitas Kesehatan
 - Ajarkan mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai
 - Ajarkan program Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari

- Ajarkan pencarian dan penggunaan system fasilitas pelayanan Kesehatan
- Ajarkan cara pemeliharaan kesehatan

4. Implementasi

Perawat dalam membantu kebutuhan klien Diare harus memperhatikan bahwa semua kasus diare akut sebagai penyakit menular sampai diketahui penyebab pastinya (Harding & Kwong, 2019). Tindakan pencegahan pengendalian infeksi yang ketat diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit diare ke orang lain, antara lain:

- a. Perawat harus cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan setiap klien atau menangani cairan tubuh klien, memakai sarung tangan dan gaun.
- b. Bilas muntahan dan feses di dalam toilet.
- c. Ajarkan klien dan keluarga untuk segera mencuci pakaian yang terkontaminasi dengan sabun dan air
- d. ajarkan prinsip-prinsip kebersihan, tindakan pencegahan pengendalian infeksi dan potensi bahaya penyakit yang menular ke diri sendiri dan orang lain.
- e. Diskusikan dengan klien dan keluarga teknik penanganan makanan yang tepat, cara memasak dan penyimpanan makanan.
- f. Klien diare harus ditempatkan di ruangan tersendiri, diberi stetoskop dan thermometer sekali pakai.
- g. Semua barang di ruangan tersebut didesinfeksi dengan klorin 10% (Harding & Kwong, 2019).

Pada klien diare dapat diberikan Tindakan Edukasi dehidrasi yaitu mengajarkan pengelolaan kekurangan cairan dan elektrolit (PPNI, 2017). Tindakan yang dapat diberikan pada klien diare antara lain:

- a. Observasi; identifikasi kemampuan klien dan keluarga menerima informasi
- b. Terapeutik; persiapkan materi, media, alat, formulari balans cairan; tentukan waktu yang tepat untuk memberikan Pendidikan Kesehatan sesuai kesepakatan dengan klien dan keluarga; berikan kesempatan klien dan keluarga bertanya
- c. Edukasi; jelaskan tanda dan gejala dehidrasi; anjurkan memperbanyak minum; anjurkan memperbanyak konsumsi buah yang mengandung banyak air seperti semangka, papaya; ajarkan cara pemberian oralit; ajarkan menilai status hidrasi berdasarkan warna urin

5. Evaluasi

Setelah semua intervensi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan klien diare, perawat perlu melakukan evaluasi untuk menilai apakah masalah telah teratasi, teratasi Sebagian atau muncul masalah baru. Dalam melakukan evaluasi diperlukan indikator ketercapaian tujuan pada setiap masalah. Evaluasi yang dilakukan pada klien diare mengacu pada kriteria hasil keperawatan sesuai Standar Luaran Keperawatan Indonesia (PPNI, 2019).

Keberhasilan masalah diare dapat diamati dari luaran utamanya adalah eliminasi fecal Kembali normal seperti frekuensi satu kali sehari, konsistensi feses padat. Untuk masalah hypovolemia yang dialami klien diare keberhasilan Tindakan keperawatan dapat dinilai dari perbaikan termoregulasi seperti tekanan darah, denyut nadi radial, membrane mukosa, turgor kulit menjadi lebih baik. Kriteria hasil penanganan masalah kurang cairan pada klien diare dapat teratasi yaitu asupan cairan, keluaran urin, kelembaban mukosa, asupan makanan meningkat (PPNI, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, V. (2021). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diare Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi dan Cairan. *Universitas Kusuma Husada Surakarta*.
- Harding, M. M., & Kwong, J. (2019). *Lewis ' s Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems*.
- Kelly, L., Jenkins, H., & Whyte, L. (2018). Pathophysiology of diarrhoea. *Paediatrics and Child Health (United Kingdom)*, 28(11), 520–526. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2018.09.002>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf* (p. 674).
- Menteri, P., Republik, K., Praktik, P., Bagi, K., Di, D., Pelayanan, F., Primer, K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Kesehatan, M., & Indonesia, R. (2014). *BERITA NEGARA*. 2008(231), 2–4.
- Nair, U. (2009). Textbook of Medical and Surgical Nursing. In *Textbook of Medical and Surgical Nursing*. <https://doi.org/10.5005/jp/books/10916>
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia - Definisi dan Indikator Diagnostik* (PPNI (ed.); ke tiga). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan* (PPNI (ed.); ke dua). DPP PPNI.

- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia : Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (PPNI (ed.); ke dua). DPP PPNI.
- Riddle, M. S., Dupont, H. L., & Connor, B. A. (2016). ACG clinical guideline: Diagnosis, treatment, and prevention of acute diarrheal infections in adults. *American Journal of Gastroenterology*, 111(5), 602–622. <https://doi.org/10.1038/ajg.2016.126>
- Sheikh, I. A., Ammourey, R., & Ghishan, F. K. (2018). Pathophysiology of Diarrhea and Its Clinical Implications. In *Physiology of the Gastrointestinal Tract, Sixth Edition* (Sixth Edition, Vol. 2). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809954-4.00068-2>
- Trikora, E., & Siwiendrayanti, A. (2015). Hubungan Praktik Cuci Tangan, Kriteria Pemilihan Warung Makan Langgan dan Sanitasi Warung dengan Kejadian Diare pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Unnes Journal of Public Health*, 4(1), 39–48.
- Umar Zein, Khalid Huda Sagala, J. G. (2017). Diare Akut Disebabkan Bakteri. *Universitas Stuttgart*, 1–15.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN HEPATITIS

Ns. RINI NURDINI, M.Kep.



ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN HEPATITIS

PENULIS : Ns. RINI NURDINI, M.Kep.

A. KONSEP DASAR MEDIK

1. Pendahuluan

Penyakit hepatitis menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia, hal ini terjadi karena mudahnya penularan sehingga banyak terjadi kematian yang disebabkan oleh penyakit ini yang dapat menyerang bayi, balita, orang dewasa maupun lansia. Penyakit hepatitis yang mudah menular ini disebabkan karena salah satunya dari kurangnya pengetahuan tentang sanitasi dan perilaku gaya hidup individu. Upaya pencegahan dari penyakit ini bisa menjadi salah satu alternative dalam menurunkan angka kejadian dan kematian akibat hepatitis, selain fasilitas kesehatan juga menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Menurut Hesmina PS dkk dalam penelitiannya yang berjudul perbedaan pengetahuan pre dan post Pendidikan kesehatan pada penghuni lapas tentang resiko kejadian viral hepatitis menyimpulkan ada perbedaan pengetahuan pre dan post tentang kejadian viral hepatitis. (Sari et al., 2019)

Penelitian Elsi Setiandari, dkk yang berjudul Hubungan pekerjaan dan jarak pelayanan kesehatan terhadap peningkatan kasus hepatitis pada ibu hamil yang menyimpulkan bahwa lingkungan dan sanitasi tempat tinggal yang sangat padat menjadi mudah dalam penularan hepatitis B, dan tingginya pendidikan ibu hamil dan banyak ibu hamil yang bekerja membuat mereka malu dan malas untuk melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan jarak tempuh fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau. (L.O et al., 2021)

Penyakit hepatitis di Indonesia menjadi penyakit endemis sehingga sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat, produktivitas, angka harapan hidup, dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, ada sekitar 1.017.290 kasus hepatitis yang terjadi di seluruh Indonesia. Prevalensi kasus terbesar terjadi pada usia 5 – 14 tahun, yakni 182.338 kasus. (Riskesdas, 2018)

Menurut penelitian Prima nanda F, dkk yang berjudul prevalensi infeksi hepatitis B calon tenaga kerja Indonesia melalui pemeriksaan laboratorium elisa bahwa 15 orang positif menderita hepatitis dari 756 subjek penelitian yang dilakukan dari Januari-Maret 2020. (Fauziah et al., 2021)

Organ hati termasuk salah satu organ dari sistem pencernaan yang berperan sangat penting terhadap proses metabolisme tubuh. Gangguan hati ini dapat disebabkan salah satunya oleh virus sehingga terjadinya infeksi pada hati. Penyakit Hepatitis ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dalam proses pencernaannya sehingga penyaringan racun dan zat berbahaya dalam tubuh

terganggu. Penyakit hepatitis yang masuk ke stadium kronis semakin berisiko tinggi menimbulkan kanker hati.

2. Definisi

Hepatitis yaitu virus ditularkan secara parenteral , meliputi virus hepatitis B, C dan D, serta virus yang ditularkan secara fekal-oral , meliputi virus hepatitis A dan E. (R Sjamsulhidayat dkk, 2013)

Penyakit hepatitis adalah kondisi peradangan hati. Peradangan ini dapat terbatas atau berkembang menjadi fibrosis (Jaringan parut), sirosis atau kanker hati. (WHO, 2019)

Penyakit hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Ada 5 jenis virus hepatitis: A, B, C, D, dan E. Infeksi yang akan mengganggu kerja organ hati ini dapat menular dengan mudah, melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus. (Wahyudi, 2017)

3. Jenis-jenis Hepatitis

Beberapa jenis hepatitis dikenal dengan sebutan;

- a. Hepatitis B
- b. Hepatitis C
- c. Hepatitis D
- d. Hepatitis A
- e. Hepatitis E

4. Anatomi Fisiologi

Hati terletak di rongga perut sebelah kanan atas, di bawah sekat rongga badan atau diafragma, hati merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh, yang mempunyai berat 1500 gr atau 2,5 % dari berat tubuh dan dilindungi oleh tulang iga. Hati terbagi dalam dua belahan utama, yang dikenal dengan lobus kanan dan lobus kiri. Permukaan atas berbentuk cembung dan terletak di bawah diafragma, permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan lekukan disebut fisura transversum. Fisura longitudinal memisahkan belahan lobus kanan dan lobus kiri di permukaan bawah, sedangkan ligamen falsiformis memisahkan belahan lobus kanan dan lobus kiri di permukaan atas hati.

Peredaran darah pada hati juga mempunyai dua jenis persediaan darah yang datang melalui arteri hepatica dan vena porta. Arteri hepatica yang keluar dari aorta dan memberikan seperlima darahnya kepada hati sedangkan vena porta yang terbentuk dari vena lienalis dan vena mesenterika superior, mengantarkan empat perlimanya ke hati. Darah vena porta ini membawa kepada hati zat makanan yang telah diabsorpsi oleh usus halus. Vena hepatica mengembalikan darah dari hati ke vena kava inferior. Maka di dalam hati terdapat empat pembuluh darah utama yang

menjelajahi seluruh hati, dalam pengertian dua yang masuk yaitu arteri hepatica dan vena porta sedangkan yang keluar yaitu vena hepatica dan saluran empedu.

Hati juga mempunyai fungsi yaitu menetralkan racun dan makanan. Sesuai dengan fungsinya, hati melaksanakan fungsi pencernaan terhadap sebagian besar bahan kimia melalui aktivitas enzim yang beraneka ragam.

Hati juga menduduki urutan pertama dalam hal jumlah, kerumitan dan ragam fungsi. Hati sangat penting untuk mempertahankan fungsi hidup dan berperan dalam hampir setiap metabolisme dan bertanggung jawab atas lebih dari 500 aktivitas berbeda.

5. Etiologi

Etiologi hepatitis terbagi dalam dua yaitu hepatitis penyebab dari virus dan non virus. Hepatitis yang disebabkan virus adalah hepatitis A, B, C, D dan E sedangkan hepatitis penyebab non virus disebabkan oleh alkohol, obat-obatan, bahan beracun dan akibat penyakit lain.

Penyakit Hepatitis di Indonesia yang paling sering adalah infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis A, B, dan C (biasa disebut dengan VHA, VHB, dan VHC). Jenis virus ini memiliki karakteristik virus yang sangat berbeda sehingga berbeda pula cara penularannya.

Jenis-jenis virus hepatitis ini berbeda dalam sifat molekuler dan antigen, akan tetapi semua jenis virus tersebut memperlihatkan gejala klinis dan perjalanan penyakit yang sama. Beberapa uraian penyebab dari masing-masing Hepatitis ini berdasarkan jenisnya antara lain Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus DNA dari golongan hepadna, untuk hepatitis C penyebabnya adalah suatu virus RNA kelompok flaviviridae dimana jenis virus ini sangat sulit diatasi oleh respon imun tubuh karena mempunyai kemampuan mutasi yang sangat cepat, penyebab hepatitis D adalah suatu virus RNA yang tidak komplet, virus ini untuk hidupnya membutuhkan HBsAg sebagai selubung karena berukuran sangat kecil sekitar 36 nm. Pada Hepatitis A disebabkan oleh virus RNA golongan pikornavirus, sedangkan hepatitis E disebabkan oleh virus RNA golongan Calcivirida yang waktu hidupnya tidak akan bertahan lama didalam lingkungan diluar tubuh.

6. Patofisiologi

Perjalanan timbulnya penyakit hepatitis ini diawali dengan adanya proses peradangan pada hati, hal ini terjadi karena adanya infeksi oleh virus, toksin, maupun karena hal lain. Peradangan pada hati ini dapat merusak sel hati dan mengganggu fungsi dari organ hati tersebut, hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh dan terjadi peregangan pada sel hati yang menyebabkan pasien merasa tidak nyaman pada perut bagian kuadran kanan atas. Proses

inflamasi ini akan memanggil respon imun untuk mengatasi inflamasi yang terjadi pada hati sehingga dapat merusak sel hepatosit dan sel Kupffer dan timbulah hyperplasia, nekrosis dan regenerasi seluler. Proses inflamasi ini juga akan mempengaruhi aliran empedu yang akan melewati kanakuli empedu dan menuju system empedu sehingga akan muncul jaundice (kekuningan), hal ini terjadi karena bilirubin tidak sempurna dikeluarkan melalui ductus hepaticus sehingga terjadi retensi dan regurgitasi pada ductuli, empedu yang mengalami konjugasi (bilirubin indirek), maupun bilirubin yang sudah mengalami konjugasi (bilirubin direk), Karena bilirubin konjugasi larut dalam air, maka bilirubin dapat dieksresi ke dalam kemih, sehingga menimbulkan bilirubin urine dan kemih berwarna gelap, tinja mengandung sedikit stercobilin oleh karena itu tinja tampak pucat. Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi dapat disertai peningkatan garam-garam empedu dalam darah yang akan menimbulkan gatal-gatal.

Parenkim hati tidak akan rusak secara signifikan bila proses inflamasi yang terjadi bersifat ringan contohnya penyakit hepatitis A, berbeda dengan hepatitis B dan C, virus jenis ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang lebih serius. Kerusakan hati ini dapat mengganggu metabolisme nutrient, obat-obatan, alkohol, toksin dan eliminasi aliran empedu. Cairan empedu yang dihasilkan hati ini sangat penting untuk mengemulsifikasi dan meningkatkan absorpsi lemak, cairan ini diproduksi oleh hati sebanyak 700 – 1200 ml setiap hari. (Priscilla LeMone et all, 2019)

7. Manifestasi Klinik

Manifestasi klinik semua jenis hepatitis secara umum sama hanya dibedakan berdasarkan fase atau stadium. Tanda dan gejala yang muncul terbagi dalam beberapa fase/stadium diantaranya; (Joice M Black, 2014)

a. Fase Prodromal atau pre ikterik

Fase ini dapat terjadi secara mendadak atau tanpa gejala, gejala umum yang terjadi biasanya mual, muntah, malaise, anoreksia, kelelahan, diare, atau konstipasi, nyeri otot dan tubuh, nyeri ringan pada abdomen kanan atas, dan juga menggigil yang akhirnya demam. Tanda dan gejala tersebut seringkali dialami pasien mengalami flu berat.

b. Fase Ikterik

Fase ini biasanya dimulai pada hari ke 5 hingga ke 10 setelah munculnya gejala awal, manifestasi klinik yang ditemukan pada tahap ini adalah ikterik pada sklera, kulit dan membrane mukosa, pruritus, feses berwarna coklat muda atau abu-abu, urin berubah menjadi warna coklat seperti teh. Bila tidak terdapat komplikasi proses penyembuhan secara spontan dimulai dalam 2 minggu setelah munculnya jaundis.

c. Fase Pemulihan

Pada fase ini manifestasi akan membaik selama beberapa minggu secara bertahap, nyeri hati akan berkurang, enzim serum akan menurun, gejala gastrointestinal pun akan menurun dan kelemahan akan menghilang. Hal ini ditandai dengan munculnya perasaan lebih sehat, pasien akan kembali nafsu makan, dan akan membaik dalam waktu 2-3 minggu bila kondisi hepatitis akut.

8. Cara Penularan Hepatitis

a. Hepatitis B

Virus hepatitis B ini dikenal dengan sebutan hepatitis fulminan (progresif secara cepat), virus ini menular melalui kontak dengan aliran darah atau cairan tubuh yang terinfeksi seperti air liur, placenta ibu dengan anaknya. Kelompok yang beresiko tinggi tertular virus ini adalah individu yang memiliki banyak patner dalam seks, pengguna narkoba dengan suntik, homo seks, dan individu yang bekerja di lingkungan yang terpapar produk darah seperti PMI, hemodialisa, tenaga kesehatan.

b. Hepatitis C

Penyakit hepatitis jenis ini ditularkan melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, sama halnya dengan hepatitis jenis B.

c. Hepatitis D

Penyakit hepatitis D ini akan muncul atau terinfeksi pada orang yang sudah terinfeksi hepatitis B. ditularkan dengan cara yang sama dengan hepatitis B dan C

d. Hepatitis A

Penyakit hepatitis A ini ditularkan melalui rute fekal oral makanan, air yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan pasien yang sudah terinfeksi.

e. Hepatitis E

Jenis hepatitis ini ditularkan melalui kontaminasi fekal melalui persediaan air di negara berkembang seperti asia tenggara. Air minum yang tercemar tinja merupakan media penularan yang paling umum.

9. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Laboratorium yang dapat ditemukan yaitu

- a. Kadar bilirubin serum meningkat
- b. SGOT dan SGPT meningkat
- c. Fosfatase alkali meningkat
- d. Albumin serum
- e. Protein total serum
- f. Globulin serum
- g. Pemeriksaan HBs Ag, anti HBs, HBV DNA

Pemeriksaan Radiologi

- a. Foto rontgen abdomen
- b. Kolestogram dan kalangiogram
- c. Arteriografi pembuluh darah seliaka

Pemeriksaan Tambahan

- a. Laparoskopi
- b. Biopsi hati
- c. USG

10. Penatalaksanaan

Ada beberapa tahap penatalaksanaan dari penyakit ini adalah ;(Wahyudi, 2017)

- a. Terapi suportif, melalui istirahat yang cukup dan aktivitas berlebihan dibatasi, penderita yang menunjukkan keluhan berat harus istirahat penuh selama 1-2 bulan.
- b. Diet harus mengandung cukup kalori dan mudah dicerna.
- c. Obat-obatan hanya diberikan untuk mengurangi gejala yang muncul, seminimal mungkin hindari pemberian obat-obatan karena obat akan dimetabolisme oleh hati yang akan meningkatkan SGPT.
- d. Manajemen khusus untuk hati dapat diberikan dukungan untuk hemodialysis
- e. Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin. Pencegahan ini hanya dianjurkan bagi orang-orang yang mengandung resiko terinfeksi.
- f. Bila pasien mual muntah, dan diare sebaiknya pasang IVFD untuk mengatasi dehidrasi.
- g. Perawatan yang dapat dilakukan di rumah:
 - Kurangi aktivitas banyak istirahat
 - Minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi
 - Hindari minum obat yang dapat melukai hati misalnya yang mengandung asetaminofen.
 - Hindari olahraga yang berat sampai gejala membaik.

B. KONSEP DASAR KEPERAWATAN

1. Pengkajian

Asuhan keperawatan pada pasien dengan Hepatitis ini berfokus pada pencegahan penyebaran infeksi ke orang lain dan meningkatkan kenyamanan serta kemampuan pasien untuk melakukan perawatan diri secara mandiri.

- a. Biodata; terdiri dari identitas pasien, dan identitas penanggung jawab (orangtua, atau saudara kandung) meliputi nama, umur, jenis kelamin,

pendidikan, pekerjaan, untuk pasien ditambah no registrasi dan diagnose medis.

b. Riwayat Kesehatan Pasien

- Keluhan Utama

Keluhan utama dapat berupa nyeri pada abdomen kuadran kanan atas, nafsu makan menurun, mual, muntah, lemah, demam dan kuning.

- Riwayat Kesehatan Sekarang

Riwayat kesehatan ini dikaji dari awal adanya keluhan sebelum masuk rumah sakit, keluhan saat dibawa ke RS sampai dengan perjalanan selama di rawat di RS.

Penderita mempunyai manifestasi seperti; anoreksia, mual, muntak, ketidaknyamanan abdomen, perubahan defekasi atau warna feses, nyeri otot atau sendi, kelelahan, perubahan warna sklera atau kulit, perhatikan durasi gejala; paparan yang diketahui untuk hepatitis, perilaku yang beresiko tinggi seperti pengguna narkoba suntik, atau memiliki pasangan seksual yang banyak.

- Riwayat kesehatan dahulu

Riwayat kesehatan dahulu dikaji yang berkaitan dengan penyakit yang pernah diderita sebelumnya, kecelakaan yang pernah dialami termasuk keracunan, prosedur operasi dan perawatan rumah sakit serta perkembangan penyakitnya.

Kaji adanya riwayat sakit dengan keluhan gangguan hati.

- Riwayat Kesehatan Keluarga

Pada riwayat ini dikaji berkaitan dengan penyakit keturunan, riwayat penyakit menular dan pola kebiasaan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang berkaitan dengan penyakit pencernaan.

- Pola kebiasaan Sehari-hari

Kaji yang berkaitan dengan factor predisposisi timbulnya penyakitnya saat ini seperti;

- Pola Nutrisi dan cairan: Jenis makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi pasien sebagai factor predisposisi penyakitnya saat ini seperti makanan berlemak, beralkohol.
- Pola eliminasi: Adakah riwayat BAK dengan warna urin berwarna gelap seperti air teh dan feses yang berwarna pucat /abu-abu.
- Pola tidur: Adakah gangguan sulit tidur karena tidak nyaman pada bagian abdomen.
- Personal Hygiene: Kaji riwayat sanitasi dan lingkungan sekitarnya hygiene atau tidak.

- Pola Aktivitas: Kaji riwayat aktivitas di malam hari seperti dugem, merokok, bergadang, dan penggunaan narkoba suntik
- Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik ini dikaji melalui tahapan pemeriksaan fisik khususnya untuk system pencernaan seperti; Inspeksi, Auskultasi, Palpasi dan perkusi.
Kaji tanda-tanda vital mencakup suhu tubuh; warna sklera dan membrane mukosa, warna dan kondisi kulit, kontur dan nyeri tekan abdomen, warna feses dan urin.
- Riwayat Psikologi
Kaji yang berkaitan dengan konsep diri pasien atau bagaimana pandangan pasien saat sedang menderita penyakitnya saat ini dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya, meliputi; gambaran diri, peran diri, identitas diri, ideal diri dan harga diri.
- Riwayat Spiritual
Kaji yang berkaitan dengan bagaimana pandangan pasien terhadap penyakit yang dideritanya terhadap keyakinan akan kesembuhan dari penyakitnya saat ini dan keikhlasan menerima kondisi saat ini yang datangnya semata-mata dari Tuhan YME.

2. Diagnosa Keperawatan

Beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan Hepatitis adalah sebagai berikut ; (TIM POKJA SDKI DPP PPNI, 2017)

a. Defisit Nutrisi/Resiko Defisit Nutrisi

Definisi : Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.

Penyebab :

- Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient
- Peningkatan kebutuhan metabolisme
- Faktor psikologi (keengganan untuk makan)

Gejala dan Tanda Mayor ; berat badan menurun minimal 10 % dibawah rentang ideal

Gejala dan Tanda Minor :

Subyektif :

- Cepat kenyang setelah makan
- Kram/nyeri abdomen
- Nafsu makan menurun

Objektif :

- Bising usus hiperaktif
- Membrane mukosa pucat
- Serum albumin turun
- Diare

b. Nyeri Kronis

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 3 bulan.

Penyebab :

Gangguan fungsi metabolic

Gejala dan Tanda Mayor

Subyektif :

- Mengeluh nyeri
- Merasa tertekan

Obyektif :

- Tampak meringis
- Gelisah
- Tidak mampu menuntaskan aktivitas

Gejala dan Tanda Minor

Subyektif :

- Merasa takut terjadinya cedera berulang

Obyektif :

- Bersikap protektif (posisi menghindari nyeri)
- Waspada
- Pola tidur berubah
- Anoreksia
- Fokus menyempit
- Berfokus pada diri sendiri

c. Intoleransi Aktivitas

Definisi : Ketidacukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Penyebab :

- Tirah baring
- Kelemahan
- Imobilitas

Gejala dan Tanda Mayor;

Subyektif ; Mengeluh Lelah

Obyektif : Frekuensi jantung meningkat >20 % dari kondisi istirahat.

Gejala dan Tanda Minor;

Subyektif :

- Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas
- Merasa lemah

Obyektif :

- Tekanan darah berubah > 20% dari kondisi istirahat
- Sianosis

d. Resiko Infeksi (transmisi)

Definisi : beresiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik

Bertujuan : mencegah terjadinya penyebaran infeksi

Faktor Resiko :

- Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan
- Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
- Malnutrisi
- Penyakit kronis

3. Intervensi Keperawatan

Merupakan segala treatment yang dikerjakan perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan.(TIM POKJA SIKI DPP PPNI, 2018)

a. Diagnosa keperawatan : Defisit Nutrisi

Intervensi Utama :

Manajemen nutrisi

Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang

Tindakan :

i. Observasi

- Identifikasi status nutrisi
- Identifikasi alergi dan intoleransi makanan
- Identifikasi makanan yang disukai
- Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient
- Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric
- Monitor asupan makanan
- Monitor berat badan
- Monitor hasil pemeriksaan laboratorium

ii. Terapi

- Lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu
- Fasilitasi menentukan pedoman diet
- Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
- Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- Berikan makanan tinggi kalori dan protein
- Berikan suplemen makanan jika perlu
- Hentikan pemberian makan melalui selang NGT, jika asupan oral dapat ditoleransi

iii. Edukasi

- Anjurkan posisi duduk jika mampu
- Ajarkan diet yang diprogramkan

iv. Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu
- Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrient yang dibutuhkan jika perlu.

b. Diagnosa Keperawatan : Nyeri Kronis

Intervensi utama :

Manajemen Nyeri

Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan.

Tindakan

i. Observasi

- Identifikasi karakteristik durasi frekuensi kualitas intensitas nyeri
- Identifikasi skala nyeri
- Identifikasi nyeri nonverbal
- Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri
- Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- Identifikasi penangan nyeri pada kualitas hidup
- Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- Monitor efek samping penggunaan analgetik

ii. Terapi

- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
- Control lingkungan yang memperberat rasa nyeri
- Fasilitasi istirahat dan tidur.

- Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri
 - iii. Edukasi
 - Jelaskan penyebab dan pemicu nyeri
 - Jelaskan strategi meredakan nyeri
 - Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
 - Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat
 - Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
 - iv. Kolaborasi
 - Kolaborasi pemberian analgetik bila perlu
- c. Diagnosa Keperawatan : Intoleransi aktivitas
- Intervensi utama :
- Manajemen energi
- Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi untuk mengatasi dan mencegah kelelahan dan mengoptimalkan proses pemulihan
- Tindakan :
- i. Observasi
 - Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan
 - Monitor kelelahan fisik dan emosional
 - Monitor pola dan jam tidur
 - Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas
 - ii. Terapi
 - Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus
 - Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif
 - Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan
 - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan.
 - iii. Edukasi
 - Anjurkan tirah baring
 - Anjurkan aktivitas bertahap
 - Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan kelelahan tidak berkurang
 - Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan
 - iv. Kolaborasi
 - Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.

d. Diagnosa Keperawatan : Resiko Infeksi

Intervensi utama :

Manajemen imunisasi / vaksinasi

Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola pemberian kekebalan tubuh secara aktif dan pasif

Tindakan :

i. Observasi

- Identifikasi riwayat kesehatan dan alergi
- Identifikasi kontra indikasi pemberian imunisasi (mis. Reaksi anafilaksis terhadap vaksin sebelumnya atau sakit parah dengan atau tnpa demam)
- Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan

ii. Terapeutik

- Berikan suntikan pada bayi dibagian paha anterolateral
- Dokumentasikan informasi vaksinasi
- Jadwalkan imunisasi pada interval waktu yang tepat

iii. Edukasi

- Jelaskan tujuan, manfaat reaksi yang terjadi, jadwal dan efek samping
- Informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah.
- Informasikan imunisasi yang melindungi terhadap penyakit namun saat ini tidak diwajibkan pemerintah.
- Informasikan imunisasi untuk kejadian khusus
- Informasikan penunda pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi kembali
- Informasikan penyedia layanan pekan imunisasi nasional yang menyediakan vaksin gratis.

4. Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan kegiatan yang dilakukan seorang perawat untuk membantu seorang pasien terhadap masalah status kesehatan pasien yang dihadapi dengan baik dengan kriteria hasil yang diharapkan.

a. Diagnosa keperawatan: Defisit Nutrisi

Implementasi Manajemen nutrisi

i. Mengobservasi

- Mengidentifikasi status nutrisi; mengukur TB, BB dan IMT pasien

- Mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan; menanyakan pasien adakah jenis makanan yang membuat alergi.
- Mengidentifikasi makanan yang disukai; dengan menanyakan pada pasien makanan yang disukai pasien
- Mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient; menghitung kebutuhan kalori pasien dan jenis nutrient yang dibutuhkan pasien.
- Mengidentifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric: bila memang intake oral tidak adekuat
- Memonitor asupan makanan; mengobservasi banyaknya porsi makan yang dihabiskan pasien
- Memonitor berat badan; cek BB pasien setiap 2 hari sekali
- Memonitor hasil pemeriksaan laboratorium; melakukan pemeriksaan Hb, serum albumin dan globulin

ii. Memberikan Terapi

- Melakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu dengan cara sikat gigi atau kumur-kumur dengan listerine
- Memfasilitasi menentukan pedoman diet
- Menyajikan makanan secara menarik dan suhu makanan dalam keadaan hangat
- Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- Memberikan makanan tinggi kalori dan protein
- Memberikan suplemen makanan jika perlu
- Menghentikan pemberian makan melalui selang NGT, jika asupan oral dapat ditoleransi

iii. Memberikan Edukasi

- Mengajarkan posisi duduk jika mampu dengan memberi motivasi agar dilakukan secara bertahap
- Mengajarkan diet yang diprogramkan terutama diet Hati

iv. Berkolaborasi

- Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu terapi anti emetik
- Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrient yang dibutuhkan jika perlu.

b. Diagnosa Keperawatan: Nyeri Kronis

Implementasi Manajemen Nyeri

i. Mengobservasi

- Mengidentifikasi karakteristik durasi frekuensi kualitas intensitas nyeri; menanyakan berapa lama nyeri dirasakan, apa yang

memperberat dan memperingan rasa nyerinya, seperti apakah nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusukkah

- Mengidentifikasi skala nyeri; menanyakan tingkat keparahan pasien dengan menggunakan skala numerik.
- Mengidentifikasi nyeri nonverbal; memperhatikan ekspresi wajah pasien saat merasakan nyeri
- Mengidentifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri; menanyakan saat aktivitas seperti apakah nyeri itu datang dan berkurang keluhan.
- Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri; dengan menanyakan pasien tentang akibat nyeri yang dirasakan.
- Mengidentifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri; menanyakan pasien solusi yang biasa dilakukan untuk mengurangi keluhan.
- Mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup; menanyakan sejauh mana keluhan mengganggu aktivitas pasien sehari-hari terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- Memonitor efek samping penggunaan analgetik; menanyakan berapa lama keluhan nyeri hilang bila sudah minum obat.

ii. Memberikan Terapi

- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan teknik relaksasi nafas dalam atau teknik distraksi.
- Mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri
- Memfasilitasi istirahat dan tidur; anjurkan segera tidur untuk merileksasikan tubuh sehingga bias mengurangi keluhan.
- Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

iii. Memberi Edukasi

- Menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri; penyebab dari munculnya nyeri yang dirasakan
- Menjelaskan strategi meredakan nyeri; dengan relaksasi dan mengurangi aktivitas
- Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri; dengan memeriksa nadi secara mandiri
- Menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat
- Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

- iv. Berkolaborasi
 - berkolaborasi pemberian analgetik bila perlu
- c. Diagnosa Keperawatan : Intoleransi aktivitas
Implementasi Manajemen energi
 - i. Mengobservasi
 - Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan; menanyakan bagian tubuh mana yang dirasakan lemas atau terasa lelah
 - Memonitor kelelahan fisik dan emosional; aktivitas seperti apakah yang dirasakan pasien
 - Memonitor pola dan jam tidur; melihat aktivitas istirahat pasien
 - Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas
 - ii. Memberikan Terapi
 - Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus; menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi pasien dengan memudahkan pasien dalam beraktivitas bebas hambatan
 - Melakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif secara rutin pagi dan sore untuk menghindari kekakuan pada sendi
 - Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan
 - Memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan, dengan melakukan secara bertahap
 - iii. Memberi Edukasi
 - Menganjurkan tirah baring
 - Menganjurkan aktivitas bertahap
 - Menganjurkan menghubungi perawat jika tanda dan kelelahan tidak berkurang
 - Mengajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan
 - iv. Berkolaborasi
 - berkolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan
- d. Diagnosa Keperawatan : Resiko Infeksi
Implementasi Manajemen imunisasi / vaksinasi
 - i. Mengobservasi
 - Mengidentifikasi riwayat kesehatan dan alergi; adakah pasien mempunyai alergi dengan jenis-jenis obat-obatan.

- Mengidentifikasi kontra indikasi pemberian imunisasi (mis. Reaksi anafilaksis terhadap vaksin sebelumnya atau sakit parah dengan atau tanpa demam)
 - Mengidentifikasi status imunisasi setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan; menanyakan pada keluarga untuk pasien bayi dan balita tentang imunisasi yang sudah didapat.
- ii. Memberikan Terapi
- Memberikan suntikan pada bayi dibagian paha anterolateral
 - Mendokumentasikan informasi vaksinasi
 - Membuat jadwal imunisasi pada interval waktu yang tepat
- iii. Memberi Edukasi
- Menjelaskan tujuan, manfaat reaksi yang terjadi, jadwal dan efek samping
 - Memberi Informasi imunisasi yang diwajibkan pemerintah.
 - Memberi Informasi imunisasi yang melindungi terhadap penyakit namun saat ini tidak diwajibkan pemerintah.
 - Memberi Informasi imunisasi untuk kejadian khusus
 - Memberi Informasi penunda pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi kembali
 - Memberi Informasi penyedia layanan pekan imunisasi nasional yang menyediakan vaksin gratis.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dari suatu proses keperawatan, evaluasi mengacu pada tujuan akhir dari diagnose keperawatan. Jenis evaluasi keperawatan ada 2 jenis yaitu evaluasi sumatif dan formatif.

Evaluasi yang diharapkan pada pasien dengan hepatitis yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan akan didapatkan nutrisi yang adekuat penting untuk fungsi imun dan penyembuhan pasien yang mengalami hepatitis kronik maupun akut, keluhan nyeri pada pasien berkurang atau hilang ditandai dengan adanya indikator penurunan skala nyeri, dan TTV normal, untuk intoleransi aktivitas diharapkan periode istirahat adekuat dan adanya pembatasan aktivitas kebutuhan sehari-hari pasien dapat teratasi, dan resiko infeksi tidak terjadi sehingga dapat penyebaran infeksi. (Priscilla LeMone et all, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, P. N., Setiawan, H., Harun, S., & Kunci, K. (2021). Prevalensi Infeksi Hepatitis B Pada Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Klinik Utama Satria Medika Sakti. Pendahuluan Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati . Penyakit ini dapat disebabkan oleh Virus Hepatitis B telah menginfeksi 240 juta orang secara. *Anakes: Jurnal Ilmiah Analis Kesehatan*, 7(2), 141–147.
- Joice M Black. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah* (8th ed.). Elsevier.
- L.O, E. S., Widyarni, A., & Noorhidayah. (2021). Hubungan Pekerjaan dan Jarak Pelayanan Kesehatan terhadap Peningkatan Kasus Penyakit Hepatitis B pada Ibu Hamil. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 4(4), 464–469. <https://doi.org/10.56338/mppki.v4i4.1865>
- Priscilla LeMone et all. (2019). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*.
- R Sjamsulhidayat dkk. (2013). *Buku Ajar Ilmu Bedah* (R Sjamsulhidayat dkk (ed.); 3rd ed.). EGC Jakarta.
- Riskesdas. (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)*. Kemenkes RI.
- Sari, H. P., Indriastuti, D., Asrul, M., & Elyasari. (2019). Perbedaan Pengetahuan Pre Dan Post Pendidikan Kesehatan Pada. *Jurnal Keperawatan*, 2(3), 9–16.
- TIM POKJA SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*.
- TIM POKJA SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*.
- Wahyudi, H. (2017). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka - HEPATITIS. *Convention Center Di Kota Tegal*, 6.
- WHO. (2019). *Hepatitis A-World Health Organization*. WHO.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA KOLELITIASIS

Nian Afrian Nuari,S.Kep,Ns,M.Kep



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEPERAWATAN PADA KOLELITIASIS

Penulis: Nian Afrian Nuari,S.Kep,Ns,M.Kep

A. KONSEP DASAR MEDIK

1. Pendahuluan

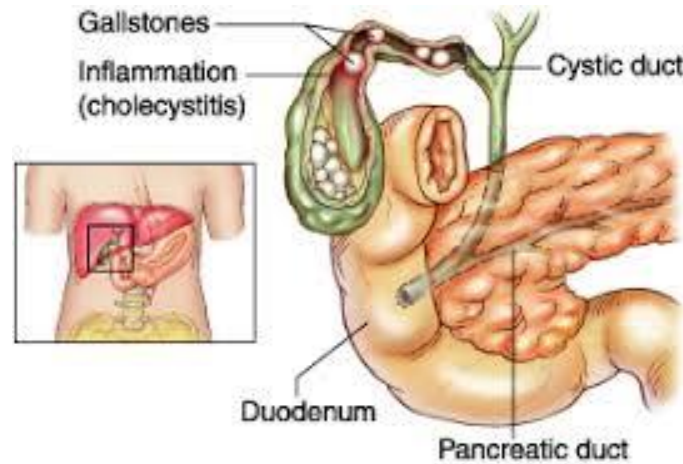
Penyakit batu empedu adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling umum di Amerika Serikat. Sekitar 10%–20% populasi dewasa nasional saat ini membawa batu empedu, dan prevalensi batu empedu meningkat. Selain itu, hampir 750.000 kolesistektomi dilakukan setiap tahun di Amerika Serikat; biaya langsung dan tidak langsung dari operasi kandung empedu diperkirakan mencapai \$6,5 miliar. Kolelitiasis juga sangat terkait dengan kejadian kanker kandung empedu, pankreas, dan kolorektal. Selain itu, National Institutes of Health memperkirakan bahwa hampir 3.000 kematian (0,12% dari semua kematian) per tahun disebabkan oleh komplikasi kolelitiasis dan penyakit kandung empedu. Meskipun penelitian ekstensif telah mencoba untuk mengidentifikasi faktor risiko cholelithiasis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa temuan definitif masih sulit dipahami. Dalam review ini, faktor predisposisi untuk cholelithiasis diidentifikasi, patofisiologi penyakit batu empedu dijelaskan, dan pilihan pencegahan nonsurgical dibahas. Memahami faktor risiko kolelitiasis mungkin tidak hanya berguna dalam membantu perawat menyediakan sumber daya dan pendidikan bagi pasien yang didiagnosis dengan batu empedu, tetapi juga dalam mengembangkan tindakan pencegahan baru untuk penyakit ini (Pak M & Lindseth G, 2016).

Batu empedu memengaruhi 10%–15% populasi orang dewasa (lebih dari 6 juta pria dan 14 juta wanita) di Amerika Serikat (AS) Pada tahun 2009, batu empedu menyumbang lebih dari 300.000 kunjungan dokter dan diagnosis debit gastrointestinal kedua yang paling umum di rawat inap AS (Peery et al., 2012). Secara tradisional, usia, jenis kelamin perempuan, dan obesitas dianggap sebagai faktor risiko utama penyakit batu empedu kolesterol. Meskipun merupakan salah satu gangguan gastrointestinal yang paling umum, etiologi dan patofisiologi penyakit batu empedu masih belum sepenuhnya dipahami. Untuk mengidentifikasi strategi pencegahan dengan lebih baik, artikel ini mengulas literatur yang menjelaskan faktor predisposisi penyakit batu empedu dan risiko yang akan datang untuk kolelitiasis, kolesistektomi, dan komplikasi penyakit lainnya (Pak M & Lindseth G, 2016).

2. Definisi

Kolelitiasis adalah penyakit dengan keadaan dimana terdapat atau terbentuk batu empedu, bisa terdapat dalam kandung empedu atau dalam duktus choledochus (choledocholithiasis) (Patrick C. D. Gagola, dkk. 2015). Jadi,

batu empedu atau kolelitiasis merupakan keadaan terdapat batu empedu dari unsur – unsur padat yang membentuk cairan empedu, ditemukan didalam kandung empedu atau dalam duktus koledokus.



Gambar 1. Kolelitiasis
(Dikutip dari Silbernagl, S., & Lang, F, 2017)

3. Klasifikasi

Menurut gambaran makroskopis dan komposisi kimianya, batu empedu di golongan atas 3 golongan:

- 1) Batu kolesterol
Berbentuk oval, multifokal atau mulberry dan mengandung lebih dari 70% kolesterol
- 2) Batu kalsium bilirubinan (pigmen coklat)
Berwarna coklat atau coklat tua, lunak, mudah dihancurkan dan mengandung kalsium-bilirubin sebagai komponen utama.
- 3) Batu pigmen hitam.
Berwarna hitam atau hitam kecoklatan, tidak berbentuk, seperti bubuk dan kaya akan sisa zat hitam yang tak terekstraksi.

Menurut Black menambahkan ada tiga tipe utama batu empedu, yaitu:

- 1) Batu pigmen, kemungkinan terbentuk bila pigmen tak terkonjugasi dalam empedu melakukan pengendapan sehingga terjadi batu.
- 2) Batu kolestrol. Terjadi akibat konsumsi makanan berkolesterol seperti fast food dengan jumlah tinggi.
- 3) Batu campuran. Batu campuran dapat terjadi akibat kombinasi antara batu pigmen dan batu kolesterol atau salah satu dari batu dengan beberapa zat lain seperti kalsium karbonat, fosfat, dan garam empedu (Nuari, NA, 2015).

4. Etiologi

Kolelitiasis dapat terjadi dengan atau tanpa faktor risiko dibawah ini. Namun, semakin banyak faktor risiko yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan untuk terjadinya kolelitiasis. Faktor risiko tersebut antara lain :

a. Jenis Kelamin.

Wanita mempunyai risiko 3 kali lipat untuk terkena kolelitiasis dibandingkan dengan pria. Ini dikarenakan oleh hormon esterogen berpengaruh terhadap peningkatan ekskresi kolesterol oleh kandung empedu. Kehamilan, yang meningkatkan kadar esterogen juga meningkatkan risiko terkena kolelitiasis. Penggunaan pil kontrasepsi dan terapi hormon (esterogen) dapat meningkatkan kolesterol dalam kandung empedu dan penurunan aktivitas pengosongan kandung empedu.

b. Usia.

Risiko untuk terkena kolelitiasis meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Orang dengan usia > 60 tahun lebih cenderung untuk terkena kolelitiasis dibandingkan dengan orang dengan usia yang lebih muda.

c. Berat badan (BMI).

Orang dengan Body Mass Index (BMI) tinggi, mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadi kolelitiasis. Ini dikarenakan dengan tingginya BMI maka kadar kolesterol dalam kandung empedu pun tinggi, dan juga mengurangi garam empedu serta mengurangi kontraksi/ pengosongan kandung empedu.

Obesitas, yang berkorelasi positif dengan indeks massa tubuh (BMI), juga merupakan faktor risiko batu empedu yang terkenal. Studi kohort prospektif melaporkan hubungan positif antara pembentukan batu empedu dan adipositas sentral, relatif terhadap adipositas ekstremitas atas dan bawah; distribusi lemak regional dengan demikian dapat memperburuk risiko batu empedu lebih jauh. Sebuah studi kohort besar terhadap 77.679 pasien mengkonfirmasi hubungan yang erat (pada kedua jenis kelamin, tetapi terutama pada wanita) antara peningkatan BMI dan peningkatan risiko penyakit batu empedu simtomatik (Stender et al., 2013).

d. Makanan.

Intake rendah klorida, kehilangan berat badan yang cepat (seperti setelah operasi gastrointestinal) mengakibatkan gangguan terhadap unsur kimia dari empedu dan dapat menyebabkan penurunan kontraksi kandung empedu.

e. Riwayat keluarga.

Orang dengan riwayat keluarga kolelitiasis mempunyai risiko lebih besar dibandingkan dengan tanpa riwayat keluarga.

f. Aktivitas fisik.

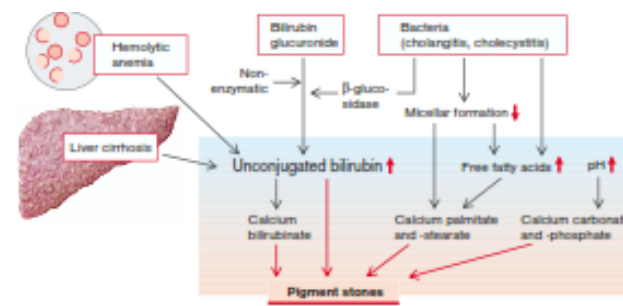
Kurangnya aktivitas fisik berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya kolelitiasis. Ini mungkin disebabkan oleh kandung empedu lebih sedikit berkontraksi.

g. Penyakit usus halus.

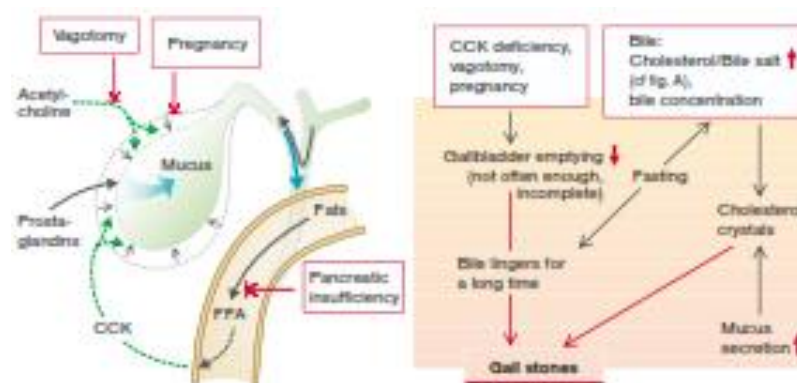
Penyakit yang dilaporkan berhubungan dengan kolelitiasis adalah crohn disease, diabetes, anemia sel sabit, trauma, dan ileus paralitik.

h. Nutrisi intravena jangka lama.

Nutrisi intravena jangka lama mengakibatkan kandung empedu tidak terstimulasi untuk berkontraksi, karena tidak ada makanan/ nutrisi yang melewati intestinal. Sehingga risiko untuk terbentuknya batu menjadi meningkat dalam kandung empedu.



Gambar 2. Proses terjadinya batu pigmen
(Dikutip dari Silbernagl, S., & Lang, F, 2017)

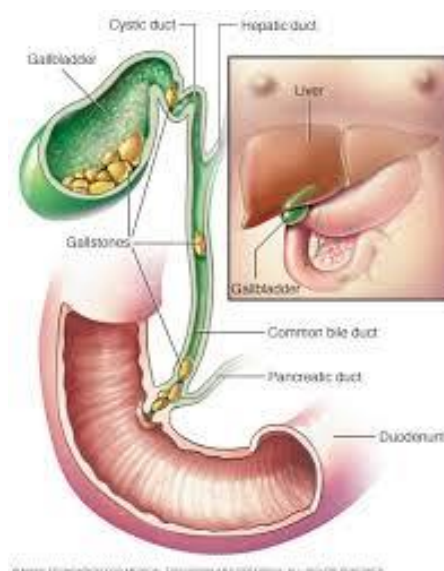


Gambar 3. Penyebab Kolelitiasis
(Dikutip dari Silbernagl, S., & Lang, F, 2017)

5. Patofisiologi

Berdasarkan berbagai teori, ada empat penjelasan yang mungkin untuk pembentukan batu empedu, yaitu:

- Perubahan komposisi empedu. Perubahan komposisi ini membentuk inti, lalu lambat laun menebal dan mengkristal. Proses pengkristalan dapat berlangsung lama, bisa sampai bertahun-tahun dan akhirnya akan menghasilkan batu empedu.
- Adanya peradangan pada empedu. Peradangan empedu dalam kandung empedu dapat mengakibatkan supersaturasi progresif, perubahan susunan kimia, dan pengendapan beberapa unsur konstituen empedu seperti kolesterol, kalsium, bilirubin.
- Adanya proses infeksi. Infeksi bakteri dalam saluran empedu dapat berperan sebagian dalam pembentukan batu, melalui peningkatan deskuamasi sel dan pembentukan mukus. Mukus meningkatkan viskositas dan unsur seluler atau bakteri dapat berperan sebagai pusat presipitasi. Adanya proses infeksi ini terkait mengubah komposisi empedu dengan meningkatkan reabsorpsi garam empedu dan lesitin.
- Genetik. Salah satu faktor genetik yang menyebabkan terjadinya batu empedu adalah obesitas karena orang dengan obesitas cenderung mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Kolesterol tersebut dapat mengendap di saluran pencernaan juga di saluran kantung empedu, yang lama kelamaan akan berubah menjadi batu empedu



Gambar 4. Batu empedu
(Dikutip dari Silbernagl, S., & Lang, F, 2017)

6. Manifestasi Klinik

- a. Perubahan warna urin dan feses
Ekskresi pigmen empedu oleh ginjal akan membuat urin berwarna sangat gelap. Feses yang tidak lagi diwarnai oleh pigmen empedu akan tampak kelabu, dan biasanya pekat yang disebut “clay-colored”.
- b. Ikterus
Perubahan warna kulit, membran mukosa lain dan sklera menjadi warna kuning.
- c. Rasa nyeri
Pasien mungkin akan merasa nyeri pada abdomen kanan atas yang dapat menjalar ke punggung dan bahu kanan disertai dengan mual dan muntah, dan akan merubah posisinya secara terus-menerus untuk mengurangi intensitas nyeri (Nuari, NA, 2015).

7. Komplikasi

Komplikasi yang muncul pada pasien batu empedu meliputi :

- a. Kolik Bilier
Kolik yang diakibatkan oleh obstruksi transien dari batu empedu merupakan keluhan utama pada 70-80% pasien. Nyeri kolik disebabkan oleh spasme fungsional di sekitar lokasi obstruksi. Nyeri kolik mempunyai karakteristik spesifik; nyeri yang dirasakan bersifat episodik dan berat, lokasi di daerah epigastrium, dapat juga dirasakan di daerah kuadran kanan atas, kuadran kiri, prekordium, dan abdomen bagian bawah. Onset nyeri tiba-tiba dan semakin memberat pada 15 menit pertama dan berkurang hingga tiga jam berikutnya. Resolusi nyeri lebih lambat. Nyeri dapat menjalar hingga region interskapular, atau ke bahu kanan.
- b. Kolesistitis kronik
Diagnosis yang tidak pasti yang ditandai dengan nyeri perut atas kanan yang bersifat intermiten, distensi, flatulens, dan intoleransi makanan berlemak, atau apabila mengalami kolesistitis episode ringan yang berulang.
- c. Kolesistitis obstruktif akut
Ditandai dengan nyeri konstan pada hipokondrium kanan, pireksia, mual, dapat atau tidak disertai dengan jaundice, Murphy sign positif (nyeri di kuadran atas kanan), leukositosis.
- d. Kolangitis
Kolangitis akut adalah kondisi sistemik yang berpotensi mengancam jiwa akibat infeksi saluran empedu, yang seharusnya steril, dan disebabkan karena obstruksisaluran bilier, paling sering karena sekun-der oleh obstruksi sebagian atau kompli pada duktus bilier atau duktus hepaticus.

Kondisi ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1877 oleh Charcot dengan trias nyeri perut kanan atas, demam, dan jaundice (trias Charcot). Diagnosis ditegakkan berdasarkan pada karakteristik gejala klinis dan tanda-tanda infeksi, laboratorium yang mendukung adanya infeksi dan sumbatan, serta pemeriksaan imaging yang mendukung adanya obstruksi bilier. Kondisi ini dapat ditangani dengan baik dengan terapi secara tepat, tetapi angka kematian dapat menjadi tinggi bila penanganan terlambat. Ditandai dengan nyeri abdominal, demam tinggi, obstruktif jaundice (Charcot's triad), nyeri hebat pada kuadran atas kanan (Irawaty, A., & Rotty, L., 2019).

e. Jaundice obstruktif

Ditandai nyeri abdominal atas, warna feses pucat, urin berwarna gelap seperti teh pekat, dan adanya pruritus. Jaundice obstruktif dapat berujung ke kolangitis bila saluran bersama tetap terjadi obstruksi (Irawaty, A., & Rotty, L., 2019).

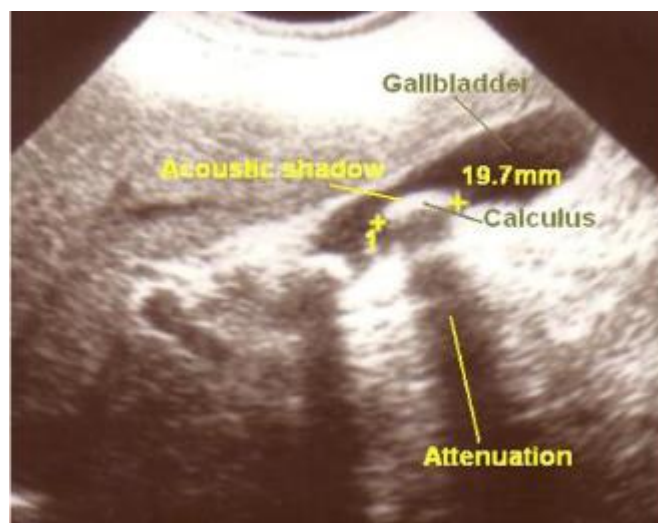
8. Pemeriksaan Penunjang

Batu pada kandung empedu maka pada pemeriksaan fisik akan ditemukan Murphy sign positif yaitu apabila penderita merasakan nyeri tekan dan bertambah sewaktu penderita menarik nafas panjang. Batu pada saluran empedu biasanya tidak menimbulkan gejala namun akan teraba saat perabaan hepar dan apabila sumbatan saluran empedu bertambah berat maka akan timbul ikterus klinis (Attara, RA et al, 2022). Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi yang meliputi:

- a. Pemeriksaan laboratorium akan ditemukan kenaikan serum kolesterol, kenaikan fosfolipid, penurunan ester kolesterol, kenaikan protrombin serum time, penurunan urobilinogen, peningkatan sel darah putih, dan peningkatan serum amilase, selain itu apabila terjadi sindroma Mirizzi akan ditemukan kenaikan ringan bilirubin serum akibat penekanan duktus koledokus oleh batu.
- b. Pemeriksaan foto polos abdomen biasanya tidak memberikan gambaran yang khas dikarenakan hanya sekitar 10-15% batu kandung empedu yang bersifat radiopak.
- c. Pemeriksaan USG mempunyai kadar spesifitas yang tinggi dan sensitifitas 96% untuk mendeteksi kolesistitis. Pemeriksaan USG juga dapat mendeteksi batu berukuran 2mm dan membedakan adanya penebalan dinding kandung empedu karena proses inflamasi.



Gambar 4. Hasil USG Kolelitiasis
(Dikutip dari Gagola,P, et al, 2015)



Gambar 5. Foto abdomen Kolelitiasis
(Dikutip dari Gagola,P, et al, 2015)

- d. Pemeriksaan kolesistografi oral merupakan pemeriksaan terbaik untuk mengetahui jenis batu, namun pemeriksaan akan gagal pada keadaan ileus parolitik, muntah, kadar bilirubin serum diatas 2 mg/dl, obstruksi pylorus dan hepatitis, dikarenakan pada keadaan tersebut kontras tidak dapat mencapai hati.
- e. Pemeriksaan sonogram dapat menentukan apakah dinding kandung empedu menebal.
- f. Pemeriksaan Endoscopic Retrograde Colangiopancreatografi (ERCP) memungkinkan visualisasi struktur secara langsung dan hanya dapat dilihat pada saat laparotomi. Pemeriksaan ini meliputi insersi endoskopiserat optik yang fleksibel ke dalam esofagus sampai mencapai duodenum pars desendens. Sebuah kanula dimasukanke dalam duktus koleduktus dan duktus pankreatikus kemudian bahan kontras disuntikan ke dalam duktus

untuk menentukan keberadaan batu dan memungkinkan visualisasi serta evaluasi percabangan bilier (Attara, RA et al, 2022).

9. Penatalaksanaan

Tatalaksana kolelitiasis dibedakan menjadi 2 yaitu penatalaksanaan non bedah dan bedah (Attara, RA et al, 2022):

- a. Penatalaksanaan non bedah dapat dilakukan dengan penatalaksanaan pendukung dan diet, 80% pasien kolelitiasis sembuh dengan istirahat, cairan infus, penghisapan nasogastrik, analgesik dan antibiotik.
- b. Oral dissolution therapy yaitu penghancuran batu dengan pemberian obat oral, pemberian obat ini dapat menghancurkan batu pada 60% pasien kolelitiasis, kriteria disolusi media adalah diameter batu <20mm, batu kurang dari 4 batu, fungsi kandung kemih baik dan duktus sistik paten, namun pada anak-anak terapi ini tidak dianjurkan kecuali anak dengan risiko tinggi untuk menjalani operasi.
- c. Disolusi kontak yaitu cara untuk menghancurkan batu dengan memasukan cairan pelarut ke dalam kandung empedu melalui kateter perkutaneus melalui hepar atau kateter nasobilier, larutan yang dipakai adalah methyl tertbutyl eteryang dimasukan ke dalam kandung empedu dan mampu menghancurkan batu empedu dalam 24 jam.
- d. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) yaitu menggunakan gelombang suara amplitudo tinggi untuk menghancurkan batu, namun pada anak-anak metode ini tidak direkomendasikan karena angka kekambuhan tinggi (Yusuf, 2021).

Kolesistektomi dianggap sebagai pengobatan standar untuk kolelitiasis simtomatik, dan merupakan salah satu operasi yang paling umum di AS; lebih dari 750.000 dilakukan setiap tahun. Beberapa studi longitudinal telah menunjukkan hasil yang bertentangan setelah operasi kandung empedu yang meliputi kanker usus besar, tumor pada kerongkongan, usus kecil dan usus besar proksimal, dan adenoma usus besar lanjut. Namun penelitian lain telah melaporkan bahwa tingkat kejadian tumor akibat operasi kolesistektomi rendah. Selain itu, komplikasi telah diamati pada hampir 20% kolesistektomi laparoskopik yang dilakukan pada orang dewasa yang lebih tua. Meskipun 80% pasien dengan batu empedu tidak menunjukkan gejala, sebagian besar batu terdeteksi secara kebetulan selama pemeriksaan medis rutin atau tidak terkait. Namun, pada populasi umum, 10% -25% dari batu empedu asimtomatik dapat berkembang menjadi kolesistitis, kolangitis, atau pankreatitis di beberapa titik selama masa hidup pasien.

Tatalaksana bedah terbagi menjadi kolisistektomi terbuka dan kolisistektomi laparoskopi.

- a. Kolisistektomi terbuka merupakan standar terbaik untuk pasien dengan kolelitiasis simtomatik, komplikasi yang dapat terjadi adalah cedera duktus biliaris dan indikasi paling umum adalah kolik biliaris rekuren diikuti oleh kolesistitis akut.
- b. Indikasi kolisistektomi laparoskopi adalah pasien dengan kolelitiasis simtomatik tanpa adanya kolesistitis akut. Kolisistektomi merupakan baku emas (gold standard) untuk tata laksana kolelitiasis dengan gejala (Attara, RA et al, 2022).

B. KONSEP DASAR KEPERAWATAN

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian kolelitiasis terdiri atas pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik, dan evaluasi diagnostic. Anamnesis adalah tanya jawab atau komunikasi secara langsung dengan klien (auto-anamnesis) maupun tak langsung (allo-anamnesis) dengan keluarganya untuk menggali informasi kesehatan klien. Komunikasi yang digunakan adalah komunikasi terapeutik yaitu suatu pola hubungan interpersonal antara klien dan perawat yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai status kesehatan klien dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada pengkajian psikosial akan didapatkan peningkatan kecemasan, serta perlunya pemenuhan intervensi keperawatan dan pengobatan.

a. Data umum

Data umum memuat biodata pasien terdiri dari: Nama pasien, Ruang (tempat klien menjalani rawat inap), No. Register pasien, Umur, Jenis Kelamin, agama, suku bangsa, bahasa, alamat, pekerjaan, status perkawinan, pendidikan terakhir, golongan darah, tanggal MRS, tanggal pengkajian dan diagnosa medis.

b. Riwayat Kesehatan Pasien

1) Keluhan Utama

Riwayat keluhan utama di gambarkan singkat dan jelas, dua atau tiga kata yang merupakan keluhan yang membuat klien meminta bantuan pelayanan kesehatan. Pada keluhan utama, ditulis keluhan pada saat masuk RS dan pada saat dilakukan pengkajian. Keluhan utama dapat berupa nyeri pada ulu hati, mual, muntah, nafsu makan menurun, dan lemah

2) Riwayat Kesehatan Sekarang

Riwayat kesehatan ini dikaji dari awal adanya keluhan sebelum masuk rumah sakit, keluhan saat dibawa ke RS sampai dengan perjalanan selama

di rawat di RS. Penderita mempunyai manifestasi seperti; nyeri, anoreksia, mual, muntah, ketidaknyamanan abdomen.

3) Riwayat kesehatan dahulu

Riwayat kesehatan dahulu dengan riwayat penyakit yang diderita klien yang berhubungan dengan penyakit saat ini atau penyakit yang mungkin dapat dipengaruhi atau mempengaruhi penyakit yang diderita klien saat ini yang berkaitan dengan penyakit yang pernah diderita sebelumnya bisa yang berkaitan dengan pencernaan, kecelakaan yang pernah dialami termasuk keracunan, prosedur operasi dan perawatan rumah sakit serta perkembangan penyakitnya.

4) Riwayat Kesehatan Keluarga

Pada riwayat ini dikaji berkaitan dengan penyakit keturunan, riwayat penyakit menular dan pola kebiasaan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang berkaitan dengan penyakit pencernaan.

5) Pola kebiasaan Sehari-hari

Kaji yang berkaitan dengan faktor predisposisi timbulnya penyakitnya saat ini seperti:

- a) Pola Nutrisi dan cairan : Jenis makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi pasien sebagai factor predisposisi penyakitnya saat ini seperti makanan berlemak;
- b) Pola eliminasi : Adakah riwayat BAK yang terganggu atau warna urin yang tidak normal;
- c) Pola aktivitas dan latihan: Adakah aktivitas rutin yang dilakukan klien sebelum sakit sampai saat sakit mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali seperti olah raga ;
- d) Pola tidur : Adakah gangguan sulit tidur karena nyeri yang dirasakan bagian abdomen pada malam hari.

c. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik yang didapatkan sesuai dengan tahap klinik kolelitiasis. Pada pemeriksaan fisik focus pad area abdomen akan didapatkan temuan:

- 1) Inspeksi : Icterus di seluruh tubuh, terutama disklera sebagai respon peningkatan bilirubin dalam darah. Urin gelap/ coklat. feces seperti tanah liat, skatore
- 2) Auskultasi: Pada kasus yang parah, suara usus sering tidak didapatkan atau hipoaktif.
- 3) Perkusi : Hipertympani akibat abdominal mengalami kembung
- 4) Palpasi : Distensi abdomen, teraba massa di abdomen atas/ kuadran kanan atas. Nyeri tekan pada abdomen di area kanan atas. Hal ini dapat diperoleh dengan pasien menghirup, sementara pemeriksa tetap menjaga tekanan di bawah kosta kanan.

- d. Riwayat Psikologis dan konsep diri
Kaji yang berkaitan dengan konsep diri pasien atau bagaimana pandangan pasien saat sedang menderita penyakitnya saat ini dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya, meliputi; gambaran diri, peran diri, identitas diri, ideal diri dan harga diri.
- e. Riwayat Pola Nilai dan Kepercayaan/ Spiritual
Kaji yang berkaitan dengan bagaimana pandangan pasien terhadap penyakit yang dideritanya terhadap keyakinan akan kesembuhan dari penyakitnya saat ini dan keikhlasan menerima kondisi saat ini yang datangnya semata-mata dari Tuhan YME.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan Kholelitiasis adalah sebagai berikut: (TIM POKJA SDKI DPP PPNI, 2017)

- a. Nyeri akut berhubungan dengan respons inflamasi bilier, kerusakan jaringan lunak pasca bedah

Definisi: Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari tiga bulan.

Penyebab:

- Agen pencedera fisiologis yaitu seperti inflamasi, iskemia, neoplasma
- Agen pencedera kimiawi yaitu seperti, terbakar, bahan kimia iritan
- Agen pencedera fisik yaitu seperti, abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan.

Gejala dan tanda Nyeri adalah sebagai berikut:

- a) Mayor
 - 1) Subjektif : Mengeluh nyeri
 - 2) Objektif
 - I. Tampak meringis
 - II. Bersifat protektif (misalnya waspada, posisi menghindari nyeri)
 - III. Gelisah
 - IV. Frekuensi nadi meningkat
 - V. Sulit tidur
- b) Minor
 - 1) Subjektif: Tidak ditemukan data subjektif
 - 2) Objektif
 - a) Tekanan darah meningkat
 - b) Pola nafas berubah
 - c) Nafsu makan berubah

- d) Proses berpikir terganggu
- e) Menarik diri
- f) Berfokus pada diri sendiri
- g) Diaforesis

- b. Defisit Nutrisi berhubungan dengan tidak adekuatnya asupan nutrisi.

Definisi : Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.

Penyebab :

- a) Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi
- b) Peningkatan kebutuhan metabolisme
- c) Faktor psikologi (keengganan untuk makan)

Gejala dan Tanda

Mayor ; berat badan menurun minimal 10 % dibawah rentang ideal

Gejala dan Tanda

Minor :

Subyektif:

- a) Cepat kenyang setelah makan
- b) Kram/nyeri abdomen
- c) Nafsu makan menurun

Objektif:

- a) Bising usus hiperaktif
- b) Membrane mukosa pucat
- c) Serum albumin turun
- d) Diare

- c. Hipovolemia berhubungan dengan muntah yang berlebihan

Definisi : Peningkatan volume cairan intravaskular, interstisial, dan / atau intraselular.

Penyebab: Kehilangan cairan aktif, Kegagalan mekanisme regulasi, Peningkatan permeabilitas kapiler, Kekurangan intake cairan dan Evaporasi

Gejala dan Tanda Mayor

Subyektif : (tidak tersedia)

Objektif: Frekuensi nadi meningkat, Nadi teraba lemah, Tekanan darah menurun, Tekanan Nadi menyempit, Turgor kulit menyempit, Membran mukosa kering, Volume urin menurun, Hematokrit meningkat

Gejala dan Tanda Minor

Subyektif: Merasa lemah dan Mengeluh haus

Objektif: Pengisian vena menurun, Status mental berubah, Suhu tubuh meningkat, Konsentrasi urin meningkat, Berat badan turun tiba-tiba.

- d. Intoleransi aktifitas berhubungan dengan kelemahan umum

Definisi : Ketidacukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Penyebab :

- a) Tirah baring
- b) Kelemahan
- c) Mobilitas

Gejala dan Tanda Mayor;

Subyektif ; Mengeluh Lelah

Objektif : Frekuensi jantung meningkat >20 % dari kondisi istirahat.

Gejala dan Tanda Minor;

Subyektif :

- a) Merasa tidak nyaman setelah beraktifitas
- b) Merasa lemah

Obyektif :

- a) Tekanan darah berubah > 20% dari kondisi istirahat
- b) Sianosis

3. INTERVENSI KEPERAWATAN

Merupakan segala treatment yang dikerjakan perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan (TIM POKJA SIKI DPP PPNI, 2018).

- a. Diagnosa Keperawatan: Nyeri akut berhubungan dengan respons inflamasi bilier, kerusakan jaringan lunak pasca bedah

Intervensi utama : **Manajemen Nyeri**

Definisi Manajemen Nyeri: Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan.

Tindakan

- 1) Observasi

- Identifikasi karakteristik durasi frekuensi kualitas intensitas nyeri
- Identifikasi skala nyeri
- Identifikasi nyeri nonverbal
- Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri
- Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- Identifikasi penangaruh nyeri pada kualitas hidup
- Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- Monitor efek samping penggunaan analgetic

- 2) Terapi
 - Berikan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
 - Control lingkungan yang memperberat rasa nyeri
 - Fasilitasi istirahat dan tidur.
 - Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri
 - 3) Edukasi
 - Jelaskan penyebab dan pemicu nyeri
 - Jelaskan strategi meredakan nyeri
 - Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
 - Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat
 - Ajarkan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
 - 4) Kolaborasi: Kolaborasi pemberian analgetik bila perlu
- b. Diagnosa Keperawatan: Defisit Nutrisi berhubungan dengan tidak adekuatnya asupan nutrisi.

Intervensi utama : **Manajemen Nutrisi**

Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang

Tindakan / Intervensi Keperawatan:

- 1) Observasi
 - Identifikasi status nutrisi
 - Identifikasi alergi dan intoleransi makanan
 - Identifikasi makanan yang disukai
 - Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient
 - Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric
 - Monitor asupan makanan
 - Monitor berat badan
 - Monitor hasil pemeriksaan laboratorium
- 2) Terapi
 - Lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu
 - Fasilitasi menentukan pedoman diet
 - Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
 - Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
 - Berikan makanan tinggi kalori dan protein
 - Berikan suplemen makanan jika perlu
 - Hentikan pemberian makan melalui selang NGT, jika asupan oral dapat ditoleransi
- 3) Edukasi
 - Anjurkan posisi duduk jika mampu
 - Ajarkan diet yang diprogramkan

- Kolaborasi
- Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu
- Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrient yang dibutuhkan jika perlu

c. Diagnosa Keperawatan: Hipovolemi berhubungan dengan muntah yang berlebihan.

Intervensi utama : **Manajemen hipovolemi**

Tindakan / Intervensi Keperawatan:

1) Observasi:

- Periksa tanda dan gejala hypovolemia (mis. frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa, kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah)
- Monitor intake dan output cairan

2) Terapeutik:

- Hitung kebutuhan cairan
- Berikan posisi modified trendelenburg
- Berikan asupan cairan oral

3) Edukasi:

- Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral
- Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak

4) Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian cairan IV isotons (mis. NaCl, RL)
- Kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis (mis. glukosa 2,5%, NaCl 0,4%)
- Kolaborasi pemberian cairan koloid (mis. albumin, plasmanate)
- Kolaborasi pemberian produk darah

d. Diagnosa Keperawatan: Intoleransi aktifitas berhubungan dengan kelemahan umum.

Intervensi utama : **Manajemen Energi**

Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi untuk mengatasi dan mencegah kelelahan dan mengoptimalkan proses pemulihan

Tindakan :

1) Observasi

- Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan
- Monitor kelelahan fisik dan emosional
- Monitor pola dan jam tidur
- Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas

2) Terapi

- Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus
- Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif
- Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan
- Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan.

3) Edukasi

- Anjurkan tirah baring
- Anjurkan aktifitas bertahap
- Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan kelelahan tidak berkurang
- Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan

4) Kolaborasi

- Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi Keperawatan yang dilakukan meliputi tindakan mandiri dan kolaborasi Pedoman implementasi keperawatan menurut sebagai berikut (Dermawan, 2012):

- a. Tindakan yang dilakukan konsisten dengan rencana dan dilakukan setelah memvalidasi rencana, Validasi menentukan apakah rencana masih relevan, masalah mendesak, berdasar pada rasional yang baik dan diindividualisasikan. Perawat memastikan bahwa tindakan yang sedang diimplementasikan, baik oleh pasien, perawat atau yang lain, berorientasi pada tujuan dan hasil. Tindakan selama implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan.
- b. Keterampilan interpersonal, intelektual dan teknis dilakukan dengan kompeten dan efisien di lingkungan yang sesuai. Perawat harus kompeten dan mampu melaksanakan keterampilan ini secara efisien guna menjalankan rencana. Kesadaran diri dan kekuatan serta keterbatasan perawat menunjang pemberian asuhan yang kompeten dan efisien sekaligus memerankan peran keperawatan profesional.
- c. Keamanan fisik dan psikologis pasien dilindungi. Selama melaksanakan implementasi, keamanan fisik dan psikologis dipastikan dengan mempersiapkan pasien secara adekuat, melakukan asuhan keperawatan dengan terampil dan efisien, menerapkan prinsip yang baik, mengindividualisasikan tindakan dan mendukung pasien

Tahap-Tahap Implementasi meliputi:

a. Tahap persiapan

Tahap ini meliputi; review antisipasi tindakan keperawatan, mengetahui hal yang mungkin timbul, mempersiapkan peralatan yang diperlukan, membuat lingkungan kondusif, mengidentifikasi aspek hukum dan etik, dan intervensi.

b. Tahap Pelaksanaan

Tindakan pelaksanaan yang dilakukan meliputi: 1) mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada klien tentang keputusan tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat; 2). Memberi kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaannya terhadap penjelasan yang telah diberikan oleh perawat; 3). Menerapkan pengetahuan intelektual dan kemampuan hubungan antar manusia dan kemampuan teknis keperawatan dalam tindakan pelaksanaan keperawatan yang diberikan oleh perawat; 4). Memperhatikan hal-hal pada saat pelaksanaan tindakan adalah energi klien dan pencegahan kecelakaan, komplikasi, rasa aman, privasi, kondisi klien dan respon klien terhadap tindakan yang telah diberikan.

c. Tahap Terminasi

Perawat memperhatikan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan. Meninjau kemajuan klien dari tindakan keperawatan yang telah diberikan dan rapikan peralatan dan lingkungan klien dan lakukan terminasi.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi Keperawatan pada pasien dengan kolelitiasis meliputi evaluasi/ catatan perkembangan yang dialami oleh pasien setelah diberikan implementasi keperawatan. Evaluasi, yaitu penilaian hasil dan proses. Penilaian hasil menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Penilaian proses menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahapan proses mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri (Kurniati, D, 2019).

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan

Evaluasi disusun menggunakan SOAP yang terdiri dari:

- a. S: Ungkapan perasaan atau keluhan yang di keluhkan secara subjektif oleh keluarga setelah di berikan implementasi keperawatan.

- b. O: Keadaan objektif yang dapat diidentifikasi oleh perawat menggunakan pengamatan yang objektif.
- c. A: Analisis perawat setelah mengetahui respon subjektif dan objektif.
- d. P: Perencanaan selanjutnya setelah perawat melakukan analisis.

Tugas dari evaluator adalah melakukan evaluasi, menginterpretasi data sesuai dengan kriteria evaluasi, menggunakan penemuan dari evaluasi untuk membuat keputusan dalam memberikan asuhan keperawatan (Kurniati, D, 2019).

Tahap evaluasi keperawatan meliputi:

- a. Membaca kembali diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, intervensi keperawatan.
- b. Mengidentifikasi tolak ukur keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan, misalnya: Tekanan darah normal 120/80, Mampu mandi sendiri minimal dua kali/hari, Mampu menyebutkan dengan benar minimal tiga cara mencegah penyakit demam berdarah
- c. Mengumpulkan data atau mengkaji ulang pencapaian hasil sesuai dengan tolak ukur keberhasilan atau kesesuaian proses pelaksanaan asuhan keperawatan dengan standar/rencana keperawatan, misalnya hasil pengukuran tekanan darah 100/60, klien Ali hanya mampu mandi sendiri satu kali dalam satu hari atau mampu menyebutkan satu cara pencegahan demam berdarah.
- d. Mengevaluasi pencapaian tujuan dengan cara sebagai berikut: Penilaian hasil, yaitu membandingkan hasil (output) yang dicapai dengan standar/tujuan yang telah ditetapkan (Kurniati, D, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Attara, RA , Syazilia, Mustofa, & TriUmiana Soleha. (2022). Diagnosis and Management Cholelithiasis. *Medical Profession Journal of Lampung*, 12(1), 75-78. <https://doi.org/10.53089/medula.v12i1.401>
- Darmawan, D. (2012). *Proses Keperawatan Penerapan dan Kerangka Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Gagola, P. C. D., Timban, J. F. J., & Ali, R. H. (2015). GAMBARAN ULTRASONOGRAFI BATU EMPEDU PADA PRIA & WANITA DI BAGIAN RADIOLOGI FK UNSRAT BLU RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO PERIODE OKTOBER 2012- OKTOBER 2014. *E-Clinic*, 3(1). <https://doi.org/10.35790/ecl.v3i1.7399>
- Hunziker, *et all*. (2013). *Prevalence and Predictors of Renal Functional Abnormalities of High Grade Vesicoureteral Reflux*. *The Journal Of Urology*, Volume 190, Issue 4, Supplement, Pages 1490–1494. October 2013
- Irawaty, A., & Rotty, L. (2019). Kolangitis Akut dengan Komplikasi Perdarahan Saluran Cerna Bagian Atas dan Peningkatan Ca 19-9: Laporan Kasus. *Medical Scope Journal (MSJ)*, 1(1).
- Kurniati, D. (2019). IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7mv62>
- NANDA Internasional. (2012). *Diagnosa Keperawatan: Definisi dan Klasifikasi*. Jakarta: EGC
- Mansjoer, Arif, dkk. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran edisi 3 jilid 1*. Jakarta: Salemba Medika
- Nuari, NA. 2015. *Asuhan Keperawatan Pada Gangguan Gastrointestinal Dengan Pendekatan Mind Mapping*. Jakarta: Trans Info Media
- Nuari, NA & Widayati, D. 2016. *Gangguan Sistem Perkemihan Dan Penatalaksanaan Keperawatan*. Jogjakarta: Deepublish
- Pak M, Lindseth G. (2016). Risk Factors for Cholelithiasis. *Gastroenterol Nurs*. Jul-Aug;39(4):297-309. doi: 10.1097/SGA.0000000000000235. PMID: 27467059; PMCID: PMC8802735.
- Peery, A. F., Dellon, E. S., Lund, J., Crockett, S. D., McGowan, C. E., Bulsiewicz, W. J., ... & Shaheen, N. J. (2012). Burden of gastrointestinal disease in the United States: 2012 update. *Gastroenterology*, 143(5), 1179-1187.
- Price, S. A & Wilson, L. M. (2015). *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit Edisi 6 Volume 2*. Jakarta: EGC
- Silbernagl, S., & Lang, F. (2017). *Atlas Berwarna Patofisiologi*. Jakarta: EGC.

- Smeltzer, Suzanne C, Brenda G bare, (2012). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: EGC
- Stender, S., Nordestgaard, B. G., & Tybjærg-Hansen, A. (2013). Elevated body mass index as a causal risk factor for symptomatic gallstone disease: a Mendelian randomization study. *Hepatology*, 58(6), 2133-2141.
- Suddart, Brunner. (2012). *Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Vol 2* alih bahasa H. Y. Kuncara, Andry Hartono, Monica Ester, Yasmin Asih. Jakarta: EGC
- Sinto R, Nainggolan G. (2010). *Acute Kidney Injury: Pendekatan Klinis dan Tata Laksana*. Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- St Peter W.L.et al.(2012). *"Chronic Kidney Disease : Issues and Establišing Programs and clinics for Improved Patient Outcomes"*. *Am J Kidney Dis*.41 (5):903-24
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016c). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia : Definisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018b). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Yusuf Y. (2021). Kolelitiasis pada anak. *Majalah Kedokteran Andalas*. 2021;44(3):189-195

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN CARCINOMA COLORECTAL

Ns. ELISABETH WAHYU SAVITRI, M.Kep.



ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN CARCINOMA COLORECTAL

PENULIS: Ns. ELISABETH WAHYU SAVITRI, M.Kep.

A. PENDAHULUAN

Carcinoma Colorectal atau Kanker kolon dan rektum adalah kanker yang menyerang usus besar dan rektum. Penyakit ini adalah kanker peringkat 2 yang mematikan. Usus besar adalah bagian dari Sistem Pencernaan. Usus besar terdiri dari kolon dan rektum. Kanker bila menyerang di kolon, maka disebut kanker kolon, bila mengenai di rektum, maka disebut kanker rektum. Bila mengenai kolon maupun rektum maka disebut kanker kolorektal.

Hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti apa penyebab kanker kolorektal. Tidak dapat diterangkan, mengapa pada seseorang terkena kanker ini sedangkan yang lain tidak. Namun yang pasti adalah bahwa penyakit kanker kolorektal bukanlah penyakit menular.

Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang akan rentan terkena kanker kolorektal yaitu:

1. Usia, umumnya kanker kolorektal menyerang lebih sering pada usia tua. Lebih dari 90 persen penyakit ini menimpa penderita di atas usia 50 tahun dan sekitar 3% kanker ini menyerang penderita pada usia di bawah 40 tahun.
2. Polip kolorektal, adalah pertumbuhan tumor pada dinding sebelah dalam usus besar dan rektum. Sering terjadi pada usia di atas 50 tahun. Kebanyakan polyp ini adalah tumor jinak, tetapi sebagian dapat berubah menjadi kanker. Menemukan dan mengangkat polyp ini dapat menurunkan risiko terjadinya kanker kolorektal.
3. Riwayat kanker kolorektal pada keluarga, bila keluarga dekat yang terkena, maka risiko untuk terkena kanker ini menjadi lebih besar, terutama bila keluarga yang terkena tersebut terserang kanker ini pada usia muda.
4. Kelainan genetik, perubahan pada gen tertentu akan meningkatkan risiko terkena kanker kolorektal.
5. Pernah menderita penyakit sejenis, dapat terserang kembali dengan penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Demikian pula wanita yang memiliki riwayat kanker indung telur, kanker rahim, kanker payudara memiliki risiko yang tinggi untuk terkena kanker ini.
6. Radang usus besar, berupa colitis ulceratif atau penyakit Crohn yang menyebabkan inflamasi atau peradangan pada usus untuk jangka waktu lama, akan meningkatkan risiko terserang kanker kolorektal.

7. Diet, makanan tinggi lemak (khususnya lemak hewan) dan rendah kalsium, folat dan rendah serat, jarang makan sayuran dan buah-buahan, sering minum alkohol, akan meningkatkan risiko terkena kanker kolorektal.
8. Merokok, dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker ini.

Deteksi dini berupa skrining untuk mengetahui kanker kolorektal sebelum timbul gejala dapat membantu dokter menemukan polyp dan kanker pada stadium dini. Bila polyp ditemukan dan segera diangkat, maka akan dapat mencegah terjadinya kanker kolorektal. Begitu juga pengobatan pada kanker kolorektal akan lebih efektif bila dilakukan pada stadium dini. Untuk menemukan polyp atau kanker kolorektal dianjurkan melakukan deteksi dini atau skrining pada orang di atas usia 50 tahun, atau di bawah usia 50 tahun namun memiliki faktor risiko yang tinggi untuk terkena kanker kolorektal seperti yang sudah disebutkan di atas.

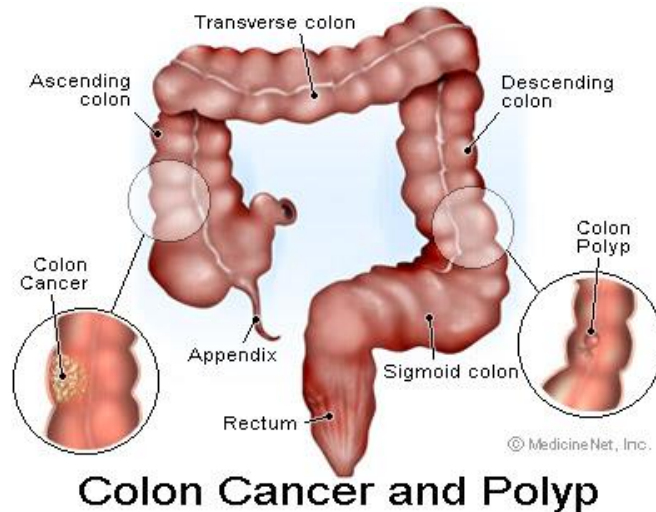
B. KONSEP DASAR MEDIS

1. Definisi

Tumor atau neoplasma berarti pertumbuhan baru, dapat bersifat jinak (benigna) atau ganas (maligna). Jika pertumbuhan massa tersebut maligna/ganas, hal inilah yang dinamakan keganasan/carcinoma/cancer/ca yang dapat diartikan sebagai:

- Massa jaringan abnormal
- Tumbuhnya berlebihan
- Tumbuh terus menerus tidak pernah mati
- Tumbuh tidak terkoordinasi dengan jaringan lain
- Tumbuhnya tidak mempunyai tujuan
- Akibatnya merugikan tubuh dimana ia tumbuh

Jika massa tersebut tumbuh pada saluran pencernaan dalam hal ini bagian colon sampai rectum, keadaan inilah yang disebut Ca Colorectal.

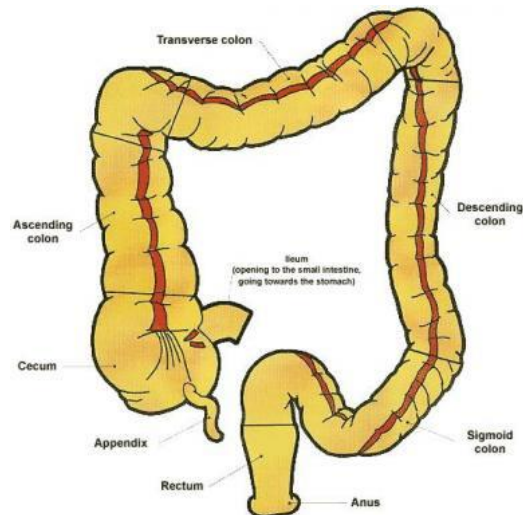


2. Anatomi Fisiologi

Intestinum Crassum dan Rectum Intestinum crassum terdiri dari Caecum, colon ascenden, colon transversum, colon descendens dan colon sigmoideum. Usus besar merupakan tabung muscular berongga dengan panjang sekitar 1,5 meter yang terbentang dari caecum sampai canalis ani. Caecum menempati sekitar 2 atau 3 inci pertama dari usus besar, pada caecum terdapat katub ileosekal dan appendiks yang melekat pada ujung caecum. Katub ileosekal mengontrol aliran kimus dari ileum ke caecum.

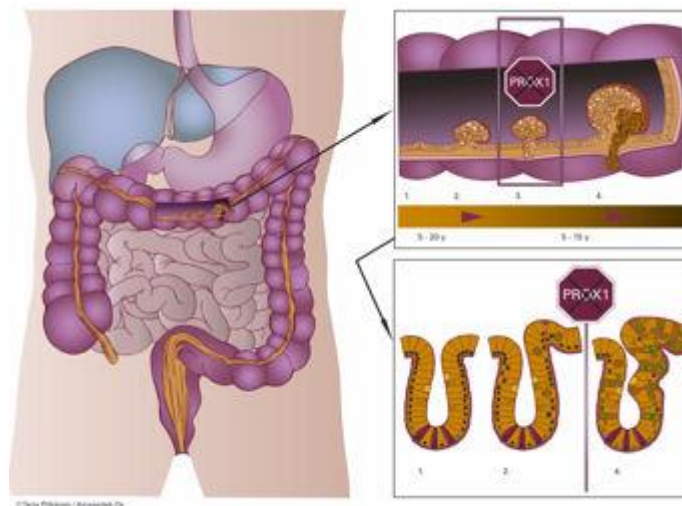
Colon terdiri dari colon ascenden, colon transversum, colon descendens dan colon sigmoideum. Tempat dimana colon membentuk belokan tajam yaitu pada abdomen kanan dinamakan flexura hepática atau flexura colica dektra dan kiri atas dinamakan flexura lienalis atau flexura colica sinistra.

Colon sigmoid mulai setinggi arista iliaca dan berbentuk lekukan seperti huruf S, lekukan bagian bawah membelok kekiri waktu colon sigmoid bersatu dengan rectum.



Bagian utama usus besar yang terakhir dinamakan rectum, yang terbentang dari colon sigmoid sampai anus (Muara bagian luar tubuh). Satu inci terakhir dari rectum dinamakan canalis ani dan dilindungi oleh spingter ani eksternus dan internus. Lapisan otot longitudinal usus besar tidak sempurna, tetapi berkumpul dalam tiga pita yang dinamakan taenia coli.

Taenia bersatu pada sigmoid distal dengan demikian rectum mempunyai satu lapisan otot longitudinal lengkap. Taenia lebih pendek dari usus, hal ini menyebabkan usus tertarik dan berkerut membentuk kantong-kantong kecil peritonium yang berisi lemak dan melekat sepanjang taenia. Lapisan mukosa usus besar jauh lebih tebal dari usus halus dan tidak memiliki vili atau rugae. Kriptus Lieberkuhn (kelenjar intestinal) terletak lebih dalam dan mempunyai lebih banyak sel goblet dari usus halus.



Usus besar secara klinis dibagi menjadi belahan kiri dan kanan, sesuai dengan suplai darah yang diterimanya, yaitu:

- a. Arteri mesenterika superior memperdarahi bagian kanan, yaitu: caecum, colon ascendes dan 2/3 proksimal colon transversum.
- b. Arteri mesenterika inferior memperdarahi bagian kiri, yaitu: 1/3 distal colon transversum, colon descendens, colon sigmoid dan bagian proksimal rectum.
- c. Suplai darah tambahan untuk rectum adalah melalui arteria sakralis media, arteria iliaca interna dan aorta abdominalis.

Usus besar mempunyai fungsi yang paling penting, yaitu mengabsorpsi air dan elektrolit, colon mengabsorpsi kurang lebih 600 ml air/hari (sedangkan usus halus mengabsorpsi 8.000 ml/hari). Kapasitas absorpsi usus besar adalah sekitar 2.000 ml/hari, jika jumlah ini dilampaui misalnya karena adanya diriman yang berlebihan dari ileum, maka akan terjadi diare.

Berat akhir faeses yang dikeluarkan per hari sekitar 200 gram, yang terdiri dari 75% air dan sisanya terdiri dari residu makanan yang tidak diabsorpsi. Sedikitnya pencernaan yang terjadi di usus besar terutama diakibatkan oleh bakteri dan bukan karena kerja enzim, usus besar mengekskresikan mukus alkali yang tidak mengandung enzim. Mukus ini bekerja untuk melumasi dan melindungi mukosa usus besar.

Colon sigmoid berfungsi sebagai reservoir yang menampung massa faeses sampai defekasi berlangsung. Pada umumnya pergerakan usus besar lambat, pergerakan yang khas adalah gerakan mengaduk haustra. Haustra teregang dari waktu ke waktu, otot sirkuler akan berkontraksi untuk mengosongkannya. Pergerakannya tidak progresif tetapi menyebabkan isi usus bergerak bolak-balik dan meremas-remas sehingga memberi cukup waktu untuk absorpsi. Terdapat 2 jenis peristaltik propulsif yaitu:

- a. Kontraksi lamban dan tidak teratur, berasal dari segmen proximal dan bergerak kedepan menyumbat beberapa haustra.
- b. Peristaltik massa, merupakan kontraksi yang melibatkan segmen colon, gerakan peristaltik ini menggerakkan massa faeses kedepan yang akhirnya merangsang defekasi.

Propulsi faeses ke rectum mengakibatkan distensi dinding rectum dan merangsang defekasi, dimana defekasi dikendalikan oleh spingter ani eksterna dan interna. Penyebab utama konstipasi adalah kegagalan pengosongan rectum saat terjadi peristaltik massa. Bila defekasi tidak sempurna, rectum relaksasi dan hasrat untuk defekasi hilang sementara air tetap diabsorpsi dari massa faeses, menyebabkan faeses menjadi keras sehingga defekasi selanjutnya menjadi lebih sukar.

3. Etiologi

Tidak diketahui secara pasti. Diduga ada beberapa faktor yang dapat mempermudah kejadian ini sebagai faktor predisposisi, yaitu kolitis ulseratif, polip colon, riwayat keluarga dengan carsinoma, usia lebih dari 40 tahun, dan kebiasaan makan makanan yang tinggi lemak dan rendah serat (Burkitt, 1971).

Kebiasaan makan/diet tinggi lemak diduga dapat menyebabkan perubahan pada flora usus dan terjadi degradasi garam-garam empedu yang bersifat karsinogenik. Sedangkan diet rendah serat menyebabkan pemekatan zat yang berpotensi karsinogenik (karena diet tinggi lemak) yang ada dalam faeses akan lebih lama diusus. Sehingga zat karsinogenik tersebut lebih lama kontak dengan lapisan/mukosa usus (Price, Pathofisiologi, 1995) yang tentunya akan menyebabkan resiko terjadinya carsinoma pada usus besar menjadi lebih tinggi.

4. Klasifikasi

Penentuan stadium untuk carsinoma colorectal biasanya menggunakan sistem DUKE's atau TNM, yaitu:

- Sistem DUKE's

A = Carsinoma terbatas pada dinding usus

B = Carsinoma menembus lapisan muscularis mukosa

C = Carsinoma metastasis ke kelenjar limfe

C1 = Carsinoma metastasis ke beberapa kelenjar limfe dekat tumor primer.

C2 = Carsinoma metastasis dalam kelenjar limfe jauh

D = Carsinoma metastasis jauh

- T N M

T = TUMOR PRIMER

TX = Tumor primer tidak dapat dinilai

T0 = Tidak ada tumor primer

Tis = Carsinoma in situ

T1 = Invasi tumor dilapisan sub mukosa

T2 = Invasi tumor melewati otot propia

T3 = Invasi tumor melewati otot propia ke sub serosa

T4 = Invasi tumor ke organ/struktur sekitarnya dan peritonium visceral

N = NODUL/KELENJAR LIMFE REGIONAL

NX = Kelenjar limfe regional tidak dapat dinilai

N0 = Tidak didapatkan kelenjar limfe regional

N1 = Metastase di 1-3 kelenjar limfe perikoli atau perirectal

N2 = Metastase di >3 kelenjar limfe perikoli atau perirectal

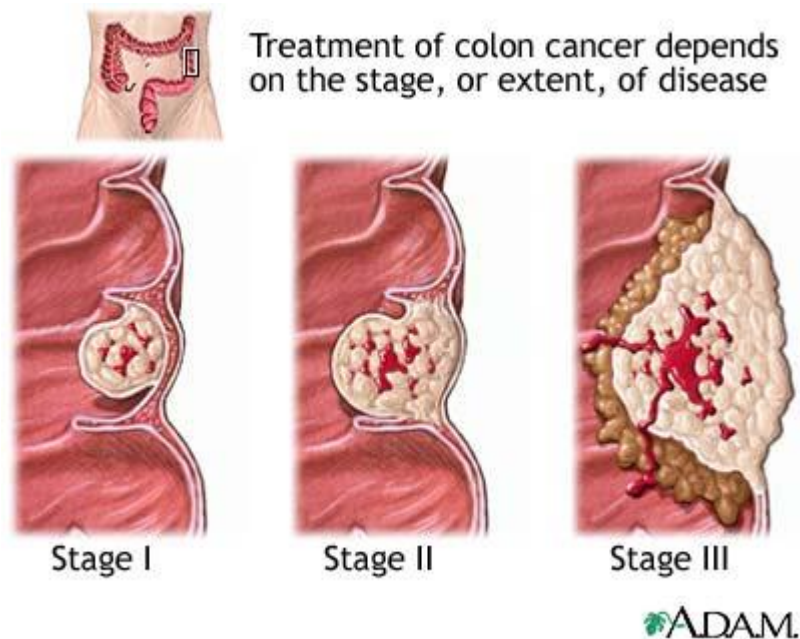
N3 = Metastase pada kelenjar limfe sesuai nama pembuluh darah dan atau pada kelenjar apikal

M = METASTASIS JAUH

MX = Metastase jauh tidak dapat dinilai

M0 = Tidak ada metastase jauh

M1 = Terdapat metastase jauh



5. Patofisiologi

Bagaimana proses terjadinya keganasan pada colorectal ini memang belum diketahui dengan pasti tetapi berbagai ahli menduga keganasan pada colorectal ini berhubungan dengan gaya hidup yang tidak baik/sehat yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak dan rendah serat. Mengapa tinggi lemak dan rendah serat? Makanan tinggi lemak akan merubah flora-flora yang ada pada colon dan menyebabkan degradasi garam-garam empedu sehingga menyebabkan zat tersebut menjadi karsinogenik, ditambah lagi dengan rendah serat yang berpotensi

6. Manifestasi Klinik

Tanda dan gejala yang ditunjukkan pada pasien yang menderita keganasan pada colon kanan dan kiri berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan fisiologi usus besar, yaitu:

Colon Kanan:

- a. Anoreksia
- b. Nausea
- c. Vomiting
- d. Nyeri daerah umbilicus
- e. Penurunan BB
- f. Anemia
- g. Teraba massa di abdomen
- h. Obstruksi jarang dijumpai
- i. Perdarahan tersamar, yang dapat dibuktikan dengan test guaiak atau test benzidine, karena perdarahan tidak dapat dilihat secara langsung seperti pada keganasan colon kiri.
- j. Biasanya pasien yang menderita keganasan pada colon kanan datang pada stadium yang sudah lanjut, karena keluhan yang dirasakan tidak terlalu mengganggu, yaitu khas untuk keganasan pada colon kanan adalah faeses cair – encer (diare), hal ini disebabkan fisiologi colon kanan yaitu sisa metabolisme pada colon kanan masih berbentuk cair.

Colon Kiri:

- a. Perdarahan rectum
- b. Faeses bercampur darah
- c. Tenesmus, rasa belum puas saat BAB dan masih ada rasa ingin buang air besar kembali.
- d. Obstruksi sering dijumpai
- e. Gejala yang juga sering dijumpai adalah faeses berbentuk pita atau pipih, hal ini dapat terjadi jika massa ada pada daerah rectum yang menghambat pengeluaran faeses.
- f. Perubahan pola eliminasi BAB yang khas pada keganasan colon kiri adalah konstipasi, hal ini disebabkan sesuai dengan fisiologi colon kiri yaitu menampung sisa metabolisme yang lebih padat jika dibandingkan dengan colon kanan.

7. Pemeriksaan Diagnostik

- a. **RECTAL TOUCHE** atau colok dubur

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah tumor resectible atau tidak, mobile atau tidak dan menentukan posisi massa. Jika massa ada diatas rectum, maka tidak dapat terdeteksi dengan pemeriksaan ini.

b. **Test guaiak** atau benzidine

Test ini biasanya dilakukan pada keganasan colon kanan, karena perdarahan yang terjadi tersamar dan hanya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan feses pada test ini.

c. Radiologi

Karena keganasan tidak terlihat dengan radiologi biasa, maka pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan zat kontras dengan barium, yang dinamakan barium enema.

d. Colonoscopy

Jika keganasan tidak terlihat jelas dengan radiologi, maka dilakukan pemeriksaan ini untuk visualisasi langsung pada daerah keganasan.

e. USG = Ultra Sonography Graf

f. CT Scan = Computered Tomography Scan

g. Test CEA

Test ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan darah untuk melihat adanya antigen cancer atau Carsinoembryonik Antigen, yang biasanya akan menunjukkan nilai positif artinya ditemukan antigen tersebut pada darah orang yang mengalami keganasan pada colon.

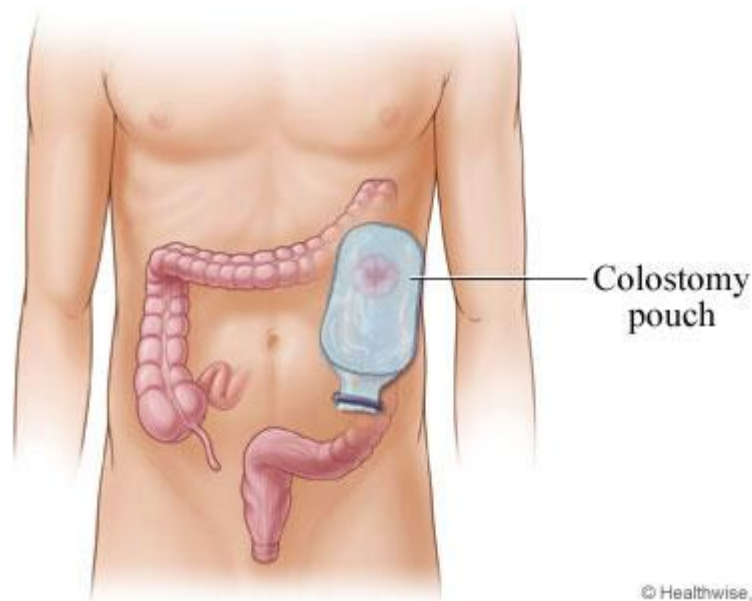
Pemeriksaan ini juga dapat menunjukkan nilai positif pada pasien dengan cancer lainnya, misalnya ca prostat, dll.

8. Penatalaksanaan Medis

a. Pembedahan

Pembedahan ini dilakukan tergantung jenis dan letak keganasan, jika keganasan resectible (dapat dilakukan reseksi atau pengangkatan), maka dapat dilakukan pembedahan dengan pemotongan colon yaitu hemikolektomie kanan pada colon ascendens, kolektomie transversal pada colon tranversum atau abdominoperineal jika keganasan mengenai bagian rectum, kemudian dilakukan pemasangan colostomie tergantung letak pembedahan.

Prognosis setelah pembedahan sangat baik, dibandingkan dengan keganasan yang terjadi pada tubuh lain dengan harapan hidup setelah 5 tahun sebesar 50%. Pada pasien yang mengalami keganasan pada colon sigmoid, jika jarak keganasan tersebut kurang dari 5 cm dari rectum, maka pada operasinya dilakukan pengangkatan rectum yang berarti pasien akan menggunakan colostomy seumur hidupnya dan pasien melakukan perawatan colostomy secara mandiri.



b. Radiasi

Untuk keganasan yang unresectible biasanya dilakukan radiasi atau chemotherapy terlebih dahulu sampai keadaan massanya resectible dan dapat dilakukan pembedahan.

c. Chemotherapy

d. Komplikasi

Keganasan pada colorectal dapat menyebar pada:

e. Prognosis

Lihat pada stadium. Jika pasien mengalami keganasan pada colon sigmoid, jarak keganasan tersebut kurang dari 5 cm dari rectum, maka operasi yang dilakukan dengan mengangkat rectum dan tentu saja pasien ini akan menggunakan colostomy seumur hidupnya dengan demikian pasien ini dapat melakukan perawatan colostomy secara mandiri dan tetap dapat melanjutkan aktivitas (hidupnya).

C. KONSEP DASAR KEPERAWATAN

1. Pengkajian: 11 Pola Gordon

a. POLA PERSEPSI KESEHATAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

- Usia lebih dari 50 tahun
- Riwayat penyakit yang pernah dialami, misalnya polip kolon, colitis ulseratif, dll.
- Data subjektif sebelum sakit, yaitu klien merupakan pekerja berat yang memiliki sedikit waktu untuk makan, sehingga klien mengonsumsi makanan yang cepat saji atau fast food.

- Riwayat menderita kanker terutama pada kolorektal termasuk Riwayat cancer dalam keluarga
- Riwayat merokok
- b. POLA NUTRISI METABOLIK
 - Sering mengkonsumsi makanan yang TINGGI LEMAK dan RENDAH SERAT
 - Mengeluh mual, muntah dan anoreksia
 - Badan terlihat sangat kurus, pucat dan anemis
 - Kehilangan BB dengan cepat dalam waktu singkat
- c. POLA ELIMINASI
 - **Tenesmus**, yaitu rasa tidak tuntas setelah buang air besar atau rasa ingin buang air besar kembali.
 - Faeses bercampur darah
 - Feses berbentuk pita/pipih, jika keganasan di daerah rectum.
 - Teraba massa pada daerah abdomen
 - Jika BAB feses selalu cair/tidak berbentuk pada keganasan colon kanan
 - Jika BAB feses padat atau konstipasi pada keganasan colon kiri
 - BAB lewat colostomy permanent atau sementara
 - Perawatan Colostomy mandiri atau tergantung
 - Colostomy kanan, feses yang keluar bubur atau semi bubur.
 - Colostomy kiri, feses yang keluar lebih padat.
- d. POLA AKTIVITAS DAN LATIHAN
 - Klien jarang memiliki waktu untuk olahraga
 - Klien sering mengeluh cepat capek
- e. POLA ISTIRAHAT DAN TIDUR
 - Klien sering terganggu tidurnya karena merasakan nyeri pada daerah abdomen, umbilicus atau rectum
 - Klien cemas memikirkan sakitnya sehingga susah tidur/insomnia
- f. POLA PERSEPSI KOGNITIF
 - Klien sering merasa nyeri pada daerah abdomen, umbilicus atau rectum
 - Klien sering merasa perut kembung atau distensi
- g. POLA PERSEPSI DAN KONSEP DIRI
 - Klien merasa minder dengan penyakit yang dideritanya.
 - Klien merasa diri tidak berguna
- h. POLA PERAN DAN HUBUNGAN DENGAN SESAMA
 - Klien tidak mampu melaksanakan tugas/pekerjaannya karena sakitnya
 - Klien menolak untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang lain
- i. POLA REPRODUKSI SEKSUALITAS
 - Klien merasa takut untuk berhubungan seksual, terutama setelah pemasangan colostomy.

- Klien merasa tidak nyaman/sungkan/malu dengan pasangan karena pemasangan colostomy sehingga malas untuk berhubungan
 - Cepat capek dan lelah untuk berhubungan seksual
 - j. POLA MEKANISME KOPING DAN TOLERANSI TERHADAP STRESS
 - Klien merasa cemas dengan penyakitnya dan didiagnosa cancer
 - Klien merasa tertekan karena sakitnya sehingga mudah marah, sedih, dll
 - k. POLA SISTEM KEPERCAYAAN
 - Klien merasa bahwa keadaan sakitnya adalah cobaan Tuhan yang harus dijalani dan diterima dengan ikhlas
 - Klien merasa Tuhan menghukum dia dengan sakit yang dideritanya
 - Klien memerlukan pemuka agama untuk bimbingan iman atau spiritual
2. Diagnosa Keperawatan
- I. PRE OPERASI
- a. Gangguan eliminasi feses: diare b.d keganasan pada colorectal
 - b. Gangguan eliminasi feses: konstipasi b.d keganasan pada colorectal
 - c. Resiko deficit cairan b.d mual, muntah dan anoreksia
 - d. Nutrisi kurang dari kebutuhan b.d intake nutrisi yang kurang dan pertumbuhan massa pada tubuh
 - e. Cemas b.d diagnosa cancer
- II. POST OPERASI
- a. Resti infeksi b.d luka terbuka pada abdomen (colostomy)
 - b. Resti gangguan integritas kulit b.d pemasangan colostomy
 - c. Gangguan body image b.d pemasangan colostomy
 - d. Perubahan peran b.d proses penyakitnya
3. Perencanaan Keperawatan
- a. Pre Operasi
- 1) Gangguan eliminasi feses: **diare** b.d keganasan pada colorectal
- Tujuan: Setelah dilakukan Tindakan keperawatan klien BAB secara normal
- Kriteria Hasil :
- BAB 1 kali per hari
 - Konsistensi Faeses padat
 - Palpasi abdomen supel
 - Bising usus normal 5-35 kali per menit
- Intervensi:
- Identifikasi penyebab diare

- Monitor warna, konsistensi dan volume feses
- Monitor tanda-tanda hypovolemia
- Monitor iritasi kulit di perianal

Terapeutik:

- Berikan asupan cairan oral yang cukup
- Berikan cairan oralit atau cairan gula garam

Edukasi:

- Anjurkan minum setiap kali habis buang air

Kolaborasi:

- Kolaborasi pemberian obat anti diare jika perlu
- Kolaborasi pemberian cairan intravena

2) Gangguan eliminasi feses: konstipasi b.d keganasan pada colorectal

Tujuan:

Setelah dilakukan Tindakan keperawatan klien bisa BAB secara normal

Kriteria Hasil:

- BAB 1 kali sehari
- Palpasi abdomen supel
- Peristaltik usus 5 -35 kali per menit

Intervensi :

- Periksa tanda dan gejala konstipasi
- Periksa pergerakan usus, karakteristik feses (konsistensi, bentuk, volume, dan warna)
- Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Obat- obatan, tiring baring, diet rendah serat)

Terapeutik:

- Anjurkan diet tinggi serat
- Lakukan massa abdomen
- Lakukan evakuasi feses secara manual, jika perlu
- Berikan enema atau irigasi, jika perlu

Edukasi:

- Jelaskan etiologi masalah, alasan tindakan
- Anjurkan peningkatan asupan cairan, jika tidak ada kontra-indikasi
- Latih buang air besar secara teratur
- Ajarkan cara mengatasi konstipasi /impaksi

Kolaborasi:

- Konsultasi dengan tim medis tentang penurunan/peningkatan frekuensi suara usus
- Kolaborasi penggunaan obat pencahar, jika perlu

3) Nausea b.d Efek agen farmakologis

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat nausea dapat menurun.

Kriteria Hasil :

- Nafsu makan meningkat
- Keluhan mual menurun
- Perasaan ingin muntah menurun
- Pucat tampak membaik

Intervensi Manajemen Mual (I.03117):

Observasi :

- Identifikasi faktor penyebab mual
- Identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup
- Monitor mual

Terapeutik :

- Kontrol faktor lingkungan penyebab mual
- Berikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik

Edukasi :

- Anjurkan istirahat dan tidur yang cukup
- Ajarkan penggunaan teknik non farmakologis untuk mengatasi mual

Kolaborasi :

- Kolaborasi pemberian antiemetik, jika perlu

4) Resiko deficit nutrisi b.d intake nutrisi yang kurang dan pertumbuhan massa pada tubuh

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan nutrisi pasien meningkat

Kriteria hasil : makan membaik

Intervensi Manajemen Nutrisi :

- Identifikasi status nutrisi
- Identifikasi alergi atau intoleran makanan
- Identifikasi makanan yang disukai
- Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi

Terapeutik :

- Fasilitasi menentukan pedoman diet
- Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
- Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- Berikan suplemen makanan, jika perlu
- Ajarkan diet yang diprogramkan

Kolaborasi :

- Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (misal. Pereda nyeri, anti-emetik)
- Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu

5) Ansietas (Cemas) b.d diagnosa cancer

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat ansietas pasien menurun.

Kriteria Hasil :

- Verbalisasi kebingungan menurun
- Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi
- Perilaku gelisah menurun
- Perilaku tegang menurun
- Frekuensi pernapasan, nadi dan tekanan darah menurun

Intervensi Reduksi Ansietas :

Observasi :

- Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (misal kondisi, waktu, stressor)
- Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal)

Terapeutik :

- Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
- Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
- Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan

Edukasi :

- Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
- Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, jika perlu
- Latih teknik relaksasi

Kolaborasi :

Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

b. Post Operasi

1) Resti infeksi b.d luka terbuka pada abdomen (*colostomy*)

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan risiko infeksi dapat menurun.

Kriteria Hasil :

- Demam menurun
- Kemerahan menurun
- Nyeri menurun
- Bengkak menurun

Intervensi Pencegahan Infeksi (I.14539):

Observasi :

- Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan local

Terapeutik :

- Batasi jumlah pengunjung
- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien

Edukasi :

- Jelaskan tanda dan gejala infeksi
- Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar

Kolaborasi :

- Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu

2) Resti gangguan integritas kulit b.d pemasangan *colostomi*

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan risiko gangguan integritas kulit menurun.

Kriteria Hasil :

- Elastisitas meningkat
- Hidrasi meningkat
- Kerusakan jaringan menurun
- Kerusakan lapisan kulit menurun

Intervensi perawatan integritas kulit (I.11353):

Observasi :

- Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit

Terapeutik :

- Gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitive
- Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering

Edukasi :

- Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi

3) Gangguan citra tubuh b.d pemasangan *colostomy* (D.0083)

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan persepsi tentang penampilan pasien dapat meningkat.

Kriteria Hasil :

- Verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun
- Verbalisasi kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain
- Menyembunyikan bagian tubuh berlebihan menurun
- Respon nonverbal pada perubahan tubuh membaik
- Hubungan sosial membaik

Intervensi Promosi citra tubuh (I.09305):

Observasi :

- Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan
- Identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial
- Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri

Terapeutik :

- Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya
- Diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri
- Diskusikan cara mengembangkan harapan citra tubuh secara realistis
- Diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh

Edukasi :

- Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh
- Latih fungsi tubuh yang dimiliki
- Latih peningkatan penampilan diri

4) Penampilan peran tidak efektif b.d proses penyakitnya

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan penampilan peran membaik

Kriteria Hasil :

- Verbalisasi harapan terpenuhi meningkat
- Verbalisasi kepuasan peran meningkat
- Verbalisasi keluasaan peran meningkat
- Adaptasi peran meningkat
- Strategi koping yang efektif meningkat
- Verbalisasi perasaan bingung menjalankan peran menurun
- Konflik peran menurun

Observasi :

- Identifikasi berbagai peran dan periode transisi sesuai tingkat perkembangan
- Identifikasi peran yang ada dalam keluarga
- Identifikasi adanya peran yang tidak terpenuhi

Terapeutik :

- Fasilitasi adaptasi peran keluarga terhadap perubahan peran yang tidak diinginkan
- Fasilitasi bermain peran dalam mengantisipasi reaksi orang lain terhadap perilaku
- Fasilitasi diskusi perubahan peran anak terhadap bayi baru lahir, jika perlu

- Fasilitasi diskusi tentang peran orang tua, jika perlu
- Fasilitasi diskusi tentang adaptasi peran saat anak meninggalkan rumah, jika perlu
- Fasilitasi diskusi harapan dengan keluarga dan peran timbal balik

Edukasi :

- Diskusikan perilaku yang dibutuhkan untuk pengembangan peran
- Diskusikan perubahan peran yang diperlukan akibat penyakit atau ketidakmampuan
- Diskusikan perubahan peran dalam menerima ketergantungan orang tua
- Diskusikan strategi positif untuk mengelola perubahan peran
- Ajarkan perilaku baru yang dibutuhkan oleh pasien/orang tua untuk memenuhi peran

Kolaborasi :

- Rujuk dalam kelompok untuk mempelajari peran baru

4. Implementasi

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Potter & Perry, 2011).

Komponen tahap implementasi:

- Tindakan keperawatan mandiri
- Tindakan keperawatan kolaboratif
- Dokumentasi tindakan keperawatan dan respon klien terhadap asuhan keperawatan.

5. Evaluasi

Evaluasi yaitu penilaian hasil dan proses. Penilaian hasil menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Penilaian proses menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahapan proses mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri (Ali, 2009). Evaluasi adalah membandingkan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai (Dinarti & Yuli Muryanti, 2017). Evaluasi disusun menggunakan SOAP yaitu (Suprajitno dalam Wardani, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

- deWit&Kumagai (2013), Medical Surgical Nursing, Concept & Practice, Second Edition, Elsevier, USA.
- Dinar, dr. A. (2017). Telapak tangan dan kaki kebas setelah kemoterapi.
- Dinarti & Yuli Muryanti. (2017). Bahan Ajar Keperawatan: Dokumentasi Keperawatan. 1–172.
- Ignatavicius & Workman (2006), Medical Surgical Nursing, Critical Thinking for Collaborative Care, Volume I, Saunders, Elsevier.
- Perry dan Potter, 2011
- Price Sylvia, Patofisiologi
- Medical Surgical Nursing, Lewis et al, 2011.
- National Cancer Institute. (2015). Kemoterapi dan Anda.
- Timurtini, S. (2019). Komplikasi Kanker Kolon.
- PPNI Pusat (2019). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI Pusat (2019). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI Pusat (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), Jakarta: DPP PPNI.
- Yusra, D. F. (2018). Efek Samping Kemoterapi Pada Pasien Kanker

SINOPSIS

Buku ini berisi tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan akibat gastritis, appendiksitis, diare, hepatitis, Kolelitiasis dan ca kolorectal.

Pada klien yang mengalami gastritis pengkajian keperawatan berfokus pada data riwayat pola makan, tanda dan gejala yang dirasakan nyeri uluhati/epigastium, tidak selera makan (anoreksia), mual, atau muntah yang dapat muncul sebelum atau setelah makan, dan apa yang dilakukan pasien untuk menghilangkan atau mengurangi gejala tersebut. Masalah keperawatan yang lazim ditemukan pada klien gastritis adalah Nyeri (akut) berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung; Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan output cair yang berlebih (mual dan muntah); Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi tidak adekuat; Intoleransi aktifitas berhubungan dengan kelemahan fisik; Ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit; Kurang pengetahuan tentang penatalaksanaan diet dan proses penyakit.

Asuhan keperawatan pada klien appendiksitis dapat dilakukan sebelum dan sesudah operasi. Masalah keperawatan yang mungkin muncul selama pre operasi diantaranya nyeri akut, hipertermi, risiko hypovolemia, deficit nutrisi. Selama periode post operasi masalah keperawatan yang dapat timbul diantaranya nyeri akut, resiko hypovolemia, resiko infeksi, dan gangguan mobilitas fisik. Upaya promotive dan preventif dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan masyarakat mengenai penyakit appendiksitis yang meliputi: pengertian, tanda dan gejala, penyebab, komplikasi dan penanganannya, edukasi tentang pencegahan *apendiksitis* yaitu dengan menjaga kebersihan makanan dan makan-makanan tinggi serat. Upaya kurative dapat dilakukan dengan melakukan perawatan luka pada pasien yang telah dilakukan operasi agar tidak terjadi infeksi dan memberikan perawatan dengan mengurangi nyeri. Upaya rehabilitatif dapat dilakukan dengan cara tetap menjaga pola makan, makan makanan tinggi serat, makan TKTTP dan melakukan perawatan luka, menjaga luka tetap bersih dan kering.

Diare dapat terjadi pada anak dewasa dengan berbagai penyebab seperti infeksi bakteri, virus dan parasit. Data subyektif yang harus didapatkan dari klien diare difokuskan pada riwayat pola buang air besar dan keluhan yang menyertai, misalnya bagaimana frekuensi, durasi, buang air besar, konsistensi feses. Data objektif dari hasil pemeriksaan fisik dengan tehnik inspeksi berfokus pada tanda dehidrasi seperti keadaan umum lemah, mata cekung, hidrasi kulit kering, volume urin sedikit dan warna urin kuning pekat. Masalah keperawatan yang ditemui antara lain, Diare, Resiko Hipovolemia,

Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif. Keberhasilan masalah diare dapat diamati dari luaran utamanya adalah eliminasi fecal Kembali normal seperti frekuensi satu kali sehari, konsistensi feses padat. Untuk masalah hypovolemia yang dialami klien diare keberhasilan tindakan keperawatan dapat dinilai dari perbaikan termoregulasi seperti tekanan darah, denyut nadi radial, membrane mukosa, turgor kulit menjadi lebih baik.

Keluhan utama pada klien Hepatitis dapat berupa nyeri pada abdomen kuadran kanan atas. Keluhan tersebut dapat disertai nafsu makan menurun, mual, muntah, lemah, demam, perubahan defekasi atau warna feses, nyeri otot atau sendi, keletihan, perubahan warna sklera atau kulit. Masalah keperawatan yang lazim ditemui yaitu Defisit Nutrisi/Resiko Defisit Nutrisi, Nyeri Kronis, Intoleransi Aktivitas, Resiko Infeksi (transmisi). Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan antara lain mengobservasi status nutrisi dan skala nyeri, memberikan tehnik relaksasi nafas dalam atau tehnik distraksi, memberi edukasi tentang diet Hati yang diprogramkan, dan kolaborasi pemberian terapi oral atau parenteral. Evaluasi yang diharapkan pada pasien dengan hepatitis yaitu didapatkan nutrisi yang adekuat untuk fungsi imun dan penyembuhan pasien yang mengalami hepatitis kronik maupun akut, keluhan nyeri pada pasien berkurang atau hilang ditandai dengan adanya indicator penurunan skala nyeri, dan TTV normal, untuk intoleransi aktivitas diharapkan periode istirahat adekuat dan adanya pembatasan aktivitas kebutuhan sehari-hari pasien dapat teratasi, dan resiko infeksi / penyebaran infeksi tidak terjadi.

Klien yang mengalami Kolelitiasis akan mengeluh nyeri pada abdomen kanan atas yang dapat menjalar ke punggung dan bahu kanan disertai dengan mual dan muntah, dan akan merubah posisinya secara terus-menerus untuk mengurangi intensitas nyeri. Pada pemeriksaan fisik secara inspeksi dapat ditemukan Icterus di seluruh tubuh, terutama disklera sebagai reson peningkatan bilirubin dalam darah. Pada gastrointestinal bias didapatkan regurgitasi ulang dan flatunasi. Urin gelap/ coklat. Feces seperti tanah liat, skatore. Masalah keperawatan yang dapat terjadi antara lain Nyeri akut, Defisit Nutrisi, Risiko ketidakseimbangan cairan, Hipertermi, Intoleransi aktivitas, Ansietas, Kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan kurangnya informasi yang didapatkan. Implementasi Keperawatan yang dilakukan meliputi tindakan mandiri seperti mengkaji status nutri dan nyeri, melakukan manajemen nyeri dan Kolaborasi dengan medis: Pemakaian penghambat H2 (seperti cimetidine/ ranitidin).

Penyebab pasti Ca Kolorektal sampai saat ini belum diketahui, namun sering dikaitkan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang TINGGI LEMAK dan RENDAH SERAT. Hasil pengkajian pada klien Ca kolorektal didapatkan data **Tenesmus**, yaitu rasa tidak tuntas setelah buang air besar atau rasa ingin buang air besar Kembali, Faeses bercampur darah, Feses berbentuk pita/pipih, jika keganasan di daerah rectum dan

Teraba massa pada daerah abdomen. Penatalaksanaan medis Ca Kolorektal yaitu pembedahan, radiasi dan kemoterapi. Masalah keperawatan PRE OPERASI, antara lain, Gangguan eliminasi feses: diare b.d keganasan pada colorectal; Gangguan eliminasi feses: konstipasi b.d keganasan pada colorectal; Resiko deficit cairan b.d mual, muntah dan anoreksia; Nutrisi kurang dari kebutuhan b.d intake nutrisi yang kurang dan pertumbuhan massa pada tubuh; Cemas b.d diagnosa cancer. Masalah keperawatan POST OPERASI yaitu Resti infeksi b.d luka terbuka pada abdomen (colostomy); Resti gangguan integritas kulit b.d pemasangan colostomy; Gangguan body image b.d pemasangan colostomy; Perubahan peran b.d proses penyakitnya

Buku ini berisi tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan akibat gastritis, appendiksitis, diare, hepatitis, Kolelitiasis dan ca kolorektal.

Pada klien yang mengalami gastritis pengkajian keperawatan berfokus pada data riwayat pola makan, tanda dan gejala yang dirasakan nyeri uluhati/epigastrium, tidak selera makan (anoreksia), mual, atau muntah yang dapat muncul sebelum atau setelah makan, dan apa yang dilakukan pasien untuk menghilangkan atau mengurangi gejala tersebut. Masalah keperawatan yang lazim ditemukan pada klien gastritis adalah Nyeri (akut) berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung; Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan output cair yang berlebih (mual dan muntah); Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi tidak adekuat; Intoleransi aktifitas berhubungan dengan kelemahan fisik; Ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit;

Kurang pengetahuan tentang penatalaksanaan diet dan proses penyakit.

Asuhan keperawatan pada klien appendiksitis dapat dilakukan sebelum dan sesudah operasi. Masalah keperawatan yang mungkin muncul selama pre operasi diantaranya nyeri akut, hipertermi, risiko hypovolemia, deficit nutrisi. Selama periode post operasi masalah keperawatan yang dapat timbul diantaranya nyeri akut, resiko hypovolemia, resiko infeksi, dan gangguan mobilitas fisik. Upaya promotive dan preventif dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan masyarakat mengenai penyakit appendiksitis yang meliputi: pengertian, tanda dan gejala, penyebab, komplikasi dan penanganannya, edukasi tentang pencegahan apendiksitis yaitu dengan menjaga kebersihan makanan dan makan-makanan tinggi serat. Upaya kurative dapat dilakukan dengan melakukan perawatan luka pada pasien yang telah dilakukan operasi agar tidak terjadi infeksi dan memberikan perawatan dengan mengurangi nyeri. Upaya rehabilitatif dapat dilakukan dengan cara tetap menjaga pola makan, makan makanan tinggi serat, makan TKT dan melakukan perawatan luka, menjaga luka tetap bersih dan kering.

Diare dapat terjadi pada anak dewasa dengan berbagai penyebab seperti infeksi bakteri, virus dan parasit.

Data subyektif yang harus didapatkan dari klien diare difokuskan pada riwayat pola buang air besar dan keluhan yang menyertai, misalnya bagaimana frekuensi, durasi, buang air besar, konsistensi feses. Data objektif dari hasil pemeriksaan fisik dengan tehnik inspeksi berfokus pada tanda dehidrasi seperti keadaan umum lemah, mata cekung, hidrasi kulit kering, volume urin sedikit dan warna urin kuning pekat. Masalah keperawatan yang ditemui antara lain, Diare, Resiko Hipovolemia, Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif.

Keberhasilan masalah diare dapat diamati dari luaran utamanya adalah eliminasi fecal Kembali normal seperti frekuensi satu kali sehari, konsistensi feses padat. Untuk masalah hypovolemia yang dialami klien diare keberhasilan tindakan keperawatan dapat dinilai dari perbaikan termoregulasi seperti tekanan darah, denyut nadi radial, membrane mukosa, turgor kulit menjadi lebih baik.

Keluhan utama pada klien Hepatitis dapat berupa nyeri pada abdomen kuadran kanan atas. Keluhan tersebut dapat disertai nafsu makan menurun, mual, muntah, lemah, demam, perubahan defekasi atau warna feses, nyeri otot atau sendi, kelelahan, perubahan warna sklera atau kulit. Masalah keperawatan yang lazim ditemui yaitu Defisit Nutrisi/Resiko Defisit Nutrisi, Nyeri Kronis, Intoleransi Aktifitas, Resiko Infeksi (transmisi). Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan antara lain mengobservasi status nutrisi dan skala nyeri, memberikan tehnik relaksasi nafas dalam atau tehnik distraksi, memberi edukasi tentang diet Hati yang diprogramkan, dan kolaborasi pemberian terapi oral atau parenteral. Evaluasi yang diharapkan pada pasien dengan hepatitis yaitu didapatkan nutrisi yang adekuat untuk fungsi imun dan penyembuhan pasien yang mengalami hepatitis kronik maupun akut, keluhan nyeri pada pasien berkurang atau hilang ditandai dengan adanya indikator penurunan skala nyeri, dan TTV normal, untuk intoleransi aktifitas diharapkan periode istirahat adekuat dan adanya pembatasan aktifitas kebutuhan sehari-hari pasien dapat teratasi, dan resiko infeksi / penyebaran infeksi tidak terjadi.

Klien yang mengalami Kolelitiasis akan mengeluh nyeri pada abdomen kanan atas yang dapat menjalar ke punggung dan bahu kanan disertai dengan mual dan muntah, dan akan merubah posisinya secara terus-menerus untuk mengurangi intensitas nyeri. Pada pemeriksaan fisik secara inspeksi dapat ditemukan Icterus di seluruh tubuh, terutama disklera sebagai reson peningkatan bilirubin dalam darah. Pada gastrointestinal bias didapatkan regurgitasi ulang dan flatulasi. Urin gelap/ coklat. Feces seperti tanah liat, skatone. Masalah keperawatan yang dapat terjadi antara lain Nyeri akut, Defisit Nutrisi, Risiko ketidakseimbangan cairan, Hipertermi, Intoleransi aktifitas, Ansietas, Kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan kurangnya informasi yang didapatkan. Implementasi Keperawatan yang dilakukan meliputi tindakan mandiri seperti mengkaji status nutri dan nyeri, melakukan manajemen nyeri dan Kolaborasi dengan medis: Pemakaian penghambat H2 (seperti cimetidine/ ranitidin).

Penyebab pasti Ca Kolorektal sampai saat ini belum diketahui, namun sering dikaitkan dengan kebiasaan mengonsumsi makanan yang TINGGI LEMAK dan RENDAH SERAT. Hasil pengkajian pada klien Ca kolorektal didapatkan data Tenesmus, yaitu rasa tidak tuntas setelah buang air besar atau rasa ingin buang air besar Kembali, Faeces bercampur darah, Feses berbentuk pita/pipih, jika keganasan di daerah rectum dan Teraba massa pada daerah abdomen. Penatalaksanaan medis Ca Kolorektal yaitu pembedahan, radiasi dan kemoterapi. Masalah keperawatan PRE OPERASI, antara lain, Gangguan eliminasi feses: diare b.d keganasan pada colorectal; Gangguan eliminasi feses: konstipasi b.d keganasan pada colorectal; Resiko deficit cairan b.d mual, muntah dan anoreksia; Nutrisi kurang dari kebutuhan b.d intake nutrisi yang kurang dan pertumbuhan massa pada tubuh; Cemas b.d diagnosa cancer. Masalah keperawatan POST OPERASI yaitu Resti infeksi b.d luka terbuka pada abdomen (colostomy); Resti gangguan integritas kulit b.d pemasangan colostomy; Gangguan body image b.d pemasangan colostomy; Perubahan peran b.d proses penyakitnya